

CHAPITRE

06

Éthique et déontologie en santé publique

Valeurs | Principes | Secret | Données | Image

DANS CE VOLUME

- ✓ Cours structuré
- ✓ Schémas en couleur
- ✓ Auto-tests corrigés
- ✓ Fil rouge des Tilleuls

Sommaire

6.1 Compétences mobilisées 3
6.2 Croisement référentiel × précisions × indications 3
6.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025 4
6.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED 4
6.3 Cours 5
6.3.1 Morale, éthique, déontologie, droit 5
6.3.2 Les principes éthiques 9
6.3.3 Le cadre professionnel du diététicien 17
6.3.4 Le secret professionnel et la confidentialité 21
6.3.5 La protection des données personnelles (RGPD) 25
6.3.6 Le consentement et le droit à l'image 31
6.3.7 Les conflits d'intérêts 35
6.3.8 Une démarche de réflexion éthique 38
6.3.9 Les droits des usagers et la démocratie en santé 42
6.3.10 La responsabilité du professionnel dans une action collective 47
6.3.11 Publicité, allégations et compléments alimentaires : repères pour une information loyale 51
6.3.12 Enquêtes, recherche et protection des personnes 56
6.3.13 Identité numérique et e-réputation du professionnel 60
6.3.14 Cinq dilemmes éthiques commentés 62
6.3.15 Laïcité et neutralité dans les actions de santé publique 65
6.3.16 Fil rouge : les choix éthiques d'Inès 67
6.3.17 Cas guidé : repérer la dénutrition des seniors à domicile 67
6.4 Approfondissements 69
6.4.1 Le diététicien sur les réseaux sociaux 69
6.4.2 Les partenariats public-privé en nutrition 70
6.4.3 La participation des personnes : une exigence éthique 72
6.4.4 Éthique et intelligence artificielle en santé 73
6.4.5 Le consentement des personnes vulnérables 74
6.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3 76
6.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles 77
Méthodes pour l'épreuve E5 : réussir les questions d'éthique 78
Méthode 5 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve 79
Méthode 6 – Relier l'éthique aux autres chapitres du cours 80
Méthode 7 – Savoir à qui s'adresser : les autorités et leurs rôles 81
6.7 L'essentiel à retenir 82
6.8 Entraînement 83
6.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses) 83
6.8.2 Exercices 85
6.8.3 Questions de réflexion 88
6.8.4 Étude de cas 89
6.8.5 Mises en situation express 89
6.8.6 Exercices complémentaires 92
6.9 Glossaire 93
6.10 Renvois bibliographiques par notion 94
6.12 Bibliographie numérotée 94

Objectifs du chapitre (référentiel)

À la fin de ce chapitre, vous devez être capable de :

- distinguer morale, éthique, déontologie et droit ;
- mobiliser les principes éthiques (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice) et ceux propres à la santé publique (proportionnalité, moindre contrainte, équité, transparence) ;
- situer une action sur l'échelle d'intervention et en discuter la légitimité (information, nudge, incitation, réglementation) ;
- connaître le cadre professionnel du diététicien (Code de la santé publique, code de déontologie) ;
- respecter le secret professionnel et le partage d'informations dans une action collective ;
- appliquer le RGPD à un questionnaire, à un fichier de participants ou à une évaluation ;
- recueillir un consentement et une autorisation de droit à l'image, y compris pour des mineurs ;
- repérer et gérer un conflit d'intérêts (partenariats, sponsors, industrie agroalimentaire) ;
- conduire une démarche de réflexion éthique face à un dilemme de terrain.

6.1 Compétences mobilisées

Compétence	Ce que le chapitre apporte	Indicateurs du référentiel travaillés
C3.1	Conduire un projet dans le respect des obligations éthiques, juridiques et déontologiques	Règles éthiques, juridiques et déontologiques respectées
C3.2	Animer des ateliers respectueux (confidentialité, non-stigmatisation, allergènes, neutralité)	Méthodes d'animation appropriées ; hygiène et sécurité respectées
C3.3	Recueillir et traiter des données de santé (questionnaires, enquêtes) conformément au RGPD	Règles de déontologie et d'éthique prises en compte ; principes éthiques du traitement des données numériques en santé maîtrisés
C3.5	Communiquer dans le respect du droit à l'image, de l'e-réputation et du secret	Réglementation (RGPD, droit à l'image) ; enjeux de l'e-réputation pris en compte ; posture adaptée
C3.6	Protéger les fichiers et les données personnelles	Environnement numérique géré et sécurisé

6.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Éthique, morale, déontologie, droit	Définir et distinguer	Pas de cours de philosophie ; exemples professionnels
Principes éthiques	Mobiliser les 4 principes dans une situation	Beauchamp et Childress ; éthique de santé publique
Cadre de la profession	Citer les textes essentiels	Code de la santé publique (L. 4371-1 et suivants) ; code de déontologie
Secret professionnel, confidentialité	Appliquer en action collective	L. 1110-4 CSP ; article 226-13 du Code pénal
Protection des données	Appliquer les principes du RGPD	Règlement (UE) 2016/679 ; CNIL ; anonymat
Droit à l'image, consentement	Rédiger une autorisation	Article 9 du Code civil ; mineurs
Conflits d'intérêts	Repérer, déclarer, gérer	Partenariats avec l'industrie ; transparence

Notion (guide 2025)	Objectifs pour l'apprenant	Limites et attendus
Démarche de réflexion éthique	Analyser un dilemme et justifier une décision	Grille d'analyse

6.2.1 Contrôle de conformité avec le référentiel 2024 et le guide 2025

Le chapitre a été vérifié par rapport au référentiel du BTS (arrêté publié au *Journal officiel* du 17 décembre 2024 : bloc 3, savoirs « Éthique et déontologie ») et au guide d'accompagnement pédagogique de 2025 (p. 61). Les dates et les textes ont été comparés à la dernière version en vigueur au 26 octobre 2026 ; les mises à jour sont signalées dans l'encadré « Attention » de la section 6.2.2.

Texte	Critère ou indication	Où dans ce cours
Guide 2025, p. 61	Posture professionnelle : savoir-être	6.3.2 (la posture professionnelle) ; 6.3.10 ; 6.3.14
Guide 2025, p. 61	Règles d'éthique : équité, justice sociale, bienveillance, autonomie individuelle et de groupe	6.3.2 (principes éthiques et tableau des quatre valeurs) ; 6.3.8 (démarche de réflexion éthique)
Guide 2025, p. 61	Code de déontologie : principes et valeurs	6.3.3 (cadre professionnel, charte de l'AFDN) ; 6.3.4 (secret) ; 6.3.7 (conflits d'intérêts)
Référentiel, C3.1	Règles éthiques, juridiques et déontologiques respectées dans le projet	6.3.5, 6.3.6, 6.3.9, 6.3.12 ; 6.6
Référentiel, C3.5	Communication respectant le droit à l'image, l'e-réputation et le secret	6.3.6 ; 6.3.11 ; 6.3.13 ; 6.4.1

6.2.2 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié par rapport au fascicule *Environnement professionnel – Les essentiels*, 2e année (CNED 3-6124-AN-WT-00-21, © 2022), module 1, séquence 2 « Outils, ressources et méthodologies en santé publique » (p. 11) et séquence 6 « Démocratie sanitaire : droits des usagers et patients » (p. 22 à 24). La séquence 7 « Santé et numérique » est traitée au chapitre 20.

Module CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
Essentiels M1 S2 §2 (p. 11)	Cadre d'un projet sanitaire : Code de la santé publique, règles, textes de référence, recommandations, codes de déontologie, éthique, secret professionnel	6.3.1 (morale, éthique, déontologie, droit) ; 6.3.3 ; 6.3.4
Essentiels M1 S6 §1 (p. 22)	Démocratie sanitaire : loi du 4 mars 2002, loi du 26 janvier 2016	6.3.9 (grands textes, définition de la démocratie en santé)
Essentiels M1 S6 §2.1 et §2.2 (p. 22 et 23)	Droits fondamentaux ; droits collectifs et individuels (droit à l'oubli, action de groupe, information, consentement, accès au dossier, secret)	6.3.4 ; 6.3.6 ; 6.3.9 (droit à l'oubli et action de groupe)
Essentiels M1 S6 §2.3 (p. 23 et 24)	Outils de la loi du 2 janvier 2002 (charte, document individuel, personne qualifiée, CVS, règlement de fonctionnement, projet d'établissement) ; loi HPST	6.3.9 (loi du 2 janvier 2002, CVS ; loi HPST) ; 6.3.10

Attention – corrections apportées aux documents sources – Ce qui a changé ou était inexact

- **Droit à l'oubli** (p. 23) : le délai de « dix ans » est dépassé. Depuis la loi du 28 février 2022 (applicable au 1er juin 2022), il est de **5 ans** après la fin du protocole thérapeutique, pour les cancers et l'hépatite C.

- **Action de groupe** (p. 23) : le régime de 2016 a été remplacé par un régime unique (loi du 30 avril 2025, pour les actions introduites depuis le 2 mai 2025).
- **Loi « HSPT »** (p. 24) : il s'agit de la loi **HPST** (« Hôpital, patients, santé et territoires ») du 21 juillet 2009, publiée au *Journal officiel* du 22 juillet 2009.
- **Code de déontologie** (p. 11) : pour les diététiciens, il n'existe pas de code publié par décret ni d'ordre professionnel ; le texte de référence est la charte de déontologie de l'AFDN (2018).
- **Consentement et données** (p. 27, séquence 7) : le fascicule a raison de distinguer le consentement aux soins et la base légale du traitement des données ; en action collective (enquête, atelier), le traitement repose le plus souvent sur une autre base que le consentement, mais l'information des personnes reste obligatoire (chapitre 6.3.5).

6.3 Cours

NIVEAU BTS – EXIGIBLE

État de la veille – État de la veille au 26 octobre 2026

- **Code de déontologie** : le texte de l'AFDN en ligne en octobre 2026 est la « Charte de déontologie du diététicien-nutritionniste » du 1er janvier 2018 ; il n'existe pas de code réglementaire publié par décret pour les diététiciens.
- **Données personnelles** : le RGPD (règlement (UE) 2016/679) s'applique depuis le 25 mai 2018 ; les guides pratiques et les méthodologies de référence de la CNIL sont régulièrement mis à jour (*cnil.fr*).
- **Intelligence artificielle** : le règlement (UE) 2024/1689 s'applique par étapes (interdictions depuis le 2 février 2025, obligations de transparence depuis le 2 août 2026) ; le règlement « omnibus » (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026 a reporté les obligations des systèmes à haut risque au 2 décembre 2027 et au 2 août 2028.
- **Influence commerciale** : la loi du 9 juin 2023 encadre l'activité des influenceurs ; elle a été modifiée par une ordonnance du 6 novembre 2024 pour la rendre conforme au droit européen.

6.3.1 Morale, éthique, déontologie, droit

Module · Référentiel et guide : voir 6.2.1 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 11)

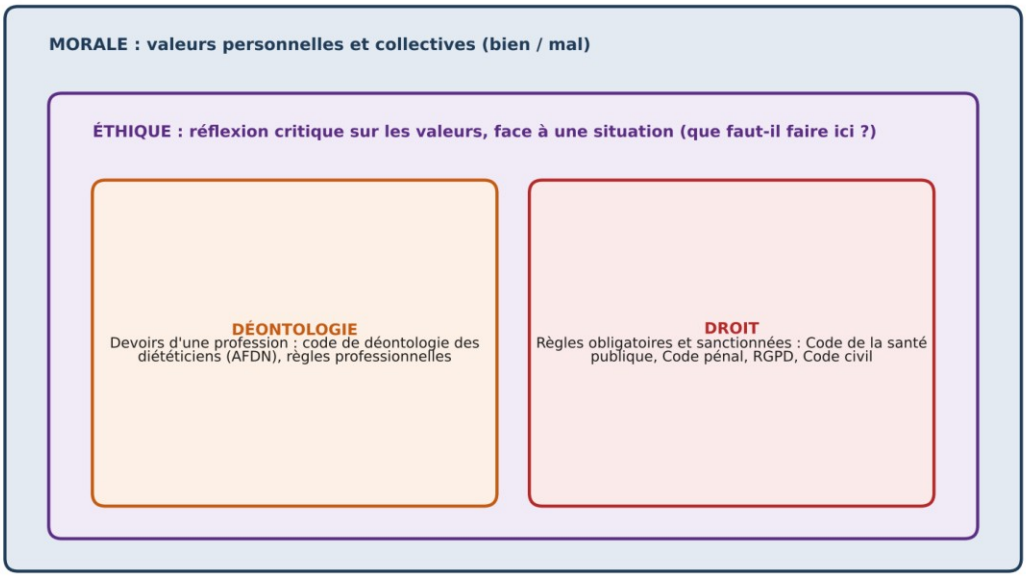


Figure 6.1 – Morale, éthique, déontologie et droit

Comprendre le schéma – Figure 6.1

1. La **morale** désigne l'ensemble des valeurs et des normes qui distinguent le bien du mal, dans une société ou pour une personne ; elle est souvent vécue comme évidente.
2. L'**éthique** est une **réflexion critique** sur ces valeurs, à l'occasion d'une situation concrète : « Que faut-il faire ici, et pourquoi ? ». Elle intervient surtout quand plusieurs valeurs légitimes entrent en **tension** (respecter le choix d'une personne et la protéger).
3. La **déontologie** (du grec *deon*, « ce qu'il faut faire ») rassemble les **devoirs** d'une profession envers les personnes, les collègues et la société ; pour les diététiciens, elle est formalisée par un **code de déontologie** porté par l'association professionnelle (AFDN).
4. Le **droit** fixe des règles **obligatoires** et **sanctionnées** par l'État (Code de la santé publique, Code pénal, Code civil, RGPD).
5. Les quatre niveaux s'emboîtent : une conduite peut être légale mais discutable sur le plan éthique (une campagne culpabilisante), ou déontologiquement exigée au-delà de la loi (se former en continu).

Définition – Éthique (définition opérationnelle)

Démarche de **questionnement** et de **délibération** qui vise à déterminer, dans une situation donnée, la conduite la plus juste, en prenant en compte les valeurs en présence, les règles applicables et les conséquences pour les personnes concernées.

Trois grandes façons de raisonner en éthique

Face à une même situation, on peut raisonner de plusieurs manières. Connaître les trois grands courants de la philosophie morale aide à comprendre pourquoi deux professionnels de bonne foi n'arrivent pas toujours à la même conclusion, et à construire une argumentation plus solide.

Courant	Question posée	Auteurs de référence (dates)	Exemple en nutrition
Éthique des conséquences (conséquentialisme, utilitarisme)	Quelle action produit le plus de bien et le moins de mal pour l'ensemble des personnes concernées ?	Jeremy Bentham (1789), John Stuart Mill (*L'Utilitarisme*, 1861)	Une taxe sur les boissons sucrées est justifiée si elle réduit la consommation et les maladies dans la population, même si certains consommateurs la trouvent injuste.
Éthique du devoir (déontologisme)	Quelle règle dois-je respecter, quelles que soient les conséquences ?	Emmanuel Kant (*Fondements de la métaphysique des mœurs*, 1785)	On ne ment pas à un participant pour le motiver (« ce gâteau est sans sucre »), même si le mensonge pourrait l'aider à changer.
Éthique des vertus	Que ferait ici un professionnel prudent, honnête, juste et bienveillant ?	Aristote (*Éthique à Nicomaque*, IVe siècle av. J.-C.)	Le diététicien adapte son conseil avec tact et prudence, sans appliquer mécaniquement une règle.

Le **conséquentialisme** a l'avantage d'être tourné vers les résultats, ce qui correspond bien à la santé publique, qui raisonne sur des populations. Sa limite est qu'il peut justifier de sacrifier une minorité pour le bien du plus grand nombre (stigmatiser les personnes en situation d'obésité « pour faire peur » et faire baisser la prévalence).

Le **déontologisme** protège la dignité de chaque personne. La formule de Kant le résume : il faut toujours traiter l'humanité, en soi et en autrui, « comme une fin, et jamais simplement comme un moyen ». Sa limite est la rigidité : deux devoirs peuvent s'opposer (dire la vérité et protéger une personne fragile).

L'**éthique des vertus** s'intéresse à la personne qui agit plutôt qu'à la règle ou au résultat. Elle insiste sur la **prudence** (en grec *phronesis*), c'est-à-dire la capacité de juger ce qui convient dans une situation particulière. C'est la vertu que l'on attend d'un professionnel expérimenté.

Les quatre principes de Beauchamp et Childress (6.3.2) empruntent aux trois courants : la bienfaisance et la non-malfaisance regardent les conséquences, l'autonomie et la justice expriment des devoirs envers les personnes, et l'arbitrage entre principes demande de la prudence.

Exemple – Une même question, trois raisonnements

Situation : une cantine scolaire envisage de supprimer le ketchup et la mayonnaise, que les élèves réclament.

- **Raisonnement par les conséquences** : la mesure réduit la consommation de sucres et de matières grasses ajoutés, mais elle risque d'augmenter le gaspillage si les élèves mangent moins. On compare les deux effets à partir de données (pesées des restes avant et après).
- **Raisonnement par le devoir** : la collectivité a le devoir de servir des repas conformes aux recommandations ; elle a aussi le devoir de respecter les goûts des enfants et de les associer aux décisions qui les concernent.
- **Raisonnement par les vertus** : un professionnel prudent cherche une solution mesurée, par exemple une sauce maison au yaourt et aux herbes, des sauces proposées une fois par semaine, et une explication donnée aux élèves.

Conclusion : les trois raisonnements se complètent. Une décision solide les combine.

Attention – Ne pas confondre éthique et opinion personnelle

Dire « je trouve que » ne suffit pas à faire une réflexion éthique. Une argumentation éthique s'appuie sur des **principes nommés**, sur des **faits vérifiés** et sur les **conséquences** pour chaque personne concernée. À l'épreuve E5, le jury attend une argumentation, pas un avis.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.1

Un centre de loisirs veut afficher dans le réfectoire le poids de chaque enfant pour « motiver les familles ». Pour chacun des trois courants (conséquences, devoir, vertus), rédigez une phrase qui montre pourquoi le projet pose problème.

Corrigé

Conséquences : l'affichage risque de provoquer moqueries, honte, restriction alimentaire et troubles du comportement alimentaire, sans preuve d'efficacité ; le bilan attendu est négatif. **Devoir** : l'enfant serait utilisé comme un moyen de pression sur sa famille, au mépris de sa dignité et de sa vie privée ; c'est aussi une donnée de santé diffusée sans base légale. **Vertus** : un professionnel bienveillant et prudent ne pèserait jamais un enfant en public et chercherait à améliorer l'environnement (repas, activité) plutôt qu'à désigner les enfants.

Repères historiques : comment l'éthique en santé s'est construite

L'éthique de la santé est née en grande partie de **scandales**. Connaître ces dates aide à comprendre pourquoi les règles actuelles sur le consentement et la recherche sont si strictes.

Date	Texte ou événement	Ce qu'il apporte
Ve siècle av. J.-C.	Serment d'Hippocrate	Ne pas nuire, respecter le secret de ce que l'on voit et entend
1947	Code de Nuremberg, rédigé après le procès des médecins nazis	Le consentement volontaire de la personne est « absolument essentiel » à toute expérimentation
1948	Déclaration universelle des droits de l'homme	Dignité de toute personne ; droit à un niveau de vie suffisant, y compris l'alimentation (article 25)
1964	Déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale (révisée plusieurs fois, dernière version 2024)	Principes éthiques de la recherche médicale : protocole, avis d'un comité, consentement, intérêt de la personne avant celui de la science
1979	Rapport Belmont (États-Unis), publié après l'étude de Tuskegee	Trois principes pour la recherche : respect des personnes, bienfaisance, justice
1979	Beauchamp et Childress, *Principles of Biomedical Ethics*	Les quatre principes (6.3.2)
1983	Création du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) en France	Avis sur les questions éthiques posées par la biologie, la médecine et la santé
1988	Loi Huriet-Sérusclat	Premier cadre français des recherches biomédicales
2002	Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades	Information, consentement, accès au dossier (6.3.9)
2012	Loi Jardé, appliquée depuis novembre 2016	Cadre actuel des recherches impliquant la personne humaine (6.3.12)

L'étude de **Tuskegee** (Alabama, 1932-1972) a suivi des hommes noirs atteints de syphilis sans les informer de leur maladie et sans les soigner, même après la découverte de la pénicilline. Son arrêt en 1972, après sa révélation par la presse, a conduit au rapport Belmont.

En nutrition aussi, des expériences ont été menées sans consentement réel. Au Canada, des enfants autochtones de pensionnats ont été soumis, entre 1942 et 1952, à des expériences nutritionnelles en situation de sous-alimentation ; ces faits ont été documentés par l'historien Ian Mosby en 2013. Ces exemples rappellent que les personnes les plus **vulnérables** (enfants, personnes pauvres, minorités) sont les premières exposées aux abus, et que la protection doit être plus forte pour elles.

Lien diététique – Ce que l'histoire change pour votre pratique

Un questionnaire distribué en atelier n'a rien à voir avec ces expériences. Pourtant, les mêmes principes s'appliquent à petite échelle : informer, laisser libre de participer, ne pas exposer les personnes à un risque inutile, protéger les plus fragiles. Le **respect** de ces règles est ce qui rend la confiance possible entre le public et les professionnels.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.2

Associez chaque principe actuel à un événement historique qui l'explique : a) le consentement libre et éclairé ; b) l'avis d'un comité avant une recherche ; c) l'attention particulière aux personnes vulnérables.

Corrigé

a) Le Code de Nuremberg (1947), rédigé après les expériences menées dans les camps nazis. b) La Déclaration d'Helsinki (1964) et, en France, la loi Huriet-Sérusclat (1988) puis la loi Jardé (2012). c) L'étude de Tuskegee et les expériences nutritionnelles sur des enfants autochtones au Canada, qui visaient des personnes sans pouvoir de refus.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.1 – Morale, éthique, déontologie, droit

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre la morale et l'éthique ?
2. Pourquoi la déontologie peut-elle aller au-delà du droit ? Donnez un exemple.
3. Quel courant éthique juge une action d'après ses conséquences ? Citez un auteur.
4. Complétez la formule de Kant : traiter l'humanité « toujours comme une fin, et … ».
5. Quel texte de 1947 a fait du consentement volontaire une exigence absolue ?
6. Qu'est-ce que l'étude de Tuskegee a montré ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.1

1. La morale est un ensemble de valeurs et de normes souvent vécues comme évidentes ; l'éthique est une réflexion critique sur ces valeurs face à une situation concrète.
2. La déontologie fixe des devoirs propres à une profession, qui peuvent être plus exigeants que la loi : par exemple, se former en continu ou refuser une publicité qui serait légale.
3. Le conséquentialisme (utilitarisme) ; Jeremy Bentham ou John Stuart Mill.
4. « … jamais simplement comme un moyen ».
5. Le Code de Nuremberg.
6. Des personnes vulnérables ont été suivies sans être informées ni soignées : la recherche ne doit jamais passer avant l'intérêt des personnes, et les plus fragiles doivent être protégées.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.2.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des courants éthiques et des repères historiques.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.1 et je refais les exercices d'application.

6.3.2 Les principes éthiques

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

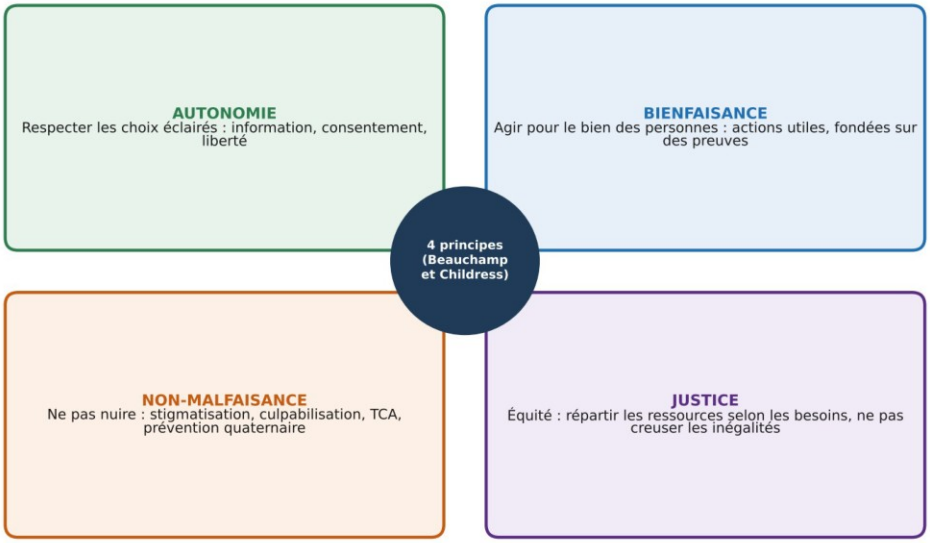


Figure 6.2 – Les quatre principes de l'éthique biomédicale

Comprendre le schéma – Figure 6.2

1. Autonomie : respecter la capacité des personnes à décider pour elles-mêmes, ce qui suppose une **information** claire (chapitre 5) et un **consentement** libre ; en santé publique, cela signifie ne pas imposer, ne pas manipuler, laisser le choix de participer.

2. Bienfaisance : agir pour le bien des personnes, avec des actions **utiles** et **fondées sur des preuves** (une action inefficace mobilise des ressources et du temps des participants).

3. Non-malfaisance (*primum non nocere*) : ne pas nuire ; en nutrition, les risques sont la **stigmatisation** du poids, la **culpabilisation**, l'induction de **restriction** ou de TCA, la médicalisation excessive (prévention quaternaire, chapitre 1).

4. Justice : répartir équitablement les ressources et les efforts selon les **besoins**, sans creuser les inégalités (universalisme proportionné, chapitre 2).

5. Ces principes, proposés par Beauchamp et Childress (*Principles of Biomedical Ethics*, 1979), ne se hiérarchisent pas a priori : la réflexion éthique consiste à les **arbitrer** dans chaque situation.

Les principes propres à la santé publique

La santé publique agit sur des **populations** et peut limiter certaines libertés (taxer, interdire, réglementer). Childress et ses collègues (2002) proposent cinq conditions pour justifier une action qui restreint les libertés :

Condition	Question à se poser
Efficacité	L'action a-t-elle des chances raisonnables d'atteindre son objectif de santé ?
Proportionnalité	Les bénéfices attendus l'emportent-ils sur les atteintes aux libertés et les effets négatifs ?
Nécessité	N'existe-t-il pas un moyen moins contraignant d'obtenir le même résultat ?
Moindre atteinte	Choisit-on la modalité la moins intrusive (information avant interdiction) ?
Justification publique	Les décideurs expliquent-ils publiquement et de façon transparente leurs choix ?

L'échelle d'intervention

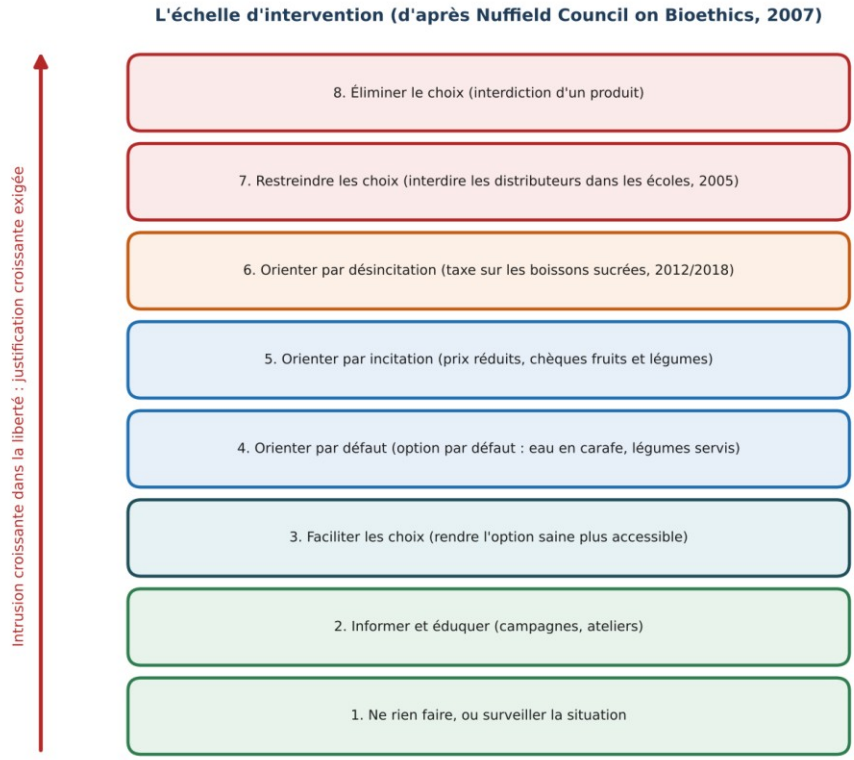


Figure 6.3 – L'échelle d'intervention en santé publique

Comprendre le schéma – Figure 6.3

1. Le Nuffield Council on Bioethics (2007) classe les interventions de santé publique selon leur degré d'**intrusion** dans la liberté individuelle, de « ne rien faire » à « éliminer le choix ».

2. Bas de l'échelle : informer, éduquer, faciliter (ateliers, campagnes PNNS) ; peu intrusifs, mais souvent moins efficaces seuls et plus favorables aux personnes déjà favorisées.

3. Milieu : orienter par défaut (*nudge* : légumes servis d'office, eau en carafe), inciter (chèques fruits et légumes), désinciter (contribution sur les boissons sucrées créée en 2012, rendue progressive selon la teneur en sucre en 2018, relevée le 1er mars 2025).

4. Haut de l'échelle : restreindre (interdiction des distributeurs automatiques payants dans les établissements scolaires depuis le 1er septembre 2005) ou éliminer le choix.

5. Plus on monte, plus la **justification** exigée est forte (gravité du problème, efficacité, absence d'alternative). Le diététicien de terrain agit surtout dans les échelons 2 à 4 ; il peut **argumenter** en faveur de mesures plus contraignantes auprès des décideurs (plaidoyer).

Définition – Nudge (« coup de pouce »)

Modification de l'**architecture du choix** qui oriente les comportements de manière prévisible **sans interdire** aucune option ni modifier significativement les incitations financières (Thaler et Sunstein, *Nudge*, 2008). Exemples : placer les fruits à hauteur des yeux au self, servir l'eau en carafe, rendre l'option végétarienne visible. On parle de **paternalisme libéral**.

Attention – Les questions éthiques posées par les nudges

Un nudge agit souvent **sans que la personne en ait conscience** : est-ce respectueux de son autonomie ? Les conditions d'un usage éthique sont la **transparence** (on peut annoncer la démarche : « Nous mettons les fruits en avant »), la **réversibilité** (la personne garde tous les choix), la **finalité** de santé (et non commerciale)

et l'**équité** (le nudge ne doit pas pénaliser un groupe).

Stigmatisation, culpabilisation et responsabilité individuelle

Les messages de nutrition peuvent produire des effets indésirables :

- **Stigmatisation du poids** (« grossophobie ») : images de personnes obèses sans visage, vocabulaire de la « lutte contre l'obésité » visant les personnes, moqueries. Elle est associée à une moins bonne santé mentale, à l'évitement des soins et à une prise de poids accrue ; elle est contraire au principe de non-malfaisance.
- **Culpabilisation** : faire porter la responsabilité aux individus (« Il suffit de manger mieux ») alors que les déterminants sont largement sociaux et environnementaux (chapitre 2).
- **Moralisation** de l'alimentation : « bons » et « mauvais » aliments, « tricher », « craquer » ; ces mots favorisent la restriction cognitive (chapitre 4).

Méthode pas à pas – Communiquer sans stigmatiser : 6 réflexes

1. Parler de **comportements** et d'**environnements**, pas de « personnes obèses » (dire « personnes en situation d'obésité » si nécessaire).
2. Utiliser des **images respectueuses** (personnes de toutes corpulences, actives, avec un visage).
3. Valoriser le **plaisir** et la **santé** plutôt que la minceur.
4. Ne jamais commenter le poids d'une personne devant un groupe ; ne pas peser en public.
5. Éviter le vocabulaire moral (bon/mauvais, interdit, tricher).
6. Rappeler les **déterminants** collectifs et proposer des solutions accessibles.

Méthode : analyser une action avec les quatre principes

Les quatre principes ne sont pas une liste à réciter. Ils servent à **examiner une action** sous quatre angles, puis à repérer les **tensions** entre eux. La méthode suivante peut être utilisée pour toute question de l'épreuve E5 qui demande d'« analyser les enjeux éthiques ».

Méthode pas à pas – Analyser une action en quatre angles

1. Décrire l'action en une phrase : qui fait quoi, pour qui, avec quels moyens.

2. Autonomie : les personnes sont-elles informées ? Sont-elles libres de participer, de refuser, de choisir ? Ont-elles été associées à la conception ?

3. Bienfaisance : l'action répond-elle à un besoin identifié par un diagnostic ? Est-elle fondée sur des preuves ? Quels bénéfices concrets en attendre ?

4. Non-malfaisance : quels effets indésirables sont possibles (stigmatisation, culpabilité, restriction, coût, perte de temps, atteinte à la vie privée) ? Comment les réduire ?

5. Justice : qui en profite et qui en est exclu ? L'action réduit-elle ou creuse-t-elle les inégalités (horaires, langue, coût, numérique) ?

6. Nommer la tension principale et proposer un **ajustement** qui la réduit.

Exemple – Analyse rédigée : des « paniers fruits et légumes » sur ordonnance

Action : une maison de santé (exemple fictif) propose à 40 familles orientées par les médecins un panier hebdomadaire de fruits et légumes à 2 € pendant six mois, avec trois ateliers cuisine.

- **Autonomie** : les familles choisissent d'entrer dans le dispositif et peuvent en sortir ; mais le contenu du panier est imposé. Ajustement : proposer deux tailles de paniers et une liste de légumes à éviter.
- **Bienfaisance** : l'action répond à un frein connu (le prix des fruits et légumes) ; les dispositifs d'ordonnances de fruits et légumes ont montré des hausses de consommation dans plusieurs évaluations,

à vérifier localement par un questionnaire avant et après.

- **Non-malfaisance** : le mot « ordonnance » peut médicaliser l'alimentation et faire sentir aux familles qu'elles « mangent mal ». Ajustement : parler de « panier de saison » et éviter tout discours sur le poids.
- **Justice** : l'orientation par les médecins oublie les familles qui ne consultent pas ; on peut ajouter une orientation par le centre social et l'épicerie solidaire.
- **Tension principale** : la justice (cibler les familles les plus modestes) contre la non-malfaisance (ne pas les désigner). Ajustement : un dispositif ouvert à tous, avec un tarif modulé selon le quotient familial (universalisme proportionné, chapitre 2).

Appliquer les conditions de Childress pas à pas

Les cinq conditions de Childress (6.3.2) s'appliquent aux mesures qui **restreignent** les choix. Il faut les examiner dans l'ordre, car si une mesure n'est pas efficace, il est inutile d'aller plus loin.

Condition	Mesure étudiée : supprimer les desserts sucrés le midi dans un self d'entreprise (exemple fictif)	Verdict
Efficacité	La mesure réduit les sucres consommés au self, mais les salariés peuvent acheter des desserts ailleurs	Douteuse
Proportionnalité	Atteinte forte au plaisir et au choix pour un gain incertain	Non remplie
Nécessité	D'autres moyens existent : fruits mis en avant, portions plus petites, desserts maison moins sucrés	Non remplie
Moindre atteinte	Un étiquetage clair et un dessert fruitier au prix le plus bas sont moins intrusifs	Non remplie
Justification publique	La direction n'a pas consulté les salariés ni expliqué ses raisons	Non remplie

Conclusion : la suppression n'est pas justifiée. On lui préfère une combinaison de mesures moins intrusives (bas et milieu de l'échelle d'intervention), évaluées au bout de trois mois.

Exemple – Calcul : estimer l'effet d'une mesure avant de la juger

Dans le self, 420 desserts sont vendus chaque jour, dont 30 % de fruits. La direction teste pendant un mois une présentation des fruits en premier, au prix le plus bas. La part des fruits passe à 41 %.

- Fruits vendus avant : 420 × 0,30 = **126** ; après : 420 × 0,41 = **172,2**, soit environ 172.
- Hausse relative : (41 − 30) / 30 × 100 = **36,7 %**.
- Desserts sucrés évités : 172 − 126 = **46** par jour, soit 46 × 20 jours = **920** par mois.

Ce résultat obtenu sans rien interdire rend la suppression des desserts encore moins nécessaire (condition de nécessité).

À vous de jouer – Exercice d'application 6.3

Une commune envisage d'interdire les camions de restauration rapide à moins de 200 mètres des collèges. Appliquez les cinq conditions de Childress en une phrase chacune, puis donnez votre avis argumenté.

Corrigé

Efficacité : la mesure réduit l'accès immédiat, mais les élèves peuvent marcher un peu plus loin ; l'effet doit être évalué. **Proportionnalité** : l'atteinte touche surtout des commerçants, pour un bénéfice possible chez les adolescents. **Nécessité** : on peut d'abord améliorer l'offre de la cantine et des foyers. **Moindre atteinte** : une charte avec les commerçants (offre de fruits, d'eau, de formules moins grasses) est moins intrusive. **Justification publique** : la commune doit présenter ses données, concerter commerçants, parents et élèves et

prévoir une évaluation. Avis : la mesure peut se défendre si elle s'accompagne d'une amélioration de la restauration scolaire et d'une concertation ; seule, elle risque d'être peu efficace et mal acceptée.

Liberté individuelle et protection de la santé : jusqu'où aller ?

La santé publique cherche à protéger la santé de tous, ce qui peut entrer en conflit avec la liberté de chacun. Ce débat est ancien. Dans *De la liberté* (1859), John Stuart Mill pose le **principe de non-nuisance** : la seule raison légitime de limiter la liberté d'une personne est d'empêcher qu'elle nuise à autrui. Selon ce principe, l'État ne devrait pas empêcher un adulte de manger ce qu'il veut, puisque cela ne nuit qu'à lui-même.

Trois arguments sont souvent opposés à cette position en nutrition :

- les choix alimentaires ne sont pas entièrement **libres** : ils sont fortement influencés par le marketing, le prix, l'offre disponible et les conditions de vie (chapitre 2) ;
- les maladies liées à l'alimentation ont un **coût collectif** (Assurance maladie, perte de productivité) ;
- les **enfants** ne peuvent pas exercer pleinement leur autonomie et doivent être protégés.

Type de paternalisme	Définition	Exemple en nutrition	Discussion
Paternalisme fort	Imposer un choix à une personne informée et capable, pour son bien	Interdire à un adulte d'acheter des sodas	Atteinte forte à l'autonomie, rarement justifiable
Paternalisme faible	Intervenir quand le choix n'est pas vraiment libre ou éclairé	Encadrer la publicité destinée aux enfants	Généralement accepté, car il protège des personnes vulnérables
Paternalisme libéral (« libertarien »)	Orienter les choix sans en supprimer aucun	Nudge : légumes en début de ligne de self	Accepté s'il est transparent et facile à contourner (6.3.2)

Définition – Principe de précaution

Principe selon lequel, lorsqu'un dommage grave et irréversible est possible, l'absence de certitude scientifique ne doit pas retarder l'adoption de mesures proportionnées pour le prévenir. En France, il figure à l'article 5 de la Charte de l'environnement (2004), qui a valeur constitutionnelle. En alimentation, il a par exemple justifié la suspension du bisphénol A dans les contenants alimentaires (loi du 24 décembre 2012).

Le principe de précaution ne signifie pas « interdire tout ce qui n'est pas prouvé sans danger ». Il impose des mesures **proportionnées** et **provisoires**, accompagnées de recherches pour réduire l'incertitude. Il ne faut pas le confondre avec la **prévention**, qui porte sur un risque connu et démontré (le sel et l'hypertension artérielle, par exemple).

Attention – Un argument souvent mal utilisé

Sur les réseaux sociaux, la « précaution » est parfois invoquée pour déconseiller des aliments sans fondement (« par précaution, évitez tous les produits laitiers »). Ce n'est pas le principe de précaution : celui-ci suppose un dommage grave plausible, identifié par une évaluation scientifique, et une réponse proportionnée décidée par les autorités. Un conseil d'éviction sans preuve peut au contraire nuire (carences, coût, anxiété).

À vous de jouer – Exercice d'application 6.4

Classez chaque mesure selon le type de paternalisme (fort, faible, libéral) et dites si elle vous paraît justifiable : a) interdiction de la publicité pour des produits gras, sucrés, salés pendant les programmes pour enfants ; b) carafe d'eau posée d'office sur les tables du restaurant universitaire, sodas toujours disponibles au comptoir ; c) obligation pour les adultes de suivre un atelier nutrition pour obtenir une aide alimentaire.

Corrigé

a) Paternalisme faible : il protège des enfants, plus sensibles à la publicité ; justifiable. b) Paternalisme libéral (nudge) : le choix reste entier et la mesure est transparente ; justifiable. c) Paternalisme fort : il impose une action à des adultes capables et conditionne une aide vitale ; il porte atteinte à l'autonomie et à la dignité (6.3.9) et n'est pas justifiable. On peut proposer l'atelier librement.

La stigmatisation du poids : un enjeu de santé, pas seulement de politesse

En 2020, un groupe de 36 experts internationaux a publié dans la revue *Nature Medicine* une **déclaration de consensus** pour mettre fin à la stigmatisation de l'obésité (Rubino et al., 2020). Ce texte rappelle que les préjugés sur le poids reposent souvent sur une idée fausse : l'obésité serait seulement une question de volonté individuelle (« il suffit de manger moins et de bouger plus »). Or le poids dépend de nombreux facteurs biologiques, génétiques, psychologiques, sociaux et environnementaux.

La stigmatisation a des **conséquences** documentées par de nombreuses études : évitement des consultations et des dépistages, moins bonne qualité des soins, dépression, faible estime de soi, isolement, et paradoxalement davantage de comportements alimentaires désordonnés et de prise de poids. Elle est donc contraire au principe de **non-malfaisance**, et elle est inefficace.

Au lieu de dire ou de faire	Préférer	Pourquoi
« Les obèses »	« Les personnes en situation d'obésité »	La personne n'est pas réduite à sa maladie
« La lutte contre l'obésité »	« La prévention », « favoriser une alimentation de qualité »	On lutte contre des causes, pas contre des personnes
Images de ventres sans visage	Personnes de toutes corpulences, actives, avec un visage	Respect de la dignité
Pesée devant le groupe	Pesée éventuelle en privé, seulement si elle est utile	Vie privée, non-malfaisance
« Manque de volonté »	Parler des déterminants et des conditions de vie	Information exacte et non culpabilisante
Matériel inadapté (fauteuils étroits, brassard trop petit)	Matériel adapté à toutes les corpulences	Accessibilité et justice

La stigmatisation peut aussi venir des **professionnels de santé** eux-mêmes, souvent sans qu'ils en aient conscience. Des études menées auprès de médecins, d'infirmiers et d'étudiants en nutrition montrent des préjugés implicites sur le poids. Le diététicien doit donc examiner ses propres représentations, par exemple en analyse de pratique.

Lien diététique – Stigmatisation et autres caractéristiques

La stigmatisation ne concerne pas que le poids. Les personnes en situation de précarité (« elles ne savent pas gérer leur budget »), les personnes d'origine étrangère (« leur cuisine est trop grasse ») ou les personnes âgées (« à son âge, ce n'est plus la peine ») sont aussi exposées. Le même réflexe s'applique : parler des conditions et des comportements, valoriser les savoir-faire, et ne jamais juger les personnes.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.5

Réécrivez ces trois phrases d'un support d'atelier pour qu'elles ne stigmatisent pas : a) « Les enfants obèses doivent arrêter de grignoter. » b) « Avec un peu de volonté, tout le monde peut perdre du poids. » c) « Les familles pauvres achètent trop de produits transformés. »

Corrigé

a) « Des repas et un goûter à heures régulières aident tous les enfants à avoir faim au bon moment. » b) « Le poids dépend de nombreux facteurs. Des petits changements choisis par la personne, accompagnés par un professionnel, sont plus efficaces que les régimes. » c) « Quand le budget est serré, les produits transformés sont souvent les moins chers et les plus rapides. Voici trois recettes simples, rapides et économiques. »

La posture professionnelle : un savoir-être

Le guide de 2025 relie l'éthique à la **posture professionnelle**, c'est-à-dire à la manière d'être du diététicien avec les personnes et le groupe. Elle se traduit par quatre valeurs, que l'on peut observer en atelier :

Valeur (guide 2025)	Ce que l'on observe chez le professionnel
Équité	Il adapte l'effort aux besoins : plus de temps ou d'aide pour ceux qui en ont besoin (universalisme proportionné, chapitre 2)
Justice sociale	Il veille à ce que l'action n'augmente pas les écarts : prix, horaires, langue, accès sans numérique
Bienveillance	Il accueille sans juger, valorise les savoirs des participants, évite toute parole stigmatisante sur le poids ou les habitudes
Autonomie individuelle et de groupe	Il propose sans imposer, laisse le groupe décider de ses règles et de ses objectifs, respecte un refus

Le savoir-être se travaille comme une compétence : on s'observe (enregistrement d'une animation avec accord), on demande un retour à un pair ou au tuteur, et on note dans un journal les situations qui ont posé question.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.2 – Les principes éthiques

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre principes de Beauchamp et Childress.
2. Dans quel ordre examine-t-on les cinq conditions de Childress, et pourquoi commence-t-on par l'efficacité ?
3. Quelle est la différence entre un paternalisme fort et un nudge ?
4. Quelle est la différence entre principe de précaution et prévention ?
5. Citez deux conséquences de la stigmatisation du poids sur la santé.
6. Une part de fruits passe de 25 % à 35 % des desserts. Calculez la hausse relative.

Corrigé – Point d'étape 6.3.2

1. Autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice.
2. Efficacité, proportionnalité, nécessité, moindre atteinte, justification publique ; une mesure inefficace ne peut pas être justifiée, il est donc inutile d'examiner la suite.
3. Le paternalisme fort impose un choix à une personne capable ; le nudge oriente sans rien interdire et reste facile à contourner.
4. La précaution concerne un risque grave mais incertain ; la prévention concerne un risque connu et démontré.
5. Évitement des soins, dépression, faible estime de soi, comportements alimentaires désordonnés, prise de poids.
6. (35 − 25) / 25 × 100 = 40 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.3.

Mon score	Ce que je fais
3 ou 4 sur 6	Je relis la méthode des quatre angles et le tableau du paternalisme.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.2 et je refais les exercices d'application.

6.3.3 Le cadre professionnel du diététicien

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 11)

Une profession réglementée

Texte	Contenu
Article L. 4371-1 CSP	Définition de la profession : le diététicien dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l'éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients ; il contribue à la qualité de l'alimentation en collectivité et aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition
Articles L. 4371-2 et suivants CSP	Le titre est réservé aux titulaires des diplômes reconnus (BTS Diététique et nutrition, DUT/BUT génie biologique option diététique, diplômes européens autorisés)
Enregistrement	Enregistrement obligatoire des diplômes auprès de l'ARS (répertoire des professionnels de santé) avant tout exercice
Usurpation de titre	L'usage du titre de diététicien sans diplôme est un délit (renvoi à l'article 433-17 du Code pénal)
Code de déontologie	Charte de déontologie du diététicien-nutritionniste publiée par l'Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN), version du 1er janvier 2018 ; il n'existe pas d'ordre professionnel des diététiciens, le code engage les professionnels qui s'y réfèrent et sert de référence en cas de litige

Attention – « Nutritionniste », « coach »… des titres non protégés

Le titre de « nutritionniste » seul n'est pas protégé (sauf « médecin nutritionniste ») et de nombreux « coachs en nutrition » ou « naturopathes » diffusent des conseils sans qualification reconnue. En santé publique, le diététicien s'assure que les intervenants d'un projet ont les **compétences** requises et que les messages sont **fondés sur des preuves**.

Les grands devoirs déontologiques

Devoir	Traduction en santé publique
Respect de la personne	Dignité, non-discrimination (origine, religion, poids, handicap, revenus), bienveillance, respect des choix
Secret professionnel	Ne pas divulguer ce qui a été confié ou observé ; confidentialité dans les groupes
Compétence et mise à jour	Agir dans son champ de compétence ; formation continue ; veille scientifique et réglementaire
Indépendance	Refuser toute influence commerciale sur ses messages ; déclarer ses liens d'intérêts
Information loyale	Messages exacts, sourcés, sans promesse trompeuse ; pas de publicité mensongère
Orientation	Orienter vers le médecin ou un autre professionnel quand la situation dépasse son champ (TCA, pathologie)

Devoir	Traduction en santé publique
Confraternité et coopération	Travailler en équipe pluriprofessionnelle, respecter les autres professionnels

Neutralité et laïcité

Dans un service public (école, collectivité, hôpital), les agents publics sont tenus à une stricte **neutralité** religieuse et politique ; le stagiaire qui intervient dans ces structures adopte la même réserve. Les usagers, eux, sont libres de leurs convictions : le diététicien **respecte** les pratiques alimentaires religieuses (chapitre 4) sans les promouvoir ni les juger.

Titre protégé, champ de compétence et travail en équipe

La profession de diététicien est protégée par son **titre** : seules les personnes titulaires d'un diplôme reconnu et enregistrées peuvent se dire diététiciennes ou diététiciens. En revanche, le Code de la santé publique ne réserve pas aux diététiciens le monopole de tout conseil alimentaire : un médecin, un infirmier ou un enseignant peut parler d'alimentation dans son propre champ. C'est pourquoi la vigilance porte surtout sur l'**usage du titre** et sur la **qualité** des conseils diffusés.

Situation	Qui peut le faire ?	Point de vigilance
Animer un atelier de prévention « bien manger à petit prix »	Diététicien, mais aussi d'autres professionnels formés (conseillère en économie sociale et familiale, infirmière)	Messages conformes aux repères officiels
Établir un régime pour une pathologie (insuffisance rénale, diabète)	Diététicien, sur prescription médicale, ou médecin	Le diagnostic et la prescription relèvent du médecin
Se présenter comme « diététicien »	Seulement le titulaire d'un diplôme reconnu et enregistré	L'usurpation du titre est un délit
Prendre en charge seul une anorexie mentale sévère	Personne seul : prise en charge pluriprofessionnelle (médecin, psychiatre, diététicien, psychologue)	Orienter rapidement, l'anorexie mentale peut mettre la vie en danger

Le diététicien travaille dans son **champ de compétence**. Quand une situation le dépasse (suspicion de trouble du comportement alimentaire, perte de poids inexpliquée, signes de dénutrition grave, détresse psychique), il **oriente** vers le médecin traitant ou vers une structure spécialisée, et il le fait avec l'accord de la personne.

> **Définition – Développement professionnel continu (DPC)**
>
> Obligation, pour tous les professionnels de santé, de suivre un parcours de formation continue sur une période de trois ans, comprenant des actions de formation, d'évaluation des pratiques et de gestion des risques. Elle a été instituée par la loi du 21 juillet 2009 et réorganisée par la loi du 26 janvier 2016. Pour le diététicien, elle traduit le devoir déontologique de **compétence** et de mise à jour.

Le devoir de non-discrimination

L'article 225-1 du Code pénal définit la discrimination comme une distinction opérée entre les personnes sur le fondement de critères interdits, parmi lesquels l'origine, le sexe, l'apparence physique, l'état de santé, le handicap, la religion, la situation de famille, le lieu de résidence ou la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique. Refuser un service à une personne pour l'un de ces motifs est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende (article 225-2).

En santé publique, la discrimination peut être **directe** (refuser une personne en situation d'obésité dans un atelier sportif) ou **indirecte** : une règle en apparence neutre qui désavantage un groupe (des inscriptions uniquement en ligne écartent les personnes sans accès au numérique). Le diététicien doit repérer les deux.

Exemple – Repérer une discrimination indirecte par le calcul

Un programme d'ateliers « cuisine et santé » (exemple fictif) accepte les inscriptions uniquement sur un site internet. Dans le quartier, 18 % des adultes n'ont pas d'accès personnel à internet. Parmi les 50 inscrits, aucun n'est dans ce cas.

- Si les inscriptions étaient indépendantes de l'accès à internet, on attendrait environ 50 × 0,18 = **9** inscrits sans accès personnel.
- On en observe **0** : le mode d'inscription a très probablement exclu ce public.

Ajustement : inscriptions aussi par téléphone, à l'accueil du centre social et par les travailleurs sociaux.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.6

Pour chaque situation, dites s'il s'agit d'une discrimination directe, indirecte, ou d'aucune discrimination, et justifiez : a) un club refuse une adolescente dans son atelier « sport et nutrition » à cause de son poids ; b) les ateliers d'une maison de quartier ont lieu uniquement à 10 h en semaine ; c) un atelier pour diabétiques est réservé aux personnes diabétiques.

Corrigé

a) Discrimination directe, fondée sur l'apparence physique ou l'état de santé. b) Discrimination indirecte possible : l'horaire écarte les personnes qui travaillent ; il faut proposer d'autres créneaux. c) Pas de discrimination : la distinction répond à un objectif légitime (l'éducation thérapeutique d'une maladie) et elle est proportionnée ; on peut ouvrir l'atelier aux aidants.

La déontologie au quotidien : huit situations commentées

Les devoirs déontologiques (6.3.3) prennent tout leur sens dans des situations concrètes. Le tableau suivant reprend des questions fréquentes en stage et en début d'exercice. Les réponses proposées sont des repères, à adapter avec le tuteur et l'équipe.

Situation	Devoir en jeu	Conduite proposée
1. Une participante offre une boîte de chocolats à la fin du cycle d'ateliers	Désintéressement, relation professionnelle	Un petit cadeau symbolique peut être accepté et partagé avec l'équipe ; un cadeau de valeur ou de l'argent est refusé avec tact
2. Un ami vous demande sur un réseau social « le meilleur régime pour perdre 10 kg »	Information loyale, pas de conseil individualisé sans bilan	Répondre en privé que vous ne pouvez pas conseiller sans bilan et l'orienter vers son médecin ou une consultation
3. Une collègue diffuse une fiche contenant une erreur (seuil de sel faux)	Compétence, confraternité, sécurité du public	Lui en parler en privé, avec la source, et proposer de corriger ensemble ; informer le responsable si l'erreur n'est pas corrigée
4. Une prescription médicale vous paraît inadaptée (régime sans sel strict chez une personne âgée qui mange peu)	Coopération, sécurité, non-malfaisance	Contacter le médecin pour en discuter, avec des arguments (risque de dénutrition) ; ne pas modifier seul la prescription
5. Un participant demande si vous pouvez lui vendre des compléments	Indépendance, absence de conflit d'intérêts	Refuser ; s'il a un besoin réel, l'orienter vers son médecin ou son pharmacien

Situation	Devoir en jeu	Conduite proposée
6. On vous propose d'animer un atelier sur un thème que vous maîtrisez mal (nutrition du sportif de haut niveau)	Compétence	Se former avant, ou orienter vers un collègue spécialisé
7. Une personne refuse vos conseils et veut continuer un régime très restrictif	Autonomie, non-malfaisance	Expliquer les risques avec des mots simples, laisser la porte ouverte, informer le médecin si un danger est possible et avec son accord
8. Vous êtes fatigué et irrité face à un groupe agité	Respect de la personne, maîtrise de soi	Faire une pause, rappeler le cadre calmement, en parler ensuite en analyse de pratique

Astuce – Trois questions à se poser avant d'agir

1. **Est-ce légal ?** (Code de la santé publique, Code pénal, RGPD, règlement de la structure).
2. **Est-ce conforme à ma déontologie ?** (secret, indépendance, compétence, respect).
3. **Serais-je à l'aise si ma décision était connue de la personne concernée, de mon tuteur ou du public ?** Si la réponse à l'une des questions est « non » ou « je ne sais pas », je m'arrête et je demande conseil.

La relation avec les autres professionnels

Le diététicien ne travaille presque jamais seul. En santé publique, il collabore avec des médecins, des infirmiers, des travailleurs sociaux, des enseignants, des animateurs, des cuisiniers et des élus. La **confraternité** et la **coopération** imposent de respecter les compétences de chacun, de ne pas dénigrer un autre professionnel devant le public, et de transmettre les informations utiles dans le respect du secret (6.3.4).

Lien diététique – Le diététicien et le cuisinier

Dans un projet de restauration collective, le cuisinier n'est pas un simple exécutant : il connaît les contraintes de production, les goûts des convives et le budget. Une démarche éthique consiste à construire les menus **avec** lui, à valoriser son savoir-faire et à expliquer les raisons des recommandations, plutôt qu'à imposer des fiches techniques. C'est aussi une condition de réussite du projet.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.7

Lors d'un atelier, une participante vous dit : « Mon médecin m'a dit n'importe quoi, il ne connaît rien à la nutrition. » Rédigez votre réponse en respectant la confraternité, sans nier ce qu'elle ressent.

Corrigé

Exemple : « J'entends que vous n'êtes pas satisfaite de ce qui vous a été dit. Je ne peux pas juger une consultation à laquelle je n'ai pas assisté. Si vous le voulez, nous pouvons noter ensemble vos questions pour que vous les posiez à votre médecin, ou je peux, avec votre accord, prendre contact avec lui pour que nous travaillions ensemble. » La réponse ne dénigre pas le médecin, reconnaît l'émotion de la personne et propose une coopération.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.3 – Le cadre professionnel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. La profession de diététicien est-elle protégée par un monopole d'exercice ou par son titre ?
2. Qu'est-ce que le développement professionnel continu, et sur quelle période s'organise-t-il ?

3. Donnez un exemple de discrimination indirecte dans une action de santé publique.
4. Quelle conduite adopter face à une prescription médicale qui vous paraît inadaptée ?
5. Citez les trois questions à se poser avant d'agir.
6. Un atelier compte 40 inscrits ; 25 % du public visé ne lit pas le français, mais aucun inscrit n'est dans ce cas. Combien en attendrait-on ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.3

1. Par son titre : l'usage du titre sans diplôme est un délit.
2. Une obligation de formation continue pour tous les professionnels de santé (formation, évaluation des pratiques, gestion des risques), organisée sur trois ans.
3. Inscriptions uniquement en ligne, horaires uniquement en journée, supports uniquement écrits en français.
4. Contacter le médecin pour en discuter avec des arguments, sans modifier seul la prescription.
5. Est-ce légal ? Est-ce conforme à ma déontologie ? Serais-je à l'aise si ma décision était connue ?
6. 40 × 0,25 = 10 inscrits.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.4.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des huit situations et la partie sur la discrimination.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.3 et je refais les exercices d'application.

6.3.4 Le secret professionnel et la confidentialité

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Essentiels M1 S2 §2 (p. 11) ; Essentiels M1 S6 §2.1 et §2.2 (p. 22 et 23)

Définition – Secret professionnel

Obligation, pour un professionnel, de ne pas révéler les informations à caractère secret dont il a connaissance dans l'exercice de sa profession. Toute personne prise en charge par un professionnel ou un établissement de santé a droit au **respect de sa vie privée et du secret** des informations la concernant (article **L. 1110-4** du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002). La révélation d'une information à caractère secret est punie d'**un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende** (article **226-13** du Code pénal).

Situation en action collective	Conduite à tenir
Un participant confie en atelier un diagnostic (diabète)	L'information reste dans le groupe (règle de confidentialité énoncée au départ) ; le diététicien n'en parle pas à l'extérieur
Le partenaire demande « qui a des problèmes de poids »	Ne transmettre que des données agrégées et anonymes (« 8 participants sur 12 souhaitent… »)
Un parent confie des difficultés financières	Ne pas en parler devant le groupe ; proposer en privé une orientation (CCAS, épicerie solidaire) avec son accord
Un enfant semble en danger (signes de maltraitance, de négligence grave)	Le secret ne s'oppose pas à la protection de l'enfance : en parler sans délai au responsable de la structure ; information préoccupante à la cellule départementale (CRIP), ou 119 ; en cas de danger immédiat, 17
Échange avec l'équipe	Partage limité aux informations strictement nécessaires à la prise en charge, entre professionnels de l'équipe, la personne étant informée (article L. 1110-4 CSP)

Méthode pas à pas – Poser le cadre de confidentialité en début de séance

« Ici, chacun parle de ce qu'il veut. Ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Personne n'est obligé de répondre ou de goûter. On ne juge pas ce que mangent les autres. » Le cadre est rappelé à chaque séance et affiché si besoin.

Ce que couvre le secret, et ses exceptions

Le secret professionnel couvre **tout ce qui est venu à la connaissance** du professionnel dans l'exercice de sa profession : ce qui lui a été **confié**, mais aussi ce qu'il a **vu, entendu ou compris**. Il couvre aussi le fait même qu'une personne a consulté ou participé à un atelier. Sa violation est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 226-13 du Code pénal).

Le secret appartient à la **personne**, pas au professionnel. Il protège sa vie privée et la confiance nécessaire à la relation d'aide. C'est pourquoi la personne peut, dans certains cas, autoriser le partage d'informations, alors que le professionnel ne peut pas décider seul de les révéler.

Le secret couvre	Exemples en action collective
Les informations confiées	Un participant dit qu'il a un diabète, qu'il est au chômage, qu'il a des dettes
Les informations observées	Une participante semble très amaigrie ; un enfant arrive chaque semaine sans goûter
Les informations déduites	La présence d'une personne à un atelier « diabète » révèle sa maladie
L'identité des personnes accompagnées	Le nom des familles orientées par l'épicerie solidaire

Les dérogations prévues par la loi

Le secret n'est pas absolu. La loi prévoit des situations où le professionnel **doit** ou **peut** parler.

Type de dérogation	Exemples	Texte
Obligation de déclarer	Maladies à déclaration obligatoire (dont la toxi-infection alimentaire collective), déclaration de naissance ou de décès	Code de la santé publique
Permission de signaler	Privations ou sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger ; violences au sein du couple quand elles mettent la vie de la victime en danger immédiat et qu'elle est sous emprise	Article 226-14 du Code pénal
Obligation d'agir face à un péril	Porter secours à une personne en danger (appeler les secours)	Article 223-6 du Code pénal (non-assistance à personne en danger)
Partage avec l'équipe	Échange des informations strictement nécessaires entre professionnels qui prennent en charge la même personne, celle-ci étant informée et pouvant s'y opposer	Article L. 1110-4 du Code de la santé publique

Le signalement fait de **bonne foi** dans le cadre de l'article 226-14 ne peut pas entraîner de sanction pour le professionnel. Ne rien faire face à un enfant en danger, en revanche, peut engager sa responsabilité (non-assistance à personne en danger).

Attention – Discrétion n'est pas secret

Le stagiaire, l'animateur ou le bénévole d'une association ne sont pas toujours soumis au secret professionnel au sens du Code pénal. Ils sont en revanche tenus à la **discrétion** et à la **confidentialité** par leur convention,

leur contrat ou le règlement de la structure. En pratique, la conduite attendue est la même : ne rien divulguer de ce qui a été appris sur les personnes, sauf pour les protéger.

Exemple – Le secret à la sortie de l'atelier

À la sortie d'un atelier, la voisine d'une participante vous demande : « Alors, Mme D. vient pour son diabète, c'est ça ? » La bonne réponse ne confirme ni n'infirme : « Je ne peux pas parler des personnes qui participent aux ateliers. Si vous voulez des informations sur les ateliers, je vous donne la plaquette. » Répondre « non, ce n'est pas pour ça » serait déjà une indiscrétion.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.8

Pour chaque situation, dites si vous devez parler, si vous pouvez parler, ou si vous devez vous taire : a) quatre participants d'un même buffet présentent des vomissements le lendemain ; b) un employeur appelle pour savoir si son salarié suit bien les ateliers ; c) une participante âgée et isolée semble privée de nourriture par son entourage.

Corrigé

a) Devoir de parler : suspicion de toxi-infection alimentaire collective, déclaration obligatoire à l'ARS, par le responsable de la structure ou le médecin. b) Se taire : l'employeur n'a pas à connaître la participation de son salarié, sauf accord de ce dernier. c) Pouvoir parler, et même agir : l'article 226-14 permet de signaler des privations infligées à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger ; en pratique, on en parle sans délai au responsable et on recherche l'accord de la personne, puis on alerte les services compétents (médecin traitant, services du département, procureur en cas de danger grave).

Partager des informations dans une équipe et en réseau

Un projet de santé publique réunit souvent des professionnels de plusieurs secteurs : santé, social, éducation, associations. Tous n'ont pas le même cadre. Le partage d'informations obéit à trois règles simples : la **personne est informée**, on partage **le strict nécessaire**, et **seulement** avec les professionnels qui en ont besoin pour l'aider.

Cadre	Qui peut partager ?	Conditions
Équipe de soins (article L. 1110-4 et L. 1110-12 du Code de la santé publique)	Professionnels qui participent directement à la prise en charge d'une même personne (médecin, infirmier, diététicien, psychologue…)	Informations strictement nécessaires à la continuité des soins ; personne informée, qui peut s'y opposer
Hors équipe de soins (entre secteur sanitaire et secteur social, par exemple)	Professionnels de santé et professionnels du social ou du médico-social	Consentement préalable de la personne
Action sociale (article L. 121-6-2 du Code de l'action sociale et des familles)	Professionnels de l'action sociale qui interviennent auprès d'une même personne ou famille	Partage limité à ce qui est nécessaire, personne informée ; information du maire dans certains cas
Protection de l'enfance (article L. 226-2-2 du même code)	Professionnels de la protection de l'enfance	Partage dans l'intérêt de l'enfant, parents informés sauf si c'est contraire à l'intérêt de l'enfant

Méthode pas à pas – Avant de transmettre une information sur une personne

1. Pourquoi ? Quel est le but précis de la transmission ? Est-il dans l'intérêt de la personne ?

2. À qui ? Le destinataire en a-t-il besoin pour l'aider ? Est-il lui-même tenu au secret ou à la discrétion ?

3. Quoi ? Quelle est l'information minimale utile ? (« Mme L. a besoin d'une aide pour ses courses » plutôt que tout son dossier).

4. Avec quel accord ? La personne est-elle informée ? A-t-elle donné son accord quand il est nécessaire ?

5. Comment ? Par un moyen sécurisé (messagerie sécurisée de santé, entretien en face à face), jamais par une messagerie personnelle ou un groupe de discussion.

6. Trace : noter la transmission dans le dossier ou le journal de bord, sans détail inutile.

Exemple – Une réunion de synthèse dans un centre social

Le centre social réunit chaque mois la conseillère en économie sociale et familiale, l'animatrice, la référente famille et la stagiaire diététicienne. On y parle d'une famille en difficulté. La stagiaire sait, par un entretien, que la mère saute des repas pour nourrir ses enfants. Avant la réunion, elle lui a demandé : « Est-ce que je peux en parler à la conseillère, pour qu'elle voie avec vous une aide alimentaire ? » La mère a accepté. En réunion, la stagiaire dit seulement : « Mme R. a des difficultés pour nourrir toute la famille et elle est d'accord pour qu'on l'aide à accéder à l'épicerie solidaire. » Le reste de l'entretien n'est pas répété.

Attention – Les groupes de discussion sur téléphone

Les échanges entre collègues sur des applications de messagerie grand public (groupes de discussion) sont pratiques, mais ils ne sont pas sécurisés et les messages peuvent être lus, transférés ou capturés. On n'y écrit jamais le nom d'une personne accompagnée ni une information sur sa santé ou sa situation. Pour les professionnels de santé, il existe des messageries sécurisées de santé (espace de confiance MSSanté).

À vous de jouer – Exercice d'application 6.9

L'enseignante d'une école demande à la diététicienne d'un atelier parents-enfants « ce que la mère de Lucas a dit sur ses repas à la maison », car Lucas s'endort souvent en classe. Indiquez la conduite à tenir en appliquant les six étapes de la méthode.

Corrigé

Pourquoi ? L'enseignante s'inquiète pour Lucas, son objectif est légitime. **À qui ?** L'enseignante n'est pas dans l'équipe de soins, et les propos de la mère ont été tenus dans un cadre confidentiel. **Quoi ?** Rien du contenu de l'atelier ne peut être transmis sans accord. **Accord** : la diététicienne peut proposer à la mère d'en parler elle-même avec l'enseignante, ou de rencontrer ensemble l'infirmière scolaire. **Comment ?** Si la mère accepte, un échange en face à face, limité à ce qu'elle souhaite partager. **Trace** : noter la demande et la réponse dans le journal de bord. Si la diététicienne observe des signes de danger pour Lucas, elle en parle au responsable de la structure (information préoccupante).

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.4 – Le secret professionnel

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Le secret couvre-t-il seulement ce qui a été confié ? Justifiez.
2. À qui appartient le secret ?
3. Quelle sanction prévoit l'article 226-13 du Code pénal ?
4. Que permet l'article 226-14 du Code pénal ?
5. Quelles sont les trois règles du partage d'informations dans une équipe ?
6. Pourquoi ne faut-il pas écrire le nom d'une personne accompagnée dans un groupe de discussion grand

public ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.4

1. Non : il couvre aussi ce qui a été vu, entendu ou compris, et le fait même que la personne a été accompagnée.
2. À la personne accompagnée.
3. Un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
4. De signaler, sans être sanctionné, les privations ou sévices infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger.
5. La personne est informée ; on partage le strict nécessaire ; seulement avec les professionnels qui en ont besoin pour l'aider.
6. Ces messageries ne sont pas sécurisées : les messages peuvent être lus, transférés ou capturés, ce qui viole le secret et le RGPD.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.5.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux des dérogations et du partage d'informations.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.4 et je refais les exercices d'application.

6.3.5 La protection des données personnelles (RGPD)

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Le **Règlement général sur la protection des données** (règlement (UE) **2016/679** du 27 avril 2016), applicable depuis le **25 mai 2018**, complète en France la loi **Informatique et libertés** du 6 janvier 1978. Il s'applique dès qu'on collecte des **données personnelles** : nom, adresse, téléphone, photo, mais aussi poids, habitudes alimentaires associées à une personne identifiable. Le contrôle est assuré par la **CNIL**.

Définition – Donnée personnelle, donnée de santé, anonymisation

- **Donnée personnelle** : toute information se rapportant à une personne physique **identifiée ou identifiable**, directement (nom) ou indirectement (croisement âge + école + quartier).
- **Données de santé** : catégorie **particulière** (article 9 du RGPD) dont le traitement est en principe **interdit**, sauf exceptions (consentement explicite, prise en charge sanitaire, intérêt public…) ; poids, pathologies, allergies, régimes médicaux en font partie.
- **Pseudonymisation** : remplacement du nom par un code ; les données restent **personnelles** (on peut retrouver la personne avec la clé).
- **Anonymisation** : rendre **impossible**, de façon irréversible, toute réidentification ; les données anonymes ne relèvent plus du RGPD.



Figure 6.4 – Les six principes du RGPD

Comprendre le schéma – Figure 6.4

1. Licéité, loyauté, transparence : chaque traitement repose sur une **base légale** (consentement, mission d'intérêt public, intérêt légitime…) et les personnes sont **informées** (qui collecte, pourquoi, combien de temps, leurs droits).

2. Limitation des finalités : les données sont collectées pour un objectif précis (évaluer l'atelier) et ne sont pas réutilisées pour autre chose (prospection commerciale).

3. Minimisation : on ne collecte que ce qui est **nécessaire** ; un questionnaire de satisfaction n'a pas besoin du nom ni de la date de naissance.

4. Exactitude : données exactes et mises à jour.

5. Limitation de la conservation : durée définie à l'avance, puis suppression ou anonymisation.

6. Intégrité et confidentialité : sécurité (fichier protégé par mot de passe, accès limité, pas de partage sur une messagerie personnelle, destruction des questionnaires papier).

7. S'y ajoute la **responsabilité** (*accountability*) : le responsable du traitement (la structure) doit pouvoir **démontrer** sa conformité (registre des traitements).

Droits des personnes	Contenu
Information	Savoir qui traite ses données, pourquoi, combien de temps
Accès et rectification	Obtenir ses données, les faire corriger
Effacement	Obtenir la suppression dans certains cas
Opposition	S'opposer au traitement pour des raisons tenant à sa situation
Retrait du consentement	À tout moment, aussi facilement qu'il a été donné
Réclamation	Saisir la CNIL

Exemple – Calcul : l'ordre de grandeur des sanctions

Les amendes administratives peuvent atteindre **20 millions d'euros** ou **4 % du chiffre d'affaires annuel mondial**, le montant **le plus élevé** étant retenu (article 83 du RGPD). Pour une entreprise de restauration collective réalisant 300 M€ de chiffre d'affaires : 4 % × 300 = 0,04 × 300 = **12 M€** ; 12 M€ < 20 M€ → plafond applicable : **20 M€**. Pour un groupe réalisant 2 milliards d'euros : 0,04 × 2 000 = **80 M€** > 20 M€ → plafond : **80 M€**. Une association peut aussi être sanctionnée (rappel à l'ordre, amende, injonction).

Méthode pas à pas – Mentions d'information à placer sur un questionnaire

« Ce questionnaire est **anonyme**. Il sert uniquement à **évaluer** l'atelier « Bien manger, petit budget » du centre social des Tilleuls. Les réponses sont saisies par l'étudiante stagiaire, puis les questionnaires papier sont détruits ; le fichier est conservé jusqu'au [date], puis supprimé. Vous êtes libre de ne pas répondre. Contact : [référente du centre social]. »

Exemple – Calcul d'une date de suppression

Questionnaires recueillis le 31 mars 2028, conservation prévue « 3 mois après l'épreuve E5, prévue le 15 juin 2028 » : 15 juin + 3 mois = **15 septembre 2028**. La date est écrite dans la mention d'information et dans le registre de la structure, et une alerte est programmée dans l'agenda.

Choisir la bonne base légale

Tout traitement de données personnelles doit reposer sur l'une des **six bases légales** prévues par l'article 6 du RGPD. La base légale n'est pas un détail administratif : elle détermine les droits des personnes (par exemple, le droit de retirer son consentement n'existe que si le traitement repose sur le consentement).

Base légale (article 6)	Quand l'utiliser ?	Exemple dans un projet de nutrition
Consentement	La personne a un vrai choix et peut refuser sans conséquence	Inscription à une lettre d'information d'une association ; utilisation de photos
Contrat	Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat avec la personne	Gestion des inscriptions payantes à un cycle d'ateliers
Obligation légale	Une loi impose le traitement	Conservation des factures ; déclaration d'une toxi-infection alimentaire collective
Sauvegarde des intérêts vitaux	Urgence vitale, la personne ne peut pas consentir	Transmettre une allergie aux secours lors d'un malaise
Mission d'intérêt public	Le traitement est nécessaire à une mission de service public	Enquête d'une mairie ou d'un hôpital sur la restauration de ses usagers
Intérêt légitime	Organismes privés, intérêt réel qui ne porte pas une atteinte excessive aux droits des personnes	Une association évalue la satisfaction de ses adhérents

Pour les **données de santé**, il faut en plus l'une des exceptions de l'article 9 : consentement **explicite**, prise en charge sanitaire ou sociale par un professionnel tenu au secret, intérêt public dans le domaine de la santé publique, recherche scientifique encadrée, etc.

Attention – Le consentement n'est pas toujours la bonne base

Dans un service public ou chez un employeur, la personne n'est souvent pas vraiment libre de refuser : son consentement n'est alors pas valable. Une commune qui réalise une enquête de restauration scolaire s'appuie plutôt sur sa **mission d'intérêt public**, tout en laissant les familles libres de répondre. À l'inverse, pour diffuser des photos ou envoyer des messages d'information, le consentement reste la base adaptée.

Méthode pas à pas – Construire la fiche d'un traitement pour le registre

Le registre des activités de traitement (article 30 du RGPD) décrit chaque traitement de la structure. Pour un questionnaire de diagnostic, la fiche comprend :

1. Nom du traitement et responsable : « Enquête goûters 2027 », service de restauration de la commune.

2. Finalité : connaître les goûters des enfants pour adapter les ateliers.

3. Base légale : mission d'intérêt public.

4. Catégories de personnes et de données : parents ; âge et classe de l'enfant, aliments du goûter ; pas de nom.

5. Destinataires : service de restauration uniquement ; résultats globaux diffusés.

6. Durée de conservation : papier détruit trois mois après saisie ; fichier supprimé au bout d'un an.

7. Sécurité : fichier protégé par mot de passe, accès limité à deux personnes, stockage sur le serveur de la commune.

8. Transferts hors de l'Union européenne : aucun.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.10

Indiquez la base légale la plus adaptée pour chaque traitement : a) un hôpital enregistre les allergies des patients pour adapter leurs repas ; b) une association de diététiciens envoie une lettre d'information mensuelle à des abonnés ; c) une cuisine centrale conserve les factures de ses fournisseurs ; d) une mairie interroge les seniors du portage de repas sur leur satisfaction.

Corrigé

a) Mission d'intérêt public ou prise en charge sanitaire (article 9 : soins par des professionnels tenus au secret). b) Consentement : chaque abonné s'inscrit et peut se désinscrire à tout moment. c) Obligation légale (règles comptables). d) Mission d'intérêt public ; la participation reste libre et les personnes sont informées.

Sécuriser les données au quotidien

La sécurité est souvent le point faible des petits projets. Les incidents les plus fréquents ne viennent pas de pirates informatiques, mais d'**erreurs humaines** : une clé USB perdue, un courriel envoyé au mauvais destinataire, un tableau partagé en accès public, un questionnaire oublié sur une table.

Risque	Mesure simple
Perte ou vol d'un ordinateur ou d'une clé USB	Chiffrer les fichiers, ne pas stocker de données de santé sur une clé personnelle
Accès non autorisé	Mot de passe robuste et différent pour chaque service ; accès limité aux personnes qui en ont besoin
Envoi au mauvais destinataire	Vérifier les adresses ; envoyer les fichiers protégés par mot de passe et transmettre le mot de passe par un autre canal
Partage trop large	Vérifier les droits d'accès des documents partagés en ligne ; pas de lien « accessible à toute personne disposant du lien » pour des données personnelles
Questionnaires papier	Urne fermée pour les recueillir, rangement dans une armoire fermée à clé, destruction au broyeur
Outil en ligne hébergé hors de l'Union européenne	Préférer un outil qui héberge les données dans l'Union européenne, ou vérifier les garanties prévues

Définition – Pseudonymisation par table de correspondance

Technique qui consiste à remplacer le nom de chaque personne par un code (P01, P02…) dans le fichier d'analyse, et à conserver à part, de façon sécurisée, la table qui relie les codes aux noms. Elle est utile quand on doit relier deux questionnaires d'une même personne (avant et après un atelier). La table est conservée

par une seule personne, puis détruite dès qu'elle n'est plus nécessaire : le fichier devient alors anonyme si aucune autre information ne permet de retrouver les personnes.

Exemple – Relier deux questionnaires sans nom

Pour comparer les réponses avant et après un cycle d'ateliers sans demander le nom, on peut utiliser un **code personnel** que chaque participant construit lui-même et retrouve facilement : par exemple, les deux premières lettres du prénom de sa mère, suivies du jour de son anniversaire (« MA14 »). L'animateur ne connaît pas la correspondance. Attention : ce code reste une donnée personnelle si le groupe est petit et si l'on peut deviner la personne ; on évite donc de le combiner avec des informations très précises.

En cas de violation de données

Une **violation de données** est un incident de sécurité qui entraîne la destruction, la perte, l'altération, la divulgation ou l'accès non autorisé à des données personnelles. Le responsable du traitement doit :

- **documenter** chaque violation dans un registre interne ;
- la **notifier à la CNIL** dans un délai de **72 heures** après en avoir pris connaissance, sauf si elle ne présente pas de risque pour les personnes (article 33 du RGPD) ;
- **informer les personnes** concernées sans tarder si la violation présente un risque élevé pour leurs droits (article 34).

Le stagiaire qui découvre une violation (fichier envoyé par erreur, clé perdue) prévient **immédiatement** son tuteur et le délégué à la protection des données de la structure : chaque heure compte pour respecter le délai.

Exemple – Calcul du délai de notification

Une animatrice s'aperçoit le jeudi 9 septembre 2027 à 16 h qu'un tableau contenant le nom et les allergies de 35 enfants a été envoyé à tous les parents d'une classe. La structure doit notifier la CNIL au plus tard 72 heures plus tard, soit le **dimanche 12 septembre 2027 à 16 h**. En pratique, la notification se fait dès le vendredi, en ligne, et les familles concernées sont informées, car il s'agit de données de santé d'enfants.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.11

Une stagiaire a perdu dans le bus, le lundi 4 octobre 2027 vers 18 h, une clé USB non chiffrée contenant les réponses nominatives de 48 seniors à un questionnaire sur leur appétit et leur poids. Indiquez : a) s'il s'agit d'une violation de données ; b) ce que la stagiaire doit faire ; c) la date limite de notification à la CNIL ; d) deux mesures pour éviter que cela se reproduise.

Corrigé

a) Oui : perte de données personnelles, dont des données de santé (poids, appétit), avec un accès possible par un tiers. b) Prévenir immédiatement son tuteur et le délégué à la protection des données, décrire précisément le contenu de la clé et les circonstances. c) Au plus tard le jeudi 7 octobre 2027 vers 18 h ; les personnes doivent aussi être informées en raison du risque élevé. d) Ne jamais transporter de données nominatives sur une clé personnelle ; chiffrer les fichiers ; pseudonymiser les réponses dès la saisie ; travailler sur le serveur de la structure.

Délégué à la protection des données et analyse d'impact

Le **délégué à la protection des données** (DPO, pour *data protection officer*) conseille la structure, contrôle le respect du RGPD et sert de contact pour les personnes et pour la CNIL. Sa désignation est **obligatoire** pour les autorités et organismes publics (communes, hôpitaux, établissements scolaires) et pour les organismes dont

l'activité principale les conduit à traiter des données sensibles, comme les données de santé, à grande échelle. Dans un projet, il est l'interlocuteur à consulter avant de lancer une enquête ou un outil numérique.

Une **analyse d'impact relative à la protection des données** (AIPD, article 35 du RGPD) est obligatoire quand un traitement est susceptible d'engendrer un **risque élevé** pour les droits des personnes. La CNIL a publié une liste de critères ; un traitement qui en remplit au moins deux doit en principe faire l'objet d'une AIPD.

Critère de la CNIL (extraits)	Exemple dans un projet de nutrition
Données sensibles ou à caractère hautement personnel	Données de santé, poids, troubles alimentaires
Personnes vulnérables	Enfants, patients, personnes âgées dépendantes, personnes précaires
Collecte à grande échelle	Application de suivi alimentaire proposée à toute une région
Croisement de données	Rapprochement des données d'achats et des données de santé
Usage innovant ou nouvelle technologie	Analyse automatique des photos de repas par intelligence artificielle
Suivi systématique	Bracelet connecté qui enregistre en continu l'activité physique

Exemple – Faut-il une analyse d'impact ?

Une maison de santé veut proposer aux patients diabétiques un carnet alimentaire en ligne, analysé automatiquement par un logiciel qui calcule les glucides. Critères remplis : données de santé, personnes vulnérables (patients), usage innovant (analyse automatique), suivi systématique. Avec quatre critères, une analyse d'impact est nécessaire avant le lancement. Elle décrit le traitement, évalue sa nécessité et sa proportionnalité, identifie les risques (fuite, erreur de calcul, accès par des tiers) et prévoit des mesures pour les réduire. L'hébergement des données de santé doit en outre être confié à un hébergeur certifié pour les données de santé (HDS).

Astuce – Le réflexe « minimisation » en trois questions

Avant d'ajouter une question à un questionnaire, demandez-vous : 1. Vais-je réellement utiliser cette réponse dans mon analyse ? 2. Puis-je obtenir la même information sous une forme moins précise (tranche d'âge plutôt que date de naissance, quartier plutôt qu'adresse) ? 3. Cette question peut-elle mettre la personne mal à l'aise ou la désigner ? Si la réponse à la première question est « non », supprimez la question.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.12

Transformez ces questions pour respecter la minimisation : a) « Date de naissance » ; b) « Adresse complète » ; c) « Poids et taille » dans un questionnaire de satisfaction sur des ateliers cuisine ; d) « Revenus exacts du foyer ».

Corrigé

a) « Tranche d'âge : moins de 25 ans, 25 à 44 ans, 45 à 64 ans, 65 ans et plus. » b) « Quartier » ou commune, seulement si l'analyse par quartier est prévue. c) Supprimer : ces données de santé sont inutiles pour évaluer la satisfaction. d) Supprimer, ou remplacer par une question facultative en grandes tranches (« Votre budget alimentaire par semaine : moins de 50 €, 50 à 100 €, plus de 100 € ») si l'analyse en a besoin.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.5 – Le RGPD

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez quatre des six bases légales de l'article 6 du RGPD.

2. Pourquoi le consentement n'est-il pas une base valable pour une enquête imposée par un employeur ?
3. Quelle différence y a-t-il entre pseudonymisation et anonymisation ?
4. Dans quel délai une violation de données doit-elle être notifiée à la CNIL ?
5. Une violation est découverte le mardi à 10 h. Quelle est la date limite de notification ?
6. Citez trois critères qui peuvent rendre une analyse d'impact obligatoire.

Corrigé – Point d'étape 6.3.5

1. Consentement, contrat, obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux, mission d'intérêt public, intérêt légitime.
2. Le salarié n'est pas vraiment libre de refuser, son consentement n'est donc pas libre.
3. Les données pseudonymisées restent personnelles, car on peut retrouver la personne avec la table de correspondance ; les données anonymisées ne permettent plus aucune réidentification.
4. 72 heures après en avoir pris connaissance.
5. Le vendredi à 10 h.
6. Données sensibles, personnes vulnérables, grande échelle, croisement de données, usage innovant, suivi systématique.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.6.
3 ou 4 sur 6	Je relis les bases légales et la partie sur la sécurité.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.5 et je refais les exercices d'application.

6.3.6 Le consentement et le droit à l'image

Module · Référentiel : C3.1, C3.5 · CNED : Essentiels M1 S6 §2.1 et §2.2 (p. 22 et 23)

Le consentement à participer

Participer à une action de santé publique est **libre** : on informe des objectifs, du déroulement, des éventuelles dégustations (allergènes), de l'usage des données ; on recueille un accord (souvent oral pour un atelier, écrit pour une enquête ou des photos). La personne peut se **retirer** à tout moment sans conséquence (elle garde l'accès aux autres services de la structure). Pour un **mineur**, l'accord des **titulaires de l'autorité parentale** est recherché, mais l'avis de l'enfant compte aussi (assentiment).

Attention – Recherche ou évaluation ?

Un questionnaire d'évaluation d'un atelier n'est pas une **recherche impliquant la personne humaine** au sens de la loi Jardé (loi du 5 mars 2012). Si l'objectif devient la production de **connaissances généralisables** (publication scientifique), un avis d'un **comité de protection des personnes** (CPP) peut être requis : demander conseil à l'équipe pédagogique.

Le droit à l'image

Définition – Droit à l'image

Chaque personne a le droit de s'opposer à la prise et à la diffusion de son image sans son autorisation, sur le fondement du respect de la **vie privée** (article **9 du Code civil**). Capter ou diffuser l'image d'une personne dans un lieu privé sans son consentement est puni par l'article 226-1 du Code pénal.

Élément de l'autorisation	Contenu attendu
Identité	Nom de la personne photographiée (et des représentants légaux pour un mineur)
Objet	Contexte de la prise de vue (atelier du 15 mars 2028)
Supports	Affiche, rapport de stage, dossier E5, site du centre social, réseaux sociaux (cocher chaque case séparément)
Durée et territoire	Durée de l'autorisation (exemple : 2 ans), lieu de diffusion
Gratuité	Mention de l'absence de rémunération
Retrait	Possibilité de retirer l'autorisation à tout moment pour l'avenir
Signature	Datée, par la personne majeure ou par les deux titulaires de l'autorité parentale pour un mineur (avec l'avis de l'enfant)

Astuce – Photos sans visage

Pour illustrer un dossier E5, privilégier des photos de **mains**, de **plats**, de **supports** ou de dos : on limite les risques, tout en conservant des preuves de l'action. Floutez les visages si l'autorisation manque.

Les quatre qualités d'un consentement valable

Le RGPD (article 4 et article 7) définit précisément ce qu'est un consentement valable. Ces exigences s'appliquent à l'utilisation de données et de photos ; elles sont aussi un bon repère pour la participation à une action.

Qualité	Ce que cela veut dire	Exemple conforme	Exemple non conforme
Libre	La personne peut refuser sans subir de conséquence	« Vous pouvez participer à l'atelier sans être photographié »	« Les photos sont obligatoires pour participer »
Spécifique	Un accord distinct pour chaque usage	Cases séparées : affiche, site, réseaux sociaux	Une seule case « j'accepte tout »
Éclairé	La personne sait qui, quoi, pourquoi, combien de temps, et ses droits	Note d'information claire, lue ou expliquée à l'oral	Formulaire juridique de deux pages en petits caractères
Univoque	Un acte positif clair	Case cochée par la personne, signature	Case cochée à l'avance, silence, inaction

Le consentement doit aussi être **retirable** à tout moment, aussi simplement qu'il a été donné, et la structure doit pouvoir **prouver** qu'il a été recueilli (formulaire signé, trace d'inscription).

Définition – Âge du consentement numérique en France

Pour l'inscription à des services en ligne (réseaux sociaux, applications) qui reposent sur le consentement, la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles a fixé l'âge du consentement à **15 ans** en France. En dessous, le consentement conjoint du mineur et du ou des titulaires de l'autorité parentale est nécessaire. Pour un projet qui propose une application ou un compte en ligne à des collégiens, il faut donc prévoir l'accord des parents.

Méthode pas à pas – Recueillir un consentement à l'oral dans un atelier

Pour les personnes qui lisent peu, le consentement peut être expliqué à l'oral, puis confirmé par une signature ou une croix devant témoin.

1. Dire le but : « Nous aimerions prendre quelques photos des plats et des mains pour l'affiche du centre social. »

2. Dire les usages : « L'affiche sera dans le hall pendant un an. Il n'y aura pas de photo sur internet. »

3. Dire la liberté : « Vous pouvez dire non, cela ne change rien pour l'atelier. Vous pouvez changer d'avis plus tard. »

4. Vérifier la compréhension : « Pouvez-vous me redire où la photo sera affichée ? » (le « faire dire », chapitre 5).

5. Recueillir l'accord : formulaire simplifié avec pictogrammes, signé ou marqué d'une croix.

6. Respecter le refus : signe discret (pastille sur le badge) pour que le photographe évite la personne.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.13

Un formulaire d'inscription à un atelier comporte la phrase suivante, avec une case déjà cochée : « J'accepte que mes données et mon image soient utilisées par l'association et ses partenaires. » Relevez quatre défauts au regard des qualités du consentement, puis réécrivez la partie du formulaire.

Corrigé

Défauts : la case est pré-cochée (consentement non univoque) ; données et image sont mélangées (non spécifique) ; les usages et les partenaires ne sont pas précisés (non éclairé) ; le lien avec l'inscription laisse penser que l'accord est obligatoire (non libre) ; rien n'est dit sur le retrait. Réécriture : « Photos (facultatif, cela ne change rien à votre inscription). J'accepte d'être photographié pendant l'atelier pour : [ ] l'affiche dans le hall du centre social ; [ ] le site internet du centre social ; [ ] le compte du centre social sur les réseaux sociaux. Durée : deux ans. Je peux retirer mon accord à tout moment auprès de l'accueil. Mes coordonnées ne sont transmises à aucun partenaire. »

Droit à l'image : cas particuliers et évolutions récentes

Le principe est simple : il faut l'**autorisation** de la personne pour capter et diffuser son image dès qu'elle est **reconnaissable**. Les tribunaux admettent quelques limites à ce principe, mais elles s'appliquent rarement aux actions de santé publique.

Situation	Autorisation nécessaire ?	Commentaire
Photo d'un atelier où l'on reconnaît les participants	Oui, de chaque personne reconnaissable	Autorisation écrite et spécifique pour chaque support
Vue d'ensemble d'une foule lors d'un forum public, sans personne isolée ou cadrée	En principe non	Dès qu'une personne est isolée ou mise en avant, il faut son accord
Personne photographiée de dos, sans signe distinctif	En principe non	Attention aux vêtements, tatouages ou lieux qui permettent de la reconnaître
Élu ou personnalité lors de l'inauguration publique du projet	Non pour l'information sur l'événement	L'image ne doit pas être détournée (publicité, montage)
Photo d'un enfant	Oui, accord des deux titulaires de l'autorité parentale et avis de l'enfant selon son âge	Loi du 19 février 2024 sur le droit à l'image des enfants
Image modifiée ou créée par intelligence artificielle à partir du visage d'une personne	Oui, et la diffusion sans accord d'un montage qui n'apparaît pas comme tel est sanctionnée	Article 226-8 du Code pénal, complété par la loi du 21 mai 2024 (sécurisation de l'espace numérique)

Définition – Le droit à l'image des enfants (loi du 19 février 2024)

Cette loi a inscrit dans le Code civil que les parents protègent **ensemble** le droit à l'image de leur enfant mineur, en l'associant selon son âge et son degré de maturité. En cas de désaccord entre les parents, le juge peut interdire à l'un d'eux de diffuser des images sans l'accord de l'autre. Elle rappelle que l'image d'un enfant relève de sa **vie privée**, y compris lorsqu'elle est publiée par ses propres parents.

Attention – Les images de corps et le « avant/après »

Même avec l'accord de la personne, la diffusion d'images de silhouettes « avant et après » une perte de poids pose un problème éthique : elle centre le message sur l'apparence, renforce la stigmatisation du poids et peut inciter des personnes vulnérables à des régimes dangereux. Une action de santé publique valorise plutôt les **comportements** (cuisiner, bouger, partager un repas) et le **plaisir**.

Combien de temps garder les photos ?

L'autorisation précise une **durée**. À la fin de cette durée, les images doivent être retirées des supports et supprimées des archives, sauf nouvelle autorisation. En pratique, on tient un **tableau de suivi** des photos : date, personnes représentées, supports autorisés, date de fin, date de retrait d'un accord éventuel.

Exemple – Calcul de la fin d'une autorisation

Photos prises lors d'un atelier le 22 mars 2027, autorisation « pour deux ans à compter de la prise de vue ». Date de fin : **22 mars 2029**. Une participante retire son accord le 10 janvier 2028 : ses photos sont retirées du site internet dès que possible et ne sont plus utilisées pour l'avenir ; l'affiche déjà imprimée et retirée du hall n'est pas réimprimée.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.14

Pour chaque photo prévue lors d'un forum santé en plein air, dites si une autorisation est nécessaire : a) une vue large du forum avec une centaine de visiteurs ; b) un gros plan d'une mère et de son enfant qui goûtent une soupe ; c) le maire qui coupe le ruban d'inauguration ; d) une photo de la mère et de l'enfant transformée par une application en dessin animé pour l'affiche de l'an prochain.

Corrigé

a) En principe non, si aucune personne n'est isolée ou mise en avant. b) Oui : autorisation de la mère et des deux titulaires de l'autorité parentale pour l'enfant, avec son avis selon son âge. c) Non pour illustrer l'événement ; l'image ne doit pas être détournée. d) Oui : même transformée, l'image reste celle de personnes reconnaissables, et la nouvelle utilisation (affiche de l'année suivante) doit être prévue dans l'autorisation.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.6 – Consentement et droit à l'image

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les quatre qualités d'un consentement valable selon le RGPD.
2. Une case pré-cochée constitue-t-elle un consentement ? Justifiez.
3. À quel âge un mineur peut-il consentir seul à l'utilisation de ses données par un service en ligne en France ?
4. Que prévoit la loi du 19 février 2024 ?
5. Pourquoi les images « avant/après » posent-elles un problème même avec l'accord de la personne ?
6. Une autorisation de trois ans est signée le 5 mai 2027. Quelle est sa date de fin ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.6

1. Libre, spécifique, éclairé, univoque.
2. Non : le consentement doit résulter d'un acte positif clair de la personne.
3. 15 ans.
4. Les deux parents protègent ensemble le droit à l'image de leur enfant mineur, en l'associant selon son âge et sa maturité.
5. Elles centrent le message sur l'apparence, renforcent la stigmatisation du poids et peuvent inciter à des régimes dangereux.
6. Le 5 mai 2030.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.7.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des qualités du consentement et celui des cas particuliers.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.6 et je refais les exercices d'application.

6.3.7 Les conflits d'intérêts

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Définition – Conflit d'intérêts

Situation dans laquelle un **intérêt secondaire** (financier, professionnel, personnel) est susceptible d'influencer, ou de **paraître** influencer, le jugement d'un professionnel dans l'exercice de sa mission (**intérêt primaire** : la santé des personnes). Le lien d'intérêts n'est pas une faute en soi ; c'est son **absence de déclaration** et de **gestion** qui pose problème.

Situation	Analyse et gestion
Une marque de yaourts propose de financer les ingrédients d'un atelier en échange de son logo sur l'affiche	Risque de publicité et de perte d'indépendance ; refuser ou négocier : financement sans logo ni produit de marque, convention écrite, mention transparente du soutien, contenu décidé seul par le diététicien
Un fabricant de lait infantile offre des échantillons pour un atelier parents	À refuser : contraire au Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (OMS, 1981), qui interdit la promotion auprès du public et des professionnels
Un supermarché local offre un bon d'achat aux participants	Acceptable si aucun produit n'est promu dans les messages, avec transparence ; préférer un partenariat avec l'épicerie solidaire ou le marché
Le diététicien a un cabinet et anime un atelier municipal	Ne pas faire la promotion de son cabinet pendant l'atelier ; donner une liste de plusieurs professionnels
Une association de producteurs fournit des supports pédagogiques	Vérifier l'exactitude et la neutralité ; citer la source ; préférer les supports institutionnels (Santé publique France)

Lien diététique – La transparence des liens d'intérêts

La loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé (dite « loi Bertrand ») impose la publication des avantages et conventions entre les industries de santé et les professionnels de santé sur la base publique **Transparence Santé**. Les experts des agences (ANSES, HAS) remplissent une **déclaration publique d'intérêts**. Dans un projet, le diététicien peut appliquer la même logique : déclarer par écrit les partenariats et leur contenu.

Avantages, cadeaux et transparence : les règles

Deux dispositifs du Code de la santé publique encadrent les relations entre les professionnels de santé, dont les diététiciens, et les entreprises qui produisent ou commercialisent des produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux et autres produits listés par le Code de la santé publique). Pour les autres entreprises (agroalimentaire, compléments alimentaires), ces textes ne s'appliquent pas toujours, mais la déontologie conduit aux mêmes réflexes.

Dispositif	Principe	Ce que cela change pour le diététicien
Encadrement des avantages (dit « loi anti-cadeaux », 1993, refondu en 2017)	Les entreprises ne peuvent pas offrir d'avantages aux professionnels de santé, y compris aux étudiants qui se destinent à ces professions, sauf exceptions encadrées (rémunération d'une activité réelle, hospitalité raisonnable lors d'un congrès, dons pour la recherche) déclarées ou autorisées	Refuser les cadeaux, repas ou voyages offerts par un laboratoire en dehors de ce cadre
Transparence des liens (loi du 29 décembre 2011)	Les entreprises publient les conventions, les rémunérations et les avantages accordés aux professionnels, à partir de 10 €	Les liens du diététicien avec ces entreprises sont consultables par tous sur la base Transparence Santé

Ces règles ne sont pas une marque de méfiance envers les professionnels. Elles reposent sur un constat : même un petit cadeau crée un sentiment de **réciprocité** qui peut influencer le jugement, souvent sans que la personne en ait conscience.

Définition – Biais de réciprocité

Tendance à vouloir rendre ce que l'on a reçu. Un professionnel qui a reçu un échantillon, un repas ou un objet d'une marque aura tendance, sans le vouloir, à percevoir plus favorablement ses produits. C'est pourquoi la déontologie recommande de refuser les petits avantages et de déclarer tous les liens.

Méthode pas à pas – Gérer une sollicitation d'une entreprise

1. Identifier : qui propose quoi, en échange de quoi ? Quel est l'intérêt de l'entreprise ?

2. Vérifier le cadre : la proposition entre-t-elle dans les exceptions autorisées ? Faut-il une convention, une déclaration ?

3. Évaluer l'effet : le public pourrait-il penser que mes conseils sont influencés ? Le produit serait-il mis en avant ?

4. Décider : refuser, ou accepter sous conditions (convention écrite, absence de promotion, contenu choisi par moi).

5. Déclarer : mentionner le lien en début d'intervention, dans la déclaration d'intérêts et auprès de l'employeur.

6. Tracer : garder une copie de la convention et des échanges.

Exemple – Une invitation à un congrès

Un laboratoire pharmaceutique invite une diététicienne hospitalière à un congrès à l'étranger, transport et hôtel payés. Ce type d'hospitalité doit faire l'objet d'une convention entre l'entreprise et la professionnelle, soumise selon le montant à une déclaration ou à une autorisation préalable de l'instance compétente, et rester d'un niveau raisonnable, strictement lié à l'objet scientifique. La diététicienne informe son employeur.

L'avantage est ensuite rendu public sur la base Transparence Santé. Si elle intervient plus tard dans une formation sur la dénutrition, elle mentionne ce lien.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.15

Pour chaque proposition faite à une étudiante en BTS Diététique et nutrition, dites si elle peut l'accepter et à quelles conditions : a) un stylo et un carnet au logo d'un fabricant de lait infantile lors d'un salon ; b) un repas gratuit offert par un laboratoire pharmaceutique après une présentation de produits ; c) une rémunération pour animer un atelier dans une pharmacie, sur un thème choisi par elle, sans promotion de produits.

Corrigé

a) À refuser : avantage offert par une entreprise de produits de santé, et le Code international de l'OMS (1981) déconseille tout cadeau promotionnel des fabricants de substituts du lait maternel aux professionnels. b) À refuser : avantage sans contrepartie professionnelle réelle, interdit par l'encadrement des avantages, qui s'applique aussi aux étudiants. c) Possible : rémunération d'une activité réelle, avec une convention écrite, une liberté totale sur le contenu, aucune promotion et la mention du lien si elle intervient ensuite sur des sujets proches.

Le financement de la recherche en nutrition : un risque de biais

Les recommandations nutritionnelles reposent sur des études scientifiques. Or une partie de ces études est financée par des entreprises qui ont un intérêt commercial dans leurs résultats. Plusieurs travaux ont montré que ce financement est associé à des **conclusions plus favorables** aux produits de l'entreprise.

- En 2007, une analyse d'articles sur les boissons (sodas, jus, lait) publiée dans la revue *PLoS Medicine* (Lesser et al.) a montré que les articles entièrement financés par l'industrie avaient environ **quatre à huit fois plus de chances** d'aboutir à une conclusion favorable aux produits que les articles sans financement industriel.
- En 2016, des historiens ont publié dans la revue *JAMA Internal Medicine* (Kearns, Schmidt et Glantz) des documents montrant qu'une organisation de l'industrie sucrière avait financé, dans les années 1960, une revue scientifique qui minimisait le rôle du sucre dans les maladies cardiovasculaires et mettait l'accent sur les graisses, sans que ce financement soit déclaré.

Ces exemples ne signifient pas que toute étude financée par l'industrie est fausse. Ils montrent que le **financement doit être déclaré** et pris en compte dans la lecture critique.

Méthode pas à pas – Lire une étude de façon critique (financement et intérêts)

1. Qui a financé l'étude ? Chercher la rubrique « financement » (*funding*) en fin d'article.

2. Les auteurs ont-ils des liens d'intérêts ? Rubrique « conflits d'intérêts » (*competing interests*).

3. Le financeur a-t-il participé à la conception, à l'analyse ou à la rédaction ? Les bonnes revues l'exigent dans la déclaration.

4. Les résultats concordent-ils avec ceux d'autres études indépendantes ? Une étude isolée ne suffit pas à changer une recommandation.

5. Qui diffuse le résultat ? Un communiqué de presse d'une marque n'est pas une source scientifique.

Lien diététique – Pourquoi s'appuyer sur les avis des agences

Les avis de l'Anses, de l'EFSA ou du Haut Conseil de la santé publique reposent sur l'analyse de **l'ensemble des études** disponibles par des groupes d'experts qui déclarent publiquement leurs liens d'intérêts. Ils sont donc moins exposés au biais d'une étude isolée. Pour un support d'atelier, ce sont les sources à privilégier, avec la date de l'avis.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.16

Un participant vous montre un article de presse : « Une étude prouve que manger des céréales au chocolat chaque matin améliore la concentration des enfants. » L'étude, menée sur 40 enfants pendant deux semaines, a été financée par un fabricant de céréales. Rédigez trois questions critiques et une réponse adaptée au participant.

Corrigé

Questions : Qui a financé l'étude et a-t-il participé à l'analyse ? L'effectif (40 enfants) et la durée (deux semaines) permettent-ils une conclusion générale ? À quoi les céréales au chocolat ont-elles été comparées (absence de petit déjeuner ou autre petit déjeuner) ? D'autres études indépendantes trouvent-elles le même résultat ? Réponse : « Cette étude est petite et courte, et elle a été financée par le fabricant. Ce qu'on sait de façon solide, c'est qu'un petit déjeuner aide beaucoup d'enfants à tenir la matinée. Il peut être varié : pain, produit laitier, fruit. Les céréales au chocolat peuvent en faire partie de temps en temps. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.7 – Les conflits d'intérêts

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Les étudiants sont-ils concernés par l'encadrement des avantages ?
2. À partir de quel montant les avantages accordés à un professionnel de santé sont-ils publiés sur Transparence Santé ?
3. Qu'est-ce que le biais de réciprocité ?
4. Citez les six étapes de la gestion d'une sollicitation d'une entreprise.
5. Qu'a montré l'analyse publiée en 2007 dans *PLoS Medicine* sur les études concernant les boissons ?
6. Pourquoi privilégier les avis des agences sanitaires plutôt qu'une étude isolée ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.7

1. Oui, les étudiants qui se destinent aux professions de santé sont concernés.
2. À partir de 10 €.
3. La tendance à vouloir rendre ce que l'on a reçu, qui peut influencer le jugement sans que l'on en ait conscience.
4. Identifier, vérifier le cadre, évaluer l'effet, décider, déclarer, tracer.
5. Les articles financés par l'industrie avaient environ quatre à huit fois plus de chances de conclure en faveur des produits.
6. Ils analysent l'ensemble des études disponibles, par des experts qui déclarent leurs liens d'intérêts.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.8.
3 ou 4 sur 6	Je relis la méthode de gestion d'une sollicitation et la partie sur la recherche.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.7 et je refais les exercices d'application.

6.3.8 Une démarche de réflexion éthique

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

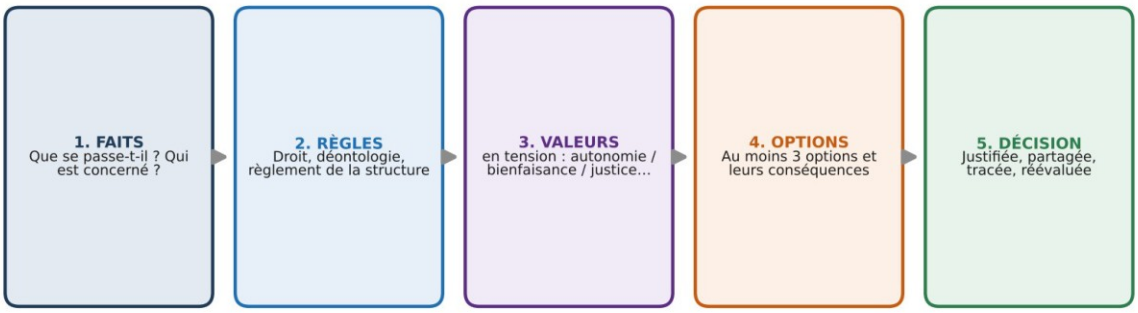


Figure 6.5 – Cinq étapes pour analyser un dilemme éthique

Comprendre le schéma – Figure 6.5

1. Faits : décrire la situation sans jugement ; qui est concerné, qu'est-ce qui pose question ?

2. Règles : qu'imposent le droit (secret, RGPD, droit à l'image), la déontologie, le règlement de la structure ?

3. Valeurs en tension : quels principes s'opposent (autonomie contre bienfaisance, justice contre efficacité) ?

4. Options : envisager au moins **trois** réponses possibles et leurs conséquences pour chaque personne concernée.

5. Décision : choisir l'option la plus juste, la **justifier**, la **partager** (tutrice, équipe), la **tracer** (journal de bord) et la réévaluer. Les situations complexes peuvent être portées devant un **espace de réflexion éthique régional** (ERER) ou le comité d'éthique d'un établissement ; au niveau national, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE, créé en 1983) rend des avis.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.17

Une mère demande à Inès de « peser tous les enfants » de l'atelier goûters « pour qu'on sache lesquels sont trop gros ». Analysez la situation avec la grille en 5 étapes.

Corrigé

Faits : demande d'une mère ; enfants de 6 à 10 ans ; atelier collectif. **Règles** : données de santé (RGPD, consentement des deux parents), secret, l'atelier n'est pas une consultation. **Valeurs** : bienfaisance (s'inquiéter de la santé des enfants) contre non-malfaisance (stigmatisation, comparaison entre enfants) et autonomie (consentement des autres familles). **Options** : a) peser en public (rejetée : stigmatisant) ; b) refuser sans explication (rejetée : la préoccupation est légitime) ; c) expliquer pourquoi on ne pèse pas en atelier et orienter vers le médecin traitant ou la PMI/la santé scolaire pour le suivi de la courbe de corpulence. **Décision** : option c, en accord avec la tutrice, notée dans le journal de bord ; l'atelier reste centré sur le plaisir et les goûters.

Une analyse complète rédigée avec la grille en cinq étapes

L'exemple suivant montre le niveau de rédaction attendu à l'épreuve E5 pour une question du type « Analysez cette situation sur le plan éthique et proposez une conduite à tenir ».

Exemple – Les dons de viennoiseries à l'épicerie solidaire

Situation (fictive) : une épicerie solidaire reçoit chaque semaine d'un supermarché environ 60 kg de viennoiseries et de gâteaux arrivés à date limite. Une bénévole propose de les refuser : « On ne va pas donner du sucre aux pauvres. » Une autre répond : « Les familles adorent ça, et sinon ce sera jeté. » La responsable

vous demande votre avis.

1. Faits : 60 kg de produits sucrés et gras par semaine, gratuits, déjà produits ; des familles en situation de précarité, qui choisissent leurs produits ; un risque de gaspillage ; deux bénévoles en désaccord.

2. Règles : la loi du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire oblige les grandes surfaces à proposer leurs invendus encore consommables à des associations ; l'article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles demande une aide alimentaire diversifiée, de qualité, et respectueuse de la dignité ; les règles d'hygiène imposent de respecter les dates et la chaîne du froid.

3. Valeurs en tension : bienfaisance (une alimentation favorable à la santé) contre autonomie (le libre choix des familles) ; justice (les familles modestes ont droit, comme les autres, au plaisir des viennoiseries) contre non-malfaisance (une offre très sucrée en grande quantité) ; lutte contre le gaspillage.

4. Options :

- a) Refuser tous ces dons : protège peut-être la santé, mais prive les familles d'un plaisir, traite les adultes comme incapables de choisir et augmente le gaspillage ;
- b) Tout accepter et tout mettre en rayon sans limite : respecte le choix, mais l'offre devient déséquilibrée et peut remplacer d'autres produits ;
- c) Accepter, proposer ces produits en libre choix avec une quantité raisonnable par passage, et redistribuer le surplus (accueils de jour, maraudes) ; parallèlement, négocier avec le supermarché des dons de fruits, de légumes et de produits laitiers, et proposer un atelier « goûters maison » sans obligation.

5. Décision : l'option c respecte l'autonomie et la dignité des familles, limite le gaspillage, et agit sur l'offre plutôt que sur les personnes. Elle est présentée à la responsable et aux bénévoles, inscrite au compte rendu de réunion, et évaluée au bout de trois mois (quantités distribuées, retours des familles, produits frais obtenus).

Méthode pas à pas – Rédiger une réponse éthique à l'écrit

1. Une phrase d'introduction qui nomme le dilemme : « Cette situation oppose le respect du choix des familles et la volonté de proposer une alimentation favorable à la santé. »

2. Un paragraphe par étape, avec un titre court (Faits, Règles, Valeurs, Options, Décision).

3. Des principes nommés (autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice) et des **textes datés** quand ils existent.

4. Au moins trois options, chacune avec un avantage et une limite.

5. Une décision justifiée par les principes, avec les modalités pratiques (qui, quand, comment) et une évaluation.

6. Une phrase de conclusion qui rappelle le partage de la décision avec l'équipe.

Astuce – Les connecteurs utiles pour argumenter

Pour opposer : « cependant », « en revanche », « à l'inverse ». Pour justifier : « en effet », « car », « puisque ». Pour conclure : « c'est pourquoi », « ainsi », « en conséquence ». Pour nuancer : « dans la mesure où », « à condition que », « sauf si ». Une argumentation éthique se reconnaît souvent à ses nuances.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.18

Un restaurant d'entreprise veut retirer la salière des tables sans prévenir les salariés. Rédigez la phrase d'introduction qui nomme le dilemme, puis les trois options avec un avantage et une limite pour chacune.

Corrigé

Introduction : « Cette situation oppose la réduction de la consommation de sel, utile pour la santé cardiovasculaire, et le respect de l'information et du choix des salariés. » Options : a) retirer les salières sans prévenir : peut réduire le sel ajouté, mais manque de transparence et risque de rejet ; b) laisser les salières et ne rien faire : respecte le choix, mais ne change rien ; c) réduire le sel dans les recettes progressivement, laisser une salière disponible au comptoir plutôt que sur chaque table, et expliquer la démarche par une affiche : réduit le sel tout en restant transparent et réversible, mais demande une concertation avec le chef cuisinier.

Les lieux de la réflexion éthique

Le professionnel n'est pas seul face à un dilemme. Plusieurs lieux permettent de partager la réflexion, du plus proche au plus institutionnel.

Niveau	Lieu	Rôle
Équipe	Réunion d'équipe, analyse de pratique, supervision	Discuter de situations vécues, prendre du recul, construire des réponses communes
Établissement	Comité ou espace de réflexion éthique d'un hôpital ou d'un établissement médico-social	Rendre des avis sur des situations complexes ou des questions générales (alimentation en fin de vie, contention, refus de soins)
Région	Espace de réflexion éthique régional (ERER)	Former, documenter, organiser des débats, soutenir les comités locaux
National	Comité consultatif national d'éthique (CCNE), créé en 1983	Rendre des avis publics sur les grandes questions éthiques de la biologie, de la médecine et de la santé ; organiser les états généraux de la bioéthique

Les avis de ces instances sont **consultatifs** : ils éclairent la décision, mais la responsabilité reste aux professionnels et aux personnes concernées.

Le journal de bord : tracer pour apprendre

Tenir un **journal de bord** des situations difficiles aide à prendre du recul et montre, à l'épreuve, que l'on a su mener une réflexion éthique. Il ne contient **aucune donnée identifiante** : on désigne les personnes par leur rôle (« une participante », « le père d'un enfant »).

Rubrique	Contenu (exemple)
Date et contexte	12 mars 2027, atelier cuisine parents-enfants, 8 participants
Situation	Un père a refusé que son fils goûte la recette contenant du porc, sans l'expliquer
Ce que j'ai fait	Proposé une variante sans porc préparée à part, sans commentaire devant le groupe
Principes en jeu	Respect des convictions, non-discrimination, sécurité (contamination croisée), discrétion
Ce que j'en retiens	Prévoir une variante dans chaque recette et le dire dès l'inscription
Avec qui j'en ai parlé	Ma tutrice, le 13 mars

Lien diététique – L'analyse de pratique en formation

En formation, l'analyse de pratique consiste à présenter une situation vécue en stage devant un petit groupe, avec un animateur, en respectant la confidentialité. Le groupe pose des questions pour comprendre, puis propose d'autres lectures de la situation. Cet exercice entraîne directement aux questions de l'épreuve E5 qui demandent de justifier une posture professionnelle.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.19

Rédigez une entrée de journal de bord pour la situation suivante, sans aucune donnée identifiante : pendant un atelier en EHPAD, une résidente vous a dit qu'elle ne mangeait plus le soir car « personne ne l'aide à couper sa viande ».

Corrigé

Date et contexte : atelier « plaisir de manger », 6 résidents. Situation : une résidente dit ne plus manger le soir faute d'aide pour couper sa viande. Ce que j'ai fait : je l'ai remerciée, je lui ai demandé si elle acceptait que j'en parle à l'équipe soignante ; elle a accepté ; j'ai transmis l'information à l'infirmière coordinatrice le jour même. Principes en jeu : bienfaisance (risque de dénutrition), autonomie (son accord), dignité (aide au repas), secret partagé. Ce que j'en retiens : demander systématiquement l'aide nécessaire au repas lors des ateliers ; proposer des textures adaptées. Avec qui j'en ai parlé : ma tutrice et l'infirmière coordinatrice.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.8 – La démarche de réflexion éthique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez dans l'ordre les cinq étapes de la grille.
2. Combien d'options faut-il envisager au minimum, et pourquoi ?
3. Que prévoit la loi du 11 février 2016 pour les grandes surfaces ?
4. Quelle est la différence entre un comité d'éthique d'établissement et le CCNE ?
5. Pourquoi un journal de bord ne doit-il contenir aucune donnée identifiante ?
6. Citez deux connecteurs pour nuancer une argumentation.

Corrigé – Point d'étape 6.3.8

1. Faits, règles, valeurs en tension, options, décision.
2. Au moins trois, pour éviter un choix binaire (tout accepter ou tout refuser) et trouver une solution plus juste.
3. Elles doivent proposer leurs invendus encore consommables à des associations d'aide alimentaire.
4. Le comité d'établissement rend des avis sur des situations ou des questions locales ; le CCNE rend des avis publics nationaux sur les grandes questions éthiques.
5. Il pourrait être lu par d'autres personnes : il doit respecter le secret et le RGPD.
6. « Dans la mesure où », « à condition que », « sauf si ».

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.9.
3 ou 4 sur 6	Je relis l'exemple rédigé et la méthode de rédaction.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.8 et je refais les exercices d'application.

6.3.9 Les droits des usagers et la démocratie en santé

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : Essentiels M1 S6 §1 (p. 22) ; Essentiels M1 S6 §2.1 et §2.2 (p. 22 et 23) ; Essentiels M1 S6 §2.3 (p. 23 et 24)

Les grands textes

Texte	Apports
Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), article 25	Droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, notamment pour l'alimentation
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), article 11	Droit à une nourriture suffisante et droit fondamental d'être à l'abri de la faim
Loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale	Droits des personnes accueillies en établissement social ou médico-social : livret d'accueil, contrat de séjour, conseil de la vie sociale (CVS), projet personnalisé ; charte des droits et libertés de la personne accueillie (2003)
Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades	Information, consentement, accès au dossier, secret ; représentation des usagers dans les instances de santé
Loi EGalim (2018), article L. 266-1 du Code de l'action sociale et des familles	La lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité, dans des conditions qui respectent leur dignité et développent leur capacité à agir
Loi de modernisation de notre système de santé (2016)	Renforcement de la démocratie sanitaire : conseils territoriaux de santé, médiation en santé

Définition – Démocratie en santé

Démarche qui associe les usagers, les citoyens et leurs représentants à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de santé, à travers des instances (conférences régionales de la santé et de l'autonomie, conseils territoriaux de santé, commissions des usagers à l'hôpital, conseils de la vie sociale dans les établissements médico-sociaux) et des démarches participatives.

Lien diététique – Ce que cela change pour un projet en établissement

Dans un EHPAD, un foyer ou un établissement pour personnes handicapées, un projet sur les repas gagne à être présenté au **conseil de la vie sociale** (représentants des résidents, des familles et du personnel), qui donne son avis sur l'organisation de la vie quotidienne, dont la restauration. C'est une exigence de respect des droits et un gage d'adhésion.

Attention – Dignité et aide alimentaire

La définition de la lutte contre la précarité alimentaire (EGalim) insiste sur la **dignité** et la **capacité à agir** : choix des produits (épiceries solidaires plutôt que colis imposés), participation financière symbolique quand c'est possible, accueil sans jugement, participation des bénéficiaires. Un atelier culinaire dans une structure d'aide alimentaire respecte ces principes : pas de leçon, valorisation des savoir-faire, liberté de participer.

Personne de confiance, directives anticipées et alimentation en fin de vie

Les droits des personnes malades prennent une importance particulière quand une personne ne peut plus exprimer sa volonté. Trois dispositifs du Code de la santé publique permettent de respecter son **autonomie** même dans cette situation.

Dispositif	Définition	Lien avec l'alimentation
Personne de confiance (loi du 4 mars 2002, élargie en 2015 au secteur médico-social)	Personne désignée par écrit (parent, proche, médecin traitant) qui accompagne le patient et témoigne de sa volonté s'il ne peut plus l'exprimer	Elle peut rappeler ce que la personne aimait, refusait ou souhaitait (convictions, goûts, volonté de ne plus être alimentée artificiellement)
Directives anticipées (loi du 22 avril 2005, renforcées par la loi du 2 février 2016)	Volontés écrites d'une personne majeure sur sa fin de vie, en particulier sur la poursuite, la limitation ou l'arrêt des traitements	Elles peuvent préciser le refus d'une nutrition artificielle (sonde, perfusion)
Procédure collégiale	Concertation de l'équipe soignante, avec avis d'un médecin extérieur, avant de limiter ou d'arrêter un traitement quand la personne ne peut pas s'exprimer	Elle porte sur la nutrition et l'hydratation artificielles, considérées comme des traitements

La loi du 2 février 2016 (dite loi Claeys-Leonetti) précise que la **nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements**. Elles peuvent donc être limitées ou arrêtées lorsqu'elles apparaissent inutiles, disproportionnées ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, en respectant la volonté du patient ou, s'il ne peut l'exprimer, après une procédure collégiale. Les **soins de confort** (soins de bouche, petites quantités d'aliments plaisir proposés si la personne le souhaite) sont, eux, toujours assurés.

Attention – Ne pas confondre alimentation plaisir et nutrition artificielle

Proposer à une personne en fin de vie un yaourt, une glace ou quelques cuillères d'un plat qu'elle aime n'est pas un traitement : c'est un soin de confort qui respecte sa dignité. À l'inverse, forcer une personne à manger contre sa volonté n'est jamais acceptable. Le rôle du diététicien est d'adapter l'offre (textures, goûts, petites portions) au souhait de la personne.

Le refus alimentaire d'une personne âgée

En EHPAD ou à domicile, le refus de manger d'une personne âgée est une situation fréquente et difficile. Il peut avoir des causes **médicales** (douleur dentaire, troubles de la déglutition, dépression, effets de médicaments), **organisationnelles** (repas servis trop tôt, textures inadaptées, absence d'aide) ou exprimer une **volonté** (fin de vie, perte de sens).

Méthode pas à pas – Face à un refus alimentaire

1. Chercher une cause traitable avec l'équipe et le médecin : bouche, dents, déglutition, douleur, humeur, médicaments.

2. Adapter l'offre : plats aimés, textures, horaires, enrichissement, aide au repas, ambiance.

3. Écouter la personne : que dit-elle de son refus ? Que souhaite-t-elle ?

4. Associer la personne de confiance et la famille, sans leur transférer la décision.

5. Discuter en équipe de la conduite à tenir et la noter dans le dossier ; recourir au comité d'éthique si le désaccord persiste.

6. Respecter la volonté d'une personne capable et informée, tout en maintenant les soins de confort.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.20

M. V., 88 ans, résident d'un EHPAD, mange de moins en moins depuis un mois. Sa fille demande qu'on « le force à manger ». Indiquez trois causes à rechercher, deux adaptations de l'offre, et la réponse à faire à la fille.

Corrigé

Causes : problème dentaire ou prothèse mal adaptée, trouble de la déglutition, dépression, effet d'un médicament, douleur, constipation. Adaptations : plats qu'il aime, enrichissement des préparations, textures adaptées, fractionnement, aide au repas, horaires plus souples. Réponse : « Nous partageons votre inquiétude. Nous recherchons avec le médecin une cause qui pourrait être soignée et nous adaptons les repas à ses goûts. Forcer votre père à manger n'est pas possible : ce serait contraire à sa dignité, et cela peut être dangereux (fausse route). Nous aimerions savoir ce qu'il aimait et ce qu'il souhaitait : pouvons-nous en parler ensemble, avec lui si possible ? »

La participation des usagers à l'hôpital et dans les établissements

La démocratie en santé (6.3.9) se traduit par des instances où les usagers et leurs représentants donnent leur avis.

Instance	Où ?	Composition et rôle
Commission des usagers (CDU), qui a remplacé en 2016 la commission des relations avec les usagers	Établissements de santé	Représentants des usagers issus d'associations agréées, médiateurs, direction ; examine les plaintes et réclamations, propose des améliorations de l'accueil et de la prise en charge, y compris la restauration
Conseil de la vie sociale (CVS)	Établissements et services sociaux et médico-sociaux (EHPAD, foyers, centres d'hébergement)	Représentants des personnes accueillies, des familles et du personnel ; avis sur l'organisation de la vie quotidienne, dont les repas
Commission des menus	Restauration scolaire, EHPAD, hôpitaux (selon l'organisation)	Usagers, parents, cuisiniers, diététicien ; avis sur les menus et leur qualité
Conseil territorial de santé	Territoire de démocratie sanitaire	Élus, professionnels, usagers ; contribue au diagnostic territorial et au projet régional de santé

La **charte de la personne hospitalisée** (circulaire du 2 mars 2006) rappelle notamment le droit à une prise en charge respectueuse de la dignité et de l'intimité, et le droit d'exprimer des observations sur les soins et l'accueil, y compris sur les repas. Elle doit être affichée et remise aux patients.

Lien diététique – Les réclamations sur les repas : une source d'amélioration

Dans beaucoup d'établissements, les repas font partie des sujets de réclamation les plus fréquents (température, goût, choix, horaires). Pour un diététicien, analyser ces réclamations avec la commission des usagers est un moyen de construire un projet d'amélioration fondé sur la parole des usagers : enquête de satisfaction, test de nouvelles recettes, horaires du dîner plus tardifs, choix entre deux plats.

Exemple – Calcul : exploiter des réclamations

Sur une année, un hôpital (exemple fictif) a reçu 240 réclamations écrites, dont 54 concernent les repas. Parmi ces 54 : 23 sur la température des plats, 14 sur le goût, 11 sur l'absence de choix, 6 sur les horaires.

- Part des réclamations qui concernent les repas : 54 / 240 × 100 = **22,5 %**.
- Parmi elles, température : 23 / 54 × 100 = **42,6 %** ; goût : 14 / 54 × 100 = **25,9 %** ; choix : 11 / 54 × 100 = **20,4 %** ; horaires : 6 / 54 × 100 = **11,1 %**.

La température est la première cause : la priorité porte sur l'organisation de la distribution (chariots chauffants, délai entre la cuisine et le lit) plutôt que sur les recettes. Ces chiffres sont présentés à la

commission des usagers, qui suit l'évolution l'année suivante.

Le patient partenaire

Un **patient partenaire** (ou patient expert) est une personne qui vit avec une maladie chronique et qui, après une formation, met son expérience au service des autres patients et des équipes : co-animation d'ateliers d'éducation thérapeutique, participation à la conception de supports, formation des étudiants. Sa participation reconnaît le **savoir expérientiel** des patients, complémentaire du savoir des professionnels. Dans un projet de nutrition, il aide par exemple à vérifier qu'une fiche sur le diabète est compréhensible et réaliste.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.21

Dans un EHPAD de 80 résidents (exemple fictif), 30 résidents ou familles ont répondu à une enquête : 18 trouvent le dîner servi trop tôt (17 h 45), 9 trouvent les plats trop salés, 21 souhaitent un choix entre deux plats le soir. Calculez les pourcentages, indiquez à quelle instance présenter les résultats, et proposez une action prioritaire.

Corrigé

Dîner trop tôt : 18 / 30 = 60,0 % ; plats trop salés : 9 / 30 = 30,0 % ; souhait d'un choix : 21 / 30 = 70,0 %. Taux de réponse : 30 / 80 = 37,5 %, ce qui limite la représentativité. Instance : le conseil de la vie sociale, qui donne son avis sur l'organisation des repas, et la commission des menus. Action prioritaire : proposer un choix entre deux plats le soir et tester un dîner plus tardif (par exemple 18 h 30), en concertation avec l'équipe de cuisine et de soins ; mesurer ensuite la satisfaction et les quantités consommées.

Deux droits récents : le droit à l'oubli et l'action de groupe

- **Droit à l'oubli** (assurance des prêts) : une personne guérie d'un cancer ou d'une hépatite C n'a plus à le déclarer à l'assureur **5 ans** après la fin du protocole thérapeutique sans rechute (loi du 28 février 2022, dite loi Lemoine, applicable depuis le 1er juin 2022 ; auparavant 10 ans). La convention AERAS (« s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ») organise l'accès au crédit pour les autres maladies.
- **Action de groupe** : créée en santé par la loi du 26 janvier 2016, elle a été remplacée par un **régime unique** par la loi du 30 avril 2025 (actions introduites depuis le 2 mai 2025). En santé, elle vise les manquements d'un producteur ou d'un fournisseur de produits de santé ; une association agréée d'usagers peut agir au nom de plusieurs victimes.
- **Loi HPST** (« Hôpital, patients, santé et territoires », 21 juillet 2009) : elle crée les agences régionales de santé (ARS) et les conférences régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA), lieux d'expression des usagers.

Exemple – Le droit à l'oubli expliqué à une participante

Une participante d'un atelier, traitée pour un cancer du sein, a terminé son traitement en mars 2021 sans rechute. Pour un prêt demandé en octobre 2026, elle n'a plus à déclarer ce cancer : le délai de 5 ans est atteint en mars 2026. Le diététicien n'a pas à donner de conseil juridique, mais il peut l'orienter vers France Assos Santé ou la Ligue contre le cancer.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.9 – Droits des usagers

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quel est le rôle de la personne de confiance ?
2. Que précise la loi du 2 février 2016 sur la nutrition et l'hydratation artificielles ?
3. Proposer quelques cuillères d'un plat aimé à une personne en fin de vie est-il un traitement ?
4. Citez trois causes possibles d'un refus alimentaire chez une personne âgée.

5. Quelle instance examine les réclamations des usagers à l'hôpital ?

6. Sur 150 réclamations, 36 concernent les repas. Calculez le pourcentage.

Corrigé – Point d'étape 6.3.9

1. Accompagner le patient et témoigner de sa volonté s'il ne peut plus l'exprimer.

2. Ce sont des traitements, qui peuvent être limités ou arrêtés s'ils sont inutiles ou disproportionnés, selon la volonté du patient ou après une procédure collégiale.

3. Non, c'est un soin de confort, toujours assuré si la personne le souhaite.

4. Problème dentaire, trouble de la déglutition, dépression, médicament, douleur, textures inadaptées, absence d'aide, volonté de la personne.

5. La commission des usagers (CDU).

6. 36 / 150 × 100 = 24 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.10.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau sur la fin de vie et celui des instances.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.9 et je refais les exercices d'application.

6.3.10 La responsabilité du professionnel dans une action collective

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : Essentiels M1 S6 §2.3 (p. 23 et 24)



Figure 6.6 – Les trois formes de responsabilité

Comprendre le schéma – Figure 6.6

1. La **responsabilité civile** oblige à **réparer** un dommage causé à autrui (article 1240 du Code civil pour la faute ; 1241 pour la négligence ou l'imprudence) : il faut une faute, un dommage et un lien de causalité. Elle est couverte par l'**assurance** de responsabilité civile professionnelle (du professionnel libéral, de l'employeur pour les salariés, de l'établissement de formation et de l'organisme d'accueil pour le stagiaire, selon la convention de stage).

2. La **responsabilité pénale** sanctionne une **infraction** : blessures involontaires (une brûlure grave par négligence), mise en danger de la vie d'autrui, violation du secret professionnel (226-13), non-assistance à personne en danger.

3. La **responsabilité disciplinaire** relève de l'employeur (règlement intérieur, fiche de poste) et, pour les

professions dotées d'un ordre, de l'instance ordinale (ce n'est pas le cas des diététiciens).

4. En atelier culinaire, les risques principaux sont les **brûlures et coupures**, les **réactions allergiques** et les **toxi-infections alimentaires** : la prévention (chapitre 13 du volume 2, fiche F8) protège les participants et le professionnel.

Risque en atelier	Prévention et traçabilité
Allergie	Recueil écrit des allergies à l'inscription, affichage des 14 allergènes de chaque recette, vérification des étiquettes, variantes, protocole d'urgence et numéros d'appel (15 ou 112) affichés
Toxi-infection alimentaire collective (TIAC)	Hygiène des mains et des surfaces, chaîne du froid, cuisson à cœur, consommation rapide ou refroidissement des restes ; une TIAC (au moins deux cas groupés présentant des symptômes similaires, dont la cause peut être rapportée à une même origine alimentaire) est une maladie à déclaration obligatoire auprès de l'ARS
Brûlures, coupures	Consignes de sécurité, matériel adapté, encadrement suffisant (1 animateur pour 4 à 6 participants, davantage avec des enfants), trousse de secours
Chute, malaise	Locaux adaptés, personne formée aux premiers secours, procédure d'appel
Enfants	Autorisation parentale, présence d'un parent ou encadrement adapté, tâches adaptées à l'âge

Attention – Le statut du stagiaire

Le stagiaire agit **sous la responsabilité** de son tuteur et de la structure d'accueil, dans le cadre d'une **convention de stage** tripartite (établissement de formation, organisme d'accueil, étudiant) qui précise les assurances. Il ne réalise pas seul une activité à risque (four, enfants) sans encadrement, et il rend compte à son tuteur de tout incident.

Obligation de moyens, obligation de sécurité et assurance

Le professionnel de santé est en général tenu à une **obligation de moyens** : il doit mettre en œuvre tous les moyens conformes aux connaissances actuelles pour atteindre l'objectif, sans pouvoir garantir le résultat. Un diététicien ne peut pas promettre qu'une personne perdra du poids ou que son diabète sera équilibré ; il doit en revanche donner des conseils exacts, adaptés et prudents.

Dans certains domaines, l'obligation est plus forte. Lorsqu'on **fournit des aliments** à des personnes (buffet, dégustation, repas d'un atelier), on doit garantir qu'ils ne présentent pas de danger : c'est une obligation de **sécurité**. Une toxi-infection due à une rupture de la chaîne du froid engage donc facilement la responsabilité de l'organisateur.

Notion	Signification	Exemple
Obligation de moyens	Faire tout ce qui est raisonnablement possible, sans garantir le résultat	Conseils adaptés lors d'un atelier ; orientation vers le médecin en cas de signe d'alerte
Obligation de sécurité	Ne pas exposer les personnes à un danger	Aliments servis sains, matériel en bon état, encadrement suffisant
Faute	Manquement à une règle ou à la prudence attendue	Ne pas vérifier les allergies déclarées ; laisser des enfants seuls près d'une plaque chaude

Notion	Signification	Exemple
Aléa	Dommage qui survient sans faute	Une personne fait un malaise sans lien avec l'atelier, malgré un déroulement normal

Définition – Assurance de responsabilité civile professionnelle

Contrat qui prend en charge les conséquences financières des dommages causés à autrui dans l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est **obligatoire** pour les professionnels de santé qui exercent à titre libéral (article L. 1142-2 du Code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002). Le salarié est couvert par l'assurance de son employeur pour les actes réalisés dans le cadre de sa mission. Le stagiaire est couvert selon les clauses de sa convention de stage.

Méthode pas à pas – Préparer un atelier en réduisant les risques

1. Inscription : recueillir par écrit les allergies, les régimes, les contacts d'urgence, les autorisations parentales.

2. Recette : vérifier les 14 allergènes réglementaires, prévoir des variantes, lire les étiquettes le jour même.

3. Locaux et matériel : vérifier les plaques, les fours, les couteaux, la trousse de secours, les numéros d'urgence affichés.

4. Encadrement : calculer le nombre d'adultes nécessaires selon le public et les tâches.

5. Hygiène : lavage des mains, chaîne du froid, cuisson à cœur, glacière pour le transport.

6. Après l'atelier : noter tout incident, même léger, et en informer le responsable.

Exemple – Calcul : l'encadrement d'un atelier parents-enfants

Un atelier accueille 9 parents et 14 enfants de 6 à 10 ans. La structure prévoit un animateur pour 4 enfants lors des tâches de découpe et de cuisson, les parents restant responsables de leur propre enfant, et un animateur pour 6 adultes.

- Pour les enfants : 14 / 4 = 3,5, arrondi à l'entier supérieur : **4** adultes encadrants pendant la découpe et la cuisson.
- Pour les parents : 9 / 6 = 1,5, soit **2** animateurs.

Si les parents participent activement à côté de leur enfant, l'équipe peut s'organiser à 4 animateurs au total ; sinon, il faut prévoir des postes de cuisson réservés aux adultes. On arrondit toujours le nombre d'encadrants **à l'entier supérieur**.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.22

Pour un atelier de 18 enfants de 8 ans avec un ratio d'un adulte pour 5 enfants pendant la cuisson, calculez le nombre d'adultes nécessaires. Indiquez ensuite si chaque situation relève d'une faute ou d'un aléa : a) un enfant allergique au lait, signalé à l'inscription, goûte une sauce à la crème ; b) un enfant tombe en courant dans la cour pendant la pause, sous la surveillance d'un adulte.

Corrigé

18 / 5 = 3,6, soit **4** adultes. a) Faute : l'allergie était connue et aurait dû être prise en compte dans la recette et la surveillance. b) Plutôt un aléa si la surveillance était normale et les lieux sans danger particulier ; une faute pourrait être retenue si la surveillance était insuffisante ou si un danger connu (sol glissant) n'avait pas été signalé.

Allergies et projets d'accueil individualisés : une responsabilité partagée

L'allergie alimentaire est le risque grave le plus fréquent dans les ateliers et en restauration collective. Elle engage à la fois la **sécurité** des personnes et la **confidentialité** des informations de santé.

Outil	Contenu	Qui y a accès ?
Projet d'accueil individualisé (PAI)	Document rédigé à la demande de la famille, avec le médecin, pour un enfant atteint d'une maladie chronique ou d'une allergie ; il précise les aménagements (panier-repas, éviction) et le protocole d'urgence	Les personnes qui encadrent l'enfant, selon ce qui est prévu dans le PAI
Fiche d'inscription à un atelier	Allergies, régimes, contacts d'urgence	L'animateur et le responsable de l'atelier
Information sur les allergènes des plats (règlement (UE) n° 1169/2011, décret du 17 avril 2015 pour les denrées non préemballées)	Présence des 14 allergènes réglementaires dans chaque plat	Tous les convives, par affichage ou sur demande

La liste des 14 allergènes réglementaires comprend : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites (au-delà de 10 mg par kg ou par litre), lupin, mollusques.

Attention – Sécurité et confidentialité : trouver l'équilibre

Afficher dans le réfectoire une liste nominative des enfants allergiques permet à tout le personnel de les repérer, mais expose des données de santé à la vue de tous (élèves, parents, prestataires). La bonne pratique est un document accessible aux seuls agents qui servent les repas, avec photo si besoin, rangé dans un lieu non visible du public, et mis à jour à chaque rentrée. La sécurité est assurée sans diffusion inutile.

Exemple – Calcul : préparer une dégustation en sécurité

Un atelier « goûters » prévoit trois recettes pour 20 participants. Les fiches d'inscription signalent 2 allergies à l'arachide, 1 allergie à l'œuf et 1 intolérance au lactose.

- Recette 1, cookies au beurre de cacahuète : contient arachide, gluten, lait, œuf. Elle exclut au moins 3 participants (2 arachide, 1 œuf) et ne convient pas à la personne intolérante au lactose sans adaptation.
- Recette 2, compote pomme-poire : aucun des 14 allergènes. Elle convient à tous.
- Recette 3, gâteau au yaourt : gluten, lait, œuf ; une variante au yaourt sans lactose est possible, mais l'œuf exclut 1 participant.

Décision : remplacer la recette 1, car le risque de contamination par l'arachide est élevé pour tout le groupe (traces sur les mains, les ustensiles), et la remplacer par des crêpes à la farine, à la boisson végétale et à la banane, sans œuf.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.23

Un centre de loisirs vous demande s'il peut coller sur la porte du réfectoire la liste « Enfants allergiques : Lina (arachide), Tom (œuf), Sami (lait) ». Expliquez le problème et proposez une organisation conforme.

Corrigé

La liste affiche des données de santé nominatives à la vue de tous (autres enfants, parents, livreurs), sans nécessité : c'est contraire au secret et au principe de minimisation du RGPD, et elle peut stigmatiser les enfants. Organisation conforme : un classeur ou une fiche rangés à l'office, accessibles aux seuls animateurs

et agents de service, avec le PAI et le protocole d'urgence de chaque enfant ; un repère discret au moment du service (plateau de couleur, place habituelle choisie avec la famille) ; une mise à jour à chaque période et une information des nouveaux animateurs.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.10 – La responsabilité

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quelle est la différence entre une obligation de moyens et une obligation de sécurité ?
2. Pour qui l'assurance de responsabilité civile professionnelle est-elle obligatoire ?
3. Pour 23 enfants et un ratio d'un adulte pour 5 enfants, combien d'adultes faut-il ?
4. Citez huit des 14 allergènes réglementaires.
5. Qu'est-ce qu'un projet d'accueil individualisé ?
6. Pourquoi ne faut-il pas afficher la liste nominative des enfants allergiques à la porte du réfectoire ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.10

1. L'obligation de moyens impose de tout faire pour atteindre l'objectif sans garantir le résultat ; l'obligation de sécurité impose de ne pas exposer les personnes à un danger, par exemple avec des aliments sains.
2. Pour les professionnels de santé qui exercent à titre libéral.
3. 23 / 5 = 4,6, soit 5 adultes.
4. Gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin, mollusques.
5. Un document établi à la demande de la famille avec le médecin pour un enfant atteint d'une maladie chronique ou d'une allergie, qui précise les aménagements et le protocole d'urgence.
6. Cela expose des données de santé à tous sans nécessité et peut stigmatiser les enfants.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.11.
3 ou 4 sur 6	Je relis la méthode de préparation d'un atelier et la partie sur les allergies.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.10 et je refais les exercices d'application.

6.3.11 Publicité, allégations et compléments alimentaires : repères pour une information loyale

Module · Référentiel : C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Les allégations nutritionnelles et de santé

Le **règlement (CE) n° 1924/2006** encadre les **allégations** figurant sur les denrées et dans la publicité : seules les allégations figurant sur des listes autorisées, avec des conditions précises, sont permises.

Allégation (exemples)	Condition (règlement 1924/2006, annexe)
« Source de fibres »	Au moins 3 g de fibres pour 100 g ou 1,5 g pour 100 kcal
« Riche en fibres »	Au moins 6 g pour 100 g ou 3 g pour 100 kcal
« Source de protéines »	Au moins 12 % de l'énergie apportée par les protéines
« Riche en protéines »	Au moins 20 % de l'énergie apportée par les protéines

Allégation (exemples)	Condition (règlement 1924/2006, annexe)
« Sans sucres ajoutés »	Aucun mono- ou disaccharide ni aucune denrée utilisée pour ses propriétés édulcorantes ajouté ; mention « contient des sucres naturellement présents » si c'est le cas
« Allégé », « réduit en… »	Réduction d'au moins 30 % par rapport à un produit similaire (25 % pour le sel)
« Faible teneur en sel »	Au plus 0,12 g de sodium pour 100 g (soit environ 0,3 g de sel)

Les **allégations de santé** (« le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature normale ») doivent être autorisées par la Commission européenne après avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et figurer dans le registre de l'Union.

Exemple – Calcul détaillé : une allégation est-elle justifiée ?

Un biscuit annonce « riche en fibres ». Étiquette pour 100 g : énergie 460 kcal ; fibres 5,2 g ; protéines 7,5 g.

- Critère par masse : 5,2 g < 6 g pour 100 g : **non rempli**.
- Critère par énergie : fibres pour 100 kcal = 5,2 / 460 × 100 = **1,13 g** < 3 g : **non rempli**.
- « Source de fibres » serait possible : 5,2 g ≥ 3 g pour 100 g : condition remplie.
- « Source de protéines » ? Énergie apportée par les protéines : 7,5 × 4 = 30 kcal ; 30 / 460 × 100 = **6,5 %** < 12 % : non.

Conclusion : l'allégation « riche en fibres » n'est pas conforme ; le diététicien peut utiliser cet exemple en atelier de littératie critique (chapitre 5) et, s'il le constate dans le cadre professionnel, le signaler à la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), qui contrôle l'étiquetage.

La publicité alimentaire et les messages sanitaires

Depuis la loi relative à la politique de santé publique de 2004 et son décret d'application de 2007, les publicités pour des aliments manufacturés ou des boissons avec ajout de sucres, de sel ou d'édulcorants doivent comporter un **message sanitaire** (« Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour », « … évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé », « … pratiquez une activité physique régulière », « … évitez de grignoter entre les repas ») et l'adresse *mangerbouger.fr*, ou verser une contribution à Santé publique France. L'efficacité limitée de ces bandeaux et l'exposition des enfants à la publicité alimentaire (déterminants commerciaux, chapitre 2) alimentent un débat sur un encadrement plus strict, recommandé par le HCSP et l'OMS ; vérifier l'état de la réglementation dans le cadre du PNNS 5.

Les compléments alimentaires

Les **compléments alimentaires** (directive 2002/46/CE ; décret n° 2006-352 en France) sont des denrées destinées à compléter l'alimentation normale, présentées sous forme de doses (gélules, comprimés). Ils ne sont pas des médicaments et ne peuvent revendiquer de propriétés de prévention ou de guérison des maladies. Ils sont déclarés auprès de la DGCCRF ; l'ANSES pilote un dispositif de **nutrivigilance** qui recueille les effets indésirables. En santé publique, le diététicien rappelle qu'une alimentation variée couvre en général les besoins, signale les situations où une supplémentation est recommandée (vitamine B12 chez le végétalien, vitamine D selon avis médical, acide folique avant la conception) et reste **indépendant** de toute marque (6.3.7).

Le Nutri-Score : une information loyale au service de l'autonomie

Le **Nutri-Score** est un logo nutritionnel à cinq couleurs et cinq lettres (de A, vert foncé, à E, orange foncé) placé sur la face avant des emballages. Il a été recommandé en France par un arrêté du 31 octobre 2017 et il reste **facultatif** pour les fabricants, car le droit européen ne permet pas à un pays de l'imposer seul. Son algorithme a été révisé en 2022 pour les aliments et en 2023 pour les boissons, puis rendu applicable en France par l'arrêté du 14 mars 2025, afin de mieux distinguer certains produits (céréales complètes, produits sucrés, boissons édulcorées) ; les nouveaux logos remplacent progressivement les anciens sur les emballages.

Sur le plan éthique, le Nutri-Score est un exemple de mesure du **bas de l'échelle d'intervention** (informer) : il n'interdit rien, il aide le consommateur à comparer rapidement des produits d'une même catégorie. Il respecte donc l'**autonomie** tout en favorisant la **justice**, car il est plus facile à comprendre qu'un tableau nutritionnel pour les personnes qui ont une littératie limitée (chapitre 5).

Atout	Limite
Lecture rapide, sans calcul	Facultatif : certaines marques ne l'affichent pas
Permet de comparer des produits d'un même rayon	Ne compare pas des produits très différents (une huile et un soda)
Pousse certains fabricants à améliorer leurs recettes	Ne tient pas compte du degré de transformation, des additifs ou des pesticides
Utile en atelier de littératie	Un produit classé A peut être consommé en excès ; un produit classé D peut avoir sa place dans une alimentation variée

Attention – Un outil de comparaison, pas un jugement moral

En atelier, on évite de parler de « bons » produits A et de « mauvais » produits E, ce qui moraliserait l'alimentation. On présente le Nutri-Score comme un outil pour **comparer** deux produits que l'on hésite à acheter : « Entre ces deux céréales, laquelle est la plus intéressante au quotidien ? » Un fromage classé D reste une source de calcium et de plaisir.

Exemple – Comparer deux produits d'un même rayon

Deux boîtes de céréales du petit déjeuner (produits fictifs) coûtent le même prix : céréales chocolatées classées D (sucres 28 g pour 100 g, fibres 4 g) et flocons d'avoine classés A (sucres 1 g, fibres 9 g). Pour une portion de 40 g, les céréales chocolatées apportent 28 × 40 / 100 = **11,2 g** de sucres, soit près de trois morceaux de sucre de 4 g (11,2 / 4 = 2,8) ; les flocons d'avoine en apportent 1 × 40 / 100 = **0,4 g**. On peut proposer de mélanger les deux pour garder le plaisir du chocolat en réduisant les sucres.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.24

Une enseigne propose d'afficher dans son rayon « Mangez A, évitez E ! » avec une photo d'enfant souriant devant les produits A. Analysez ce message au regard de l'information loyale et de la non-stigmatisation, et proposez un autre message.

Corrigé

Le message transforme un outil de comparaison en règle morale (« évitez E »), il est inexact (un produit E peut être consommé occasionnellement, et le Nutri-Score ne compare que des produits d'une même catégorie), et il peut culpabiliser les familles qui achètent des produits E pour des raisons de goût ou de prix. L'enseigne peut aussi l'utiliser pour mettre en avant ses propres produits. Autre message : « Le Nutri-Score vous aide à comparer des produits du même rayon. Pour vos achats de tous les jours, regardez les lettres A et B. »

Lire le marketing des emballages avec un œil critique

Au-delà des allégations réglementées, les emballages utilisent de nombreux procédés pour donner une image favorable du produit. Certains mots ne sont encadrés par aucune définition légale précise, d'autres le sont strictement. Savoir les distinguer fait partie de la **littératie critique** (chapitre 5) et de l'information loyale.

Mention ou procédé	Statut	Ce qu'il faut savoir
« Naturel », « authentique », « recette de grand-mère »	Pas de définition générale ; interdit seulement s'il est trompeur	Ne garantit ni l'absence d'additifs ni l'intérêt nutritionnel

Mention ou procédé	Statut	Ce qu'il faut savoir
« Fait maison » en restauration	Encadré par un décret de 2015 : plat cuisiné sur place à partir de produits crus, avec quelques exceptions	Ne concerne que la restauration, pas les produits emballés
« Bio » (eurofeuille, logo AB)	Encadré par le règlement européen sur l'agriculture biologique	Garantit un mode de production, pas une meilleure composition nutritionnelle
« Sans conservateurs », « sans colorants »	Autorisé si c'est exact et si la loi n'interdit pas déjà ces additifs dans ce produit	Peut donner une image « santé » à un produit très sucré
Images de fruits, de champs, de sportifs	Interdites seulement si elles trompent sur la composition	Un yaourt « aux fruits » peut contenir très peu de fruits : vérifier le pourcentage dans la liste des ingrédients
Personnages de dessins animés, jeux, cadeaux	Pas interdits sur les emballages en France	Procédés de marketing destinés aux enfants, souvent sur des produits gras, sucrés ou salés

Définition – Pratique commerciale trompeuse

Pratique qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur, notamment sur les qualités substantielles, la composition ou les propriétés d'un produit (articles L. 121-2 et suivants du Code de la consommation). Elle est sanctionnée pénalement et contrôlée par la DGCCRF.

Exemple – Calcul : la part réelle de fruit

Une boisson « aux fruits rouges » (produit fictif) indique dans sa liste d'ingrédients : « eau, sucre, jus de fruits rouges à base de concentré 6 %, arômes ». Pour une bouteille de 1,5 L, le jus de fruits représente 1 500 × 0,06 = **90 mL**, soit moins d'un demi-verre (un verre contient environ 200 mL). L'image de fruits débordant de l'étiquette ne correspond pas à cette réalité, ce que l'on peut faire découvrir en atelier en versant 90 mL d'eau colorée dans un verre.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.25

Un biscuit pour enfants porte les mentions « Recette authentique », « Sans colorants », « Source de céréales » et un personnage de dessin animé. Il contient 32 g de sucres pour 100 g. Classez chaque mention (réglementée ou non) et rédigez la question que vous poseriez aux parents en atelier pour développer leur esprit critique.

Corrigé

« Recette authentique » : non réglementée, elle ne dit rien de la composition. « Sans colorants » : autorisée si elle est exacte, mais elle détourne l'attention des 32 g de sucres. « Source de céréales » : formule ambiguë, qui imite une allégation nutritionnelle sans correspondre à une allégation autorisée ; elle peut être trompeuse. Personnage de dessin animé : procédé de marketing destiné aux enfants. Question : « Si vous retournez le paquet, qu'est-ce qui vous surprend dans le tableau nutritionnel par rapport à ce que dit le devant de l'emballage ? »

Compléments alimentaires : des risques réels et un rôle de conseil

Les compléments alimentaires sont souvent perçus comme « naturels » et donc sans danger. Pourtant, le dispositif de **nutrivigilance** de l'Anses reçoit chaque année des déclarations d'effets indésirables, parfois graves : atteintes du foie, troubles cardiaques, interactions avec des médicaments, surdosages.

Situation à risque	Exemple	Conseil du diététicien
Surdosage	Plusieurs produits contenant la même vitamine pris en même temps ; produits enrichis en vitamine D donnés à des nourrissons à des doses trop élevées, qui ont conduit l'Anses à alerter en 2021 sur des cas d'hypercalcémie	Faire la liste de tous les produits pris ; préférer les médicaments prescrits par le médecin quand une supplémentation est nécessaire
Interaction avec un médicament	Millepertuis qui diminue l'efficacité de certains médicaments (contraceptifs, anticoagulants)	Toujours signaler au médecin et au pharmacien les compléments pris
Population sensible	Femmes enceintes, enfants, personnes âgées polymédiquées, sportifs	Pas de complément sans avis médical
Achat sur internet hors de l'Union européenne	Produits « minceur » contenant des substances interdites	Déconseiller l'achat de produits dont l'origine et la composition ne sont pas vérifiables
Promesses non autorisées	« Détox », « brûle-graisses », « renforce l'immunité » sans allégation autorisée	Expliquer que ces promesses ne sont pas prouvées

Méthode pas à pas – Conseiller une personne qui prend des compléments

1. Recenser sans juger : quels produits, depuis quand, à quelle dose, pourquoi, sur quel conseil ?

2. Comprendre l'attente : fatigue, minceur, performance, prévention ? Quelle est la vraie préoccupation ?

3. Informer de façon loyale : ce qui est prouvé, ce qui ne l'est pas, les risques possibles.

4. Proposer des alternatives alimentaires quand elles existent (aliments riches en fer, en vitamine C, en fibres).

5. Orienter vers le médecin ou le pharmacien en cas de symptômes, de traitement en cours ou de population sensible.

6. Signaler un effet indésirable suspecté (nutrivigilance), en lien avec un professionnel de santé.

Exemple – Calcul : comparer un complément et des aliments

Une personne achète un complément « vitamine C 500 mg » à 9,90 € les 30 comprimés, soit 9,90 / 30 = **0,33 €** par jour. La référence nutritionnelle pour la population fixée par l'Anses est de 110 mg par jour pour un adulte. Une orange de 150 g de chair apporte 150 × 47,5 / 100 = **71,3 mg** de vitamine C (orange crue, 47,5 mg pour 100 g, code 13034 de la table Ciqual 2025), et 100 g de poivron rouge cru en apportent 121 mg (code 20087). Une alimentation qui contient des fruits et des légumes chaque jour couvre donc le besoin, sans dépense supplémentaire et avec d'autres bénéfices (fibres, potassium, plaisir). La dose de 500 mg dépasse largement le besoin : l'excédent est éliminé dans les urines.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.26

Une étudiante sportive prend chaque jour une poudre protéinée, un complément « énergie » contenant de la caféine et un complément de fer acheté sans avis médical. Elle dit se sentir nerveuse. Indiquez trois questions à lui poser, deux risques possibles et votre conduite.

Corrigé

Questions : quelles doses prenez-vous et depuis quand ? Buvez-vous aussi du café, du thé ou des boissons énergisantes ? Pourquoi avez-vous commencé le fer, une prise de sang a-t-elle été faite ? Risques : excès de caféine (nervosité, palpitations, troubles du sommeil) ; surcharge en fer sans carence prouvée (troubles digestifs, toxicité à long terme) ; dépenses inutiles. Conduite : lui conseiller d'arrêter le complément « énergie », de parler du fer à son médecin avant de continuer, de vérifier si ses apports en protéines par l'alimentation suffisent, et de signaler ses symptômes à un médecin ; en cas d'effet indésirable avéré, une déclaration de nutrivigilance peut être faite.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.11 – Allégations, marketing et compléments

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Le Nutri-Score est-il obligatoire en France ? Pourquoi ?
2. À quel échelon de l'échelle d'intervention correspond-il ?
3. La mention « naturel » est-elle définie par la loi ?
4. Une boisson de 1 L contient 8 % de jus de fruits. Quel volume de jus contient-elle ?
5. Citez deux risques liés aux compléments alimentaires.
6. Une boîte de 60 comprimés coûte 12 €. Quel est le coût par jour pour un comprimé par jour ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.11

1. Non, il est facultatif, car le droit européen ne permet pas à un pays de l'imposer seul.
2. Au bas de l'échelle : informer.
3. Non, elle n'a pas de définition générale ; elle est interdite seulement si elle est trompeuse.
4. 1 000 × 0,08 = 80 mL.
5. Surdosage, interaction avec un médicament, substances interdites dans des produits achetés en ligne, dépenses inutiles.
6. 12 / 60 = 0,20 € par jour.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.12.
3 ou 4 sur 6	Je relis les tableaux sur le Nutri-Score et sur le marketing.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.11 et je refais les exercices d'application.

6.3.12 Enquêtes, recherche et protection des personnes

Module · Référentiel : C3.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Les projets de santé publique comportent souvent des **enquêtes** (diagnostic, évaluation). Leur cadre juridique dépend de leur **finalité**.

Situation	Cadre	Démarches
Questionnaire anonyme de diagnostic ou d'évaluation d'une action, sans finalité de recherche	RGPD (si données personnelles) ; pas de recherche au sens de la loi Jardé	Mention d'information, minimisation, anonymat, registre de la structure

Situation	Cadre	Démarches
Recherche impliquant la personne humaine (RIPH), visant à développer les connaissances biologiques ou médicales (catégories 1, 2, 3 de la loi Jardé, 2012)	Code de la santé publique ; avis d'un comité de protection des personnes (CPP)	Protocole, information, consentement (ou non-opposition pour la catégorie 3), conformité CNIL (méthodologies de référence MR-001 à MR-003)
Recherche n'impliquant pas la personne humaine, étude ou évaluation à partir de données existantes (dossiers, bases)	RGPD ; méthodologie de référence MR-004 de la CNIL ou autorisation	Information des personnes, inscription au répertoire public des études
Mémoire universitaire ou travail d'étudiant	Selon la nature : souvent hors loi Jardé si pas de finalité de connaissance généralisable ; avis éventuel d'un comité d'éthique local	Se renseigner auprès de l'établissement de formation

Méthode pas à pas – Les principes éthiques d'une enquête de terrain

1. **Finalité** claire et utile au public.
2. **Information** loyale (qui, pourquoi, comment, quels usages).
3. **Liberté** de participer ou non, et d'arrêter, sans conséquence.
4. **Anonymat** ou pseudonymisation ; **minimisation** des données ; pas de données sensibles inutiles.
5. **Respect** des personnes (questions non intrusives, langue adaptée, durée raisonnable).
6. **Restitution** des résultats aux participants.
7. **Sécurité** des données et suppression à la date prévue.

Les trois catégories de recherches impliquant la personne humaine

La loi Jardé distingue trois catégories de recherches impliquant la personne humaine (RIPH), selon le niveau de risque et de contrainte pour les participants. Toutes nécessitent un **protocole** et l'**avis favorable d'un comité de protection des personnes** (CPP), désigné par tirage au sort au niveau national.

Catégorie	Définition	Exemple en nutrition	Accord des participants
1 – Interventionnelle	Intervention non justifiée par la prise en charge habituelle, avec des risques possibles	Essai d'un nouveau complément nutritionnel oral chez des patients dénutris	Consentement libre, éclairé et écrit ; autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament si un produit de santé est testé
2 – Interventionnelle à risques et contraintes minimes	Intervention qui ne comporte que des risques et contraintes minimes (liste fixée par arrêté)	Mesure de la composition corporelle par impédancemétrie, questionnaires répétés, prise de sang supplémentaire de faible volume	Consentement libre, éclairé et exprès (écrit ou oral tracé)
3 – Non interventionnelle (observationnelle)	Actes et produits utilisés de façon habituelle, sans procédure inhabituelle de diagnostic ou de surveillance	Observation des consommations au repas d'un service hospitalier pour étudier le lien avec la durée de séjour	Information et absence d'opposition

Un **comité de protection des personnes** est composé de membres bénévoles issus du domaine de la recherche et de la santé et de membres de la société civile (représentants d'associations d'usagers, juristes, spécialistes de l'éthique). Il vérifie notamment la pertinence de la recherche, la qualité de l'information et les modalités de

recueil du consentement, l'adéquation entre les objectifs et les moyens, et la protection des personnes vulnérables.

Définition – Note d'information d'une recherche

Document remis aux participants avant leur accord. Il précise l'objectif et la méthode de la recherche, sa durée, les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, les alternatives, les modalités de prise en charge en cas de problème, l'avis du CPP, la possibilité de refuser ou d'arrêter à tout moment sans conséquence, et les droits sur les données (RGPD). Pour une recherche de catégorie 1, le consentement est ensuite recueilli par écrit.

Exemple – Calcul : le taux de participation à une recherche

Une équipe propose une recherche de catégorie 2 à 160 patients d'un service de gériatrie (exemple fictif). 112 acceptent, 31 refusent et 17 ne peuvent pas donner leur accord en raison de troubles cognitifs sévères.

- Taux d'acceptation parmi les patients sollicités : 112 / 160 × 100 = **70,0 %**.
- Parmi les patients en mesure de décider : 112 / (160 − 17) = 112 / 143 × 100 = **78,3 %**.

Pour les 17 patients qui ne peuvent pas consentir, la loi prévoit des règles spécifiques (consentement du représentant légal ou d'un proche, intérêt direct ou bénéfice collectif, risque minime). Les résultats doivent aussi signaler que les patients les plus atteints sont peut-être sous-représentés.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.27

Classez chaque projet dans une catégorie de la loi Jardé, ou hors recherche impliquant la personne humaine : a) tester l'effet d'un régime enrichi en fibres sur la glycémie de patients diabétiques, avec des prises de sang répétées ; b) observer, sans rien changer, les quantités consommées au déjeuner par des résidents d'EHPAD pour étudier leur lien avec la perte de poids ; c) évaluer la satisfaction des participants d'un atelier cuisine.

Corrigé

a) Recherche interventionnelle : catégorie 1 si le régime ou les prélèvements présentent des risques, catégorie 2 s'ils restent dans la liste des risques et contraintes minimes ; dans tous les cas avis du CPP et consentement. b) Catégorie 3, recherche non interventionnelle, si l'objectif est de produire des connaissances ; information des résidents et absence d'opposition, avis du CPP. c) Hors recherche : évaluation d'une action, soumise au RGPD si des données personnelles sont recueillies.

L'intégrité scientifique : un devoir aussi pour l'étudiant

L'**intégrité scientifique** désigne l'ensemble des règles qui garantissent l'honnêteté et la rigueur d'un travail de recherche ou d'étude. En France, la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche l'a inscrite dans le Code de la recherche. Les trois manquements les plus graves sont regroupés sous le sigle **FFP**.

Manquement	Définition	Exemple dans un dossier d'étudiant
Fabrication	Inventer des données ou des résultats	Écrire que 40 questionnaires ont été recueillis alors que seuls 15 l'ont été
Falsification	Modifier des données, des méthodes ou des résultats pour obtenir la conclusion souhaitée	Supprimer les réponses négatives pour améliorer le taux de satisfaction
Plagiat	Présenter comme sien le travail d'autrui sans le citer	Copier un paragraphe d'un site internet ou un texte produit par une IA sans le signaler

D'autres pratiques sont aussi contraires à l'intégrité : ne pas citer ses sources, présenter des données fictives comme réelles, choisir uniquement les études qui vont dans son sens, ne pas déclarer un lien d'intérêts.

Méthode pas à pas – Citer correctement ses sources dans un dossier

1. Toute information qui n'est pas de vous (chiffre, définition, recommandation) est suivie d'une référence.

2. Une citation mot pour mot est mise entre guillemets, avec la référence.

3. La référence comporte l'auteur ou l'organisme, le titre, l'année et, pour un site, l'adresse et la date de consultation : « Santé publique France. Recommandations relatives à l'alimentation, à l'activité physique et à la sédentarité pour les adultes. 2019. Consulté le 10 octobre 2026. »

4. Les données fictives (exercices, cas simulés) sont toujours signalées comme fictives.

5. L'aide d'un outil d'IA, quand elle est autorisée, est signalée (quel outil, pour quelle tâche) et chaque information produite est vérifiée dans une source fiable.

Attention – Fraude aux examens

Présenter à l'épreuve E5 des données inventées, des photos d'une action à laquelle on n'a pas participé ou un texte rédigé par une autre personne ou par une IA comme son propre travail constitue une **fraude**. Elle peut entraîner l'annulation de l'épreuve et une interdiction de se présenter à un examen pendant plusieurs années. Au-delà de la sanction, elle trahit la confiance du jury et des personnes qui ont participé à l'action.

Exemple – Présenter honnêtement un résultat décevant

Une étudiante voulait recueillir 60 questionnaires ; elle en a obtenu 22. Elle n'a pas complété les réponses. Dans son dossier, elle écrit : « 22 questionnaires ont été recueillis sur les 60 prévus (36,7 %). Ce faible effectif ne permet pas de généraliser les résultats. La passation à la sortie de l'école, en fin de journée, explique sans doute en partie cette faible participation ; une passation pendant la fête de quartier aurait permis de toucher davantage de familles. » Cette analyse des limites est valorisée par le jury, car elle montre une démarche honnête et réflexive.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.28

Pour chaque pratique, indiquez s'il s'agit de fabrication, de falsification, de plagiat ou d'une pratique correcte : a) arrondir 66,67 % à 66,7 % ; b) retirer d'un tableau trois réponses « pas du tout satisfait » parce qu'elles « faussent la moyenne » ; c) reprendre un schéma de Santé publique France en citant la source ; d) ajouter dix questionnaires remplis soi-même pour atteindre l'effectif prévu.

Corrigé

a) Pratique correcte : arrondi annoncé et habituel. b) Falsification : des données réelles sont supprimées pour modifier le résultat. c) Pratique correcte, à condition de citer la source et de respecter les conditions de réutilisation. d) Fabrication : des données sont inventées.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.12 – Enquêtes et recherche

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez les trois catégories de recherches impliquant la personne humaine.
2. Comment est désigné le comité de protection des personnes qui examine un projet ?
3. Quel accord est demandé aux participants d'une recherche de catégorie 3 ?
4. Que signifie le sigle FFP ?

5. Sur 90 personnes sollicitées, 63 acceptent. Calculez le taux d'acceptation.
6. Que doit-on indiquer quand on utilise des données fictives dans un dossier ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.12

1. Interventionnelle ; interventionnelle à risques et contraintes minimes ; non interventionnelle.
2. Par tirage au sort au niveau national.
3. Une information et l'absence d'opposition.
4. Fabrication, falsification, plagiat.
5. 63 / 90 × 100 = 70 %.
6. Qu'elles sont fictives.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.13.
3 ou 4 sur 6	Je relis le tableau des catégories Jardé et celui de l'intégrité scientifique.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.12 et je refais les exercices d'application.

6.3.13 Identité numérique et e-réputation du professionnel

Module · Référentiel : C3.5 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Le référentiel (compétence C3.5) demande de **maîtriser son identité numérique** et de prendre en compte les enjeux de l'**e-réputation**. L'identité numérique est l'ensemble des traces associées à une personne sur internet (profils, publications, commentaires, photos) ; l'e-réputation est l'image qui s'en dégage.

Bonne pratique	Pourquoi
Séparer comptes personnels et professionnels	Éviter que des contenus privés soient associés à la fonction
Paramétrer la confidentialité des comptes personnels	Les partenaires, patients et futurs employeurs consultent les profils
Ne jamais publier de données ou de photos de participants sans autorisation spécifique	Droit à l'image, RGPD, secret (6.3.4 à 6.3.6)
Publier des contenus sourcés et datés	Information loyale ; crédibilité
Ne pas répondre à chaud aux critiques ; signaler les contenus diffamatoires	Préserver la relation et la réputation de la structure
Mentionner tout partenariat commercial	Loi du 9 juin 2023 sur l'influence commerciale
Vérifier régulièrement ce qui apparaît à son nom (moteur de recherche)	Maîtriser son image professionnelle

Répondre à la désinformation nutritionnelle

Les fausses informations sur l'alimentation circulent vite sur les réseaux sociaux : régimes miracles, aliments « poisons », jeûnes extrêmes, « détox ». Le diététicien a un rôle de **prévention** face à ces contenus, mais sa réponse doit rester respectueuse, sourcée et efficace. Contredire brutalement une personne risque de renforcer sa conviction.

Méthode pas à pas – Répondre à une fausse information en quatre temps

1. Écouter et reconnaître la préoccupation : « Vous avez raison de vous intéresser à ce que contiennent les aliments. »

2. Commencer par le fait exact, pas par le mythe : répéter le mythe risque de le renforcer. « Les produits

laitiers apportent du calcium et des protéines, et ils ont leur place dans une alimentation variée. »

3. Expliquer simplement pourquoi l'information circulait : « Ce message vient souvent de vidéos qui vendent des produits ou des programmes. »

4. Donner une source fiable et datée, et proposer d'en reparler : « Les recommandations de Santé publique France sont sur mangerbouger.fr. »

Indice d'une information douteuse	Exemple
Promesse rapide et spectaculaire	« Perdez 10 kg en 2 semaines »
Un seul aliment présenté comme miracle ou comme poison	« Le citron brûle les graisses », « le gluten est toxique pour tous »
Absence de source, ou source vague	« Des scientifiques ont prouvé… »
Vente d'un produit ou d'un programme	Code promo, lien d'achat
Témoignages à la place de données	« Ça a marché pour moi »
Discours contre « les autorités » ou « les médecins »	« Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez »

Attention – Rester dans son rôle

Le diététicien ne se moque pas des personnes qui ont cru une fausse information : cela arrive à tout le monde, et la honte empêche de changer d'avis. Il ne s'en prend pas non plus personnellement à l'auteur d'un contenu (risque de diffamation, de conflit public). Il corrige l'information, pas la personne.

Le télésoin et les consultations à distance

Depuis la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, le **télésoin** permet à des auxiliaires médicaux et à des pharmaciens de suivre des patients à distance, par vidéotransmission, dans des conditions fixées par décret (2021). Ces pratiques facilitent l'accès aux soins dans les territoires peu dotés, mais elles posent des questions éthiques.

Enjeu	Bonne pratique
Consentement	Proposer le télésoin sans l'imposer, recueillir l'accord de la personne
Confidentialité	Outil sécurisé ; professionnel seul dans une pièce fermée ; vérifier que le patient peut parler librement
Fracture numérique	Proposer une alternative en présentiel ou par téléphone ; aider à l'installation
Qualité	Première consultation en présentiel quand c'est possible ; limites (pas de pesée ni d'observation complète)
Traçabilité	Compte rendu dans le dossier, comme pour une consultation sur place

À vous de jouer – Exercice d'application 6.29

Un participant vous dit en atelier : « J'ai vu qu'il faut arrêter complètement le sucre, même les fruits, parce que le sucre nourrit le cancer. » Rédigez votre réponse en appliquant les quatre temps de la méthode.

Corrigé

1. « Je comprends que ce sujet vous inquiète, beaucoup de gens se posent la question. » 2. « Les fruits font partie des aliments qui protègent la santé : ils apportent des fibres, des vitamines et des antioxydants, et les recommandations conseillent d'en manger chaque jour. Ce qui est conseillé, c'est de limiter les produits sucrés et les boissons sucrées. » 3. « L'idée que le sucre nourrit le cancer vient d'une simplification : toutes les cellules utilisent du glucose, et supprimer les fruits ne soigne pas un cancer ;

> cela peut au contraire faire maigrir et affaiblir une personne malade. » 4. « Vous pouvez trouver des informations fiables sur le site de l'Institut national du cancer et sur mangerbouger.fr. Si vous êtes concerné, parlez-en à votre médecin, et nous pouvons en reparler ensemble. »

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.13 – Le numérique

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Pourquoi faut-il commencer par le fait exact plutôt que par le mythe ?
2. Citez quatre indices d'une information douteuse.
3. Pourquoi ne faut-il pas se moquer d'une personne qui a cru une fausse information ?
4. Quelle loi a créé le télésoin ?
5. Citez deux bonnes pratiques de confidentialité lors d'une consultation à distance.
6. Quelle alternative faut-il prévoir pour les personnes éloignées du numérique ?

Corrigé – Point d'étape 6.3.13

1. Répéter le mythe en premier risque de le renforcer dans la mémoire.
2. Promesse rapide, aliment miracle ou poison, absence de source, vente d'un produit, témoignages, discours contre les autorités.
3. La honte empêche de changer d'avis et rompt la relation.
4. La loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
5. Outil sécurisé ; professionnel seul dans une pièce fermée ; vérifier que le patient peut parler librement.
6. Une consultation en présentiel ou par téléphone, et une aide à l'installation.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie 6.3.14.
3 ou 4 sur 6	Je relis la méthode en quatre temps et le tableau sur le télésoin.
Moins de 3 sur 6	Je relis toute la partie 6.3.13 et je refais les exercices d'application.

6.3.14 Cinq dilemmes éthiques commentés

Module · Guide 2025 : p. 61 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Les situations suivantes, fréquentes en stage et en début d'exercice, sont analysées avec la grille en 5 étapes (6.3.8). Elles n'ont pas une seule « bonne réponse » : l'important est le **raisonnement** et sa **justification**.

Situation	Règles et valeurs en tension	Options envisagées	Décision argumentée
1. Un participant arrive à l'atelier en état d'ivresse	Sécurité (four, couteaux) et respect de la personne ; non-malfaisance pour lui et le groupe	Le laisser participer ; l'exclure devant le groupe ; lui parler en privé	Lui parler en privé, avec respect ; lui proposer de revenir la semaine suivante ; prévenir la référente ; ne pas le laisser manipuler le matériel dangereux ; proposer une orientation si la situation se répète
2. Une mère demande de ne pas mettre son enfant à côté d'un enfant « d'une autre origine »	Non-discrimination (loi, déontologie) et respect de la parole de la mère	Accepter ; refuser sèchement ; expliquer le cadre	Rappeler calmement que l'atelier est ouvert à tous sans distinction ; ne pas modifier l'organisation sur ce motif ; en informer la référente

Situation	Règles et valeurs en tension	Options envisagées	Décision argumentée
3. Un financeur demande la liste nominative des participants	Secret, RGPD (minimisation) et obligation de rendre compte	Envoyer la liste ; refuser sans explication ; proposer des données agrégées	Transmettre des données agrégées (nombre, profils anonymes) et les émargements seulement si la convention l'exige et si les personnes en ont été informées
4. Une collègue publie un « avant/après » de la silhouette d'une participante qui a perdu du poids (avec son accord)	Autonomie (accord de la personne) et non-malfaisance (message centré sur le poids, effet sur les autres)	Laisser ; demander le retrait ; proposer un autre message	En parler à la collègue, expliquer le risque de stigmatisation et de restriction ; proposer un témoignage centré sur le plaisir de cuisiner, avec l'accord de la participante
5. La structure veut réserver les ateliers aux familles « qui le méritent » (assiduité dans d'autres activités)	Justice (accès selon les besoins) et contraintes de places	Accepter le critère ; tirage au sort ; critères de besoin	Proposer des critères transparents liés aux besoins (orientation par les partenaires, priorité aux familles les plus éloignées), une liste d'attente et un cycle supplémentaire

Attention – Tracer ses décisions

Dans chaque cas, le professionnel **informe** sa hiérarchie ou son tuteur, **note** la situation et la décision dans un journal de bord (sans données inutiles) et **revient** sur la situation en analyse de pratique : c'est ainsi que se construit une posture éthique.

Cinq autres dilemmes pour s'entraîner

Les cinq situations suivantes complètent le tableau précédent. Essayez d'abord de les analyser seul avec la grille en cinq étapes, puis lisez la proposition de réponse. Comme pour les dilemmes commentés, plusieurs réponses peuvent être défendues : c'est la qualité de la justification qui compte.

Situation	Règles et valeurs en tension	Options envisagées	Décision argumentée
6. Un adolescent de 16 ans vous confie en atelier qu'il se fait vomir après les repas et vous demande de ne rien dire à ses parents	Secret et confiance de l'adolescent ; protection d'un mineur ; non-malfaisance (trouble du comportement alimentaire possible)	Garder le secret ; prévenir les parents sans lui en parler ; l'accompagner vers un professionnel	L'écouter sans juger, lui expliquer que sa santé est en jeu et que vous ne pouvez pas garder cela pour vous seul ; en parler à votre tuteur et à l'infirmière ou au médecin de la structure ; chercher avec lui la façon d'informer ses parents et de consulter (médecin, maison des adolescents)
7. Un élu demande de présenter dans le bilan du projet « les familles les plus en difficulté » avec photos et prénoms, pour obtenir une subvention	Rendre compte au financeur ; secret, droit à l'image, dignité	Accepter ; refuser sans proposer d'alternative ; proposer un bilan anonymisé avec témoignages autorisés	Bilan chiffré et agrégé, témoignages anonymes recueillis avec accord, photos de plats et de mains ; expliquer à l'élu que la dignité des familles est aussi un gage de confiance pour la suite

Situation	Règles et valeurs en tension	Options envisagées	Décision argumentée
8. Une participante très en retard à chaque séance perturbe le groupe ; l'animatrice veut l'exclure	Justice (accès) ; respect du groupe ; bienveillance	Exclure ; ne rien dire ; en parler en privé et adapter	Entretien individuel pour comprendre (horaires de travail, garde d'enfants, transports) ; adapter l'accueil (arrivée échelonnée, tâches qui peuvent commencer plus tard) ; rappeler le cadre au groupe sans la désigner
9. Un médecin vous demande de faire signer aux patients un formulaire autorisant l'utilisation de leurs données pour une étude, « sans trop expliquer, sinon ils refusent »	Autonomie, information loyale, cadre de la recherche ; relation avec le médecin	Obéir ; refuser sèchement ; discuter et proposer une information claire	Refuser de recueillir un consentement non éclairé ; en parler au médecin et proposer une note d'information claire ; vérifier que l'étude a reçu les autorisations nécessaires ; informer son responsable si le désaccord persiste
10. Votre employeur, une collectivité, vous demande de relayer sur vos comptes personnels une campagne municipale à la veille d'une élection	Neutralité du service public ; liberté d'expression ; séparation vie privée et vie professionnelle	Relayer ; refuser ; relayer uniquement les messages de santé sur le compte de la structure	Ne pas utiliser ses comptes personnels pour une communication de l'employeur, encore moins en période électorale ; diffuser les messages de santé publique sur les supports officiels, dans le respect des règles de communication en période électorale

Astuce – Repérer le principe dominant

Dans beaucoup de dilemmes, un principe l'emporte quand un **danger grave** existe pour une personne vulnérable (situation 6) : la protection passe alors avant le secret, mais toujours en informant la personne de ce que l'on va faire et pourquoi. Quand il n'y a pas de danger grave, l'**autonomie** et la **dignité** des personnes priment souvent (situations 7 et 8).

À vous de jouer – Exercice d'application 6.30

Une diététicienne de PMI (protection maternelle et infantile) constate qu'une mère donne à son nourrisson de 4 mois une boisson végétale à base d'amande à la place du lait infantile, par conviction. Rédigez l'analyse en cinq étapes et la phrase par laquelle vous ouvririez la discussion avec la mère.

Corrigé

Faits : nourrisson de 4 mois, alimenté par une boisson végétale non adaptée à ses besoins, choix lié aux convictions de la mère. **Règles** : les boissons végétales ne sont pas des substituts du lait maternel ou des préparations pour nourrissons et ne couvrent pas ses besoins (protéines, énergie, calcium, fer, vitamines) ; la protection de l'enfance s'impose en cas de danger. **Valeurs** : respect des convictions et de l'autonomie parentale contre bienfaisance et non-malfaisance envers l'enfant, qui ne peut pas se protéger. **Options** : respecter le choix sans rien dire (rejetée, danger) ; signaler immédiatement sans dialogue (rejetée en première intention si la mère est prête à changer) ; informer, chercher une solution compatible avec ses convictions (allaitement si possible, préparation infantile à base de protéines végétales adaptée, sur conseil du médecin) et organiser un suivi médical rapproché. **Décision** : troisième option, en lien immédiat avec le médecin de PMI ; si l'enfant présente des signes de dénutrition ou si la mère refuse toute adaptation, l'équipe envisage une information préoccupante. Phrase d'ouverture : « Je vois que vous faites très attention à ce que

vous donnez à votre bébé. Est-ce que vous voulez bien qu'on regarde ensemble ce dont il a besoin à son âge, et les laits qui peuvent correspondre à vos choix ? »

6.3.15 Laïcité et neutralité dans les actions de santé publique

Module · Référentiel et guide : voir 6.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

La **laïcité** (loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l'État ; article 1er de la Constitution de 1958) garantit la liberté de conscience et l'égalité de tous, quelles que soient leurs convictions. Elle n'impose pas la même obligation à tous les acteurs.

Acteur	Obligation
Agents publics (fonctionnaires, contractuels)	Stricte neutralité religieuse et politique dans l'exercice de leurs fonctions (Code général de la fonction publique)
Salariés d'organismes privés chargés d'une mission de service public	Soumis à la neutralité depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, pour les activités de service public
Salariés d'associations ou d'entreprises privées	Liberté de manifester ses convictions, sauf restrictions justifiées et proportionnées prévues par le règlement intérieur
Usagers (participants, élèves, résidents)	Libres de leurs convictions et de leurs pratiques, dans le respect de l'ordre public et du bon fonctionnement du service (règles spécifiques pour les élèves des écoles, collèges et lycées publics : loi du 15 mars 2004)
Stagiaire	Se conforme aux règles de la structure d'accueil ; en structure publique, adopte la même réserve que les agents

Exemple – Situations fréquentes en atelier ou en restauration

- **Menus de substitution** à la cantine : il n'existe pas d'obligation légale de proposer un plat de substitution au porc ; le Conseil d'État a toutefois rappelé (2020) que la collectivité qui modifie ses pratiques doit prendre en compte l'intérêt des enfants ; de nombreuses collectivités proposent une alternative ou une option végétarienne quotidienne, qui répond au plus grand nombre.
- **Jeûne** : on adapte l'organisation (horaires, repas à emporter) sans exiger ni décourager la pratique, et on veille à la sécurité (hydratation, pathologies, avis médical).
- **Demande de prière ou de pause** pendant un atelier : dans une structure associative, la réponse dépend du règlement intérieur et du bon déroulement de l'activité ; on cherche une solution simple et respectueuse (pause prévue dans le déroulé).
- **Professionnel** : le diététicien n'exprime pas ses propres convictions religieuses ou politiques dans l'exercice de ses fonctions en structure publique ; il respecte et sécurise les pratiques alimentaires des personnes (chapitre 4), sans les juger ni les promouvoir.

Attention – Laïcité et accueil de tous

La laïcité n'est pas un argument pour **exclure** des pratiques alimentaires : elle garantit à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire. Dans une action de santé publique, l'objectif reste l'**accessibilité** de l'action au plus grand nombre (recettes compatibles avec la majorité des pratiques, sans référence religieuse).

Les menus végétariens en restauration collective : liberté de choix et santé publique

La question des menus végétariens illustre bien l'articulation entre **liberté de choix**, **santé publique** et **environnement** dans la restauration collective.

Texte	Contenu	Champ
Loi EGalim du 30 octobre 2018	Expérimentation, à partir de novembre 2019, d'un menu végétarien au moins une fois par semaine	Restauration scolaire
Loi Climat et résilience du 22 août 2021	Pérennisation du menu végétarien hebdomadaire ; expérimentation d'une option végétarienne quotidienne pour les collectivités volontaires	Restauration scolaire
Même loi	Option végétarienne quotidienne lorsque plusieurs menus sont proposés, à partir du 1er janvier 2023	Restaurants collectifs gérés par l'État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales

Ces mesures ne relèvent pas de la **laïcité** : elles ne visent pas des convictions religieuses, mais la diversification des sources de protéines et la réduction de l'impact environnemental. Elles respectent aussi les choix des personnes qui ne mangent pas de viande, quelle qu'en soit la raison.

Sur le plan éthique, un menu végétarien doit rester **équilibré** : il apporte des protéines (légumineuses associées à des céréales, œufs, produits laitiers), du fer et de la vitamine B12 par les produits animaux non carnés quand ils sont présents. Un menu « végétarien » réduit à des pâtes à la sauce tomate ne répond ni à l'objectif de santé ni au respect des convives.

Exemple – Calcul : la part de menus végétariens sur un cycle

Une cantine propose un cycle de 20 déjeuners sur quatre semaines, avec 4 menus végétariens (un par semaine), et une option végétarienne en plus sur 6 autres jours. Part des repas où un plat végétarien est disponible : (4 + 6) / 20 × 100 = **50 %**. Part des repas entièrement végétariens pour tous : 4 / 20 × 100 = **20 %**. Pour les 92 élèves qui ne mangent pas de viande sur 380 inscrits (24,2 %), l'offre végétarienne quotidienne n'est pas encore atteinte : la commune peut s'engager dans l'expérimentation prévue par la loi.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.3.14 et 6.3.15 – Dilemmes, laïcité, menus

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Quand la protection d'une personne peut-elle passer avant le secret ?
2. Pourquoi faut-il informer la personne de ce que l'on va faire, même quand on rompt la confidentialité pour la protéger ?
3. Les agents publics et les usagers du service public ont-ils les mêmes obligations de neutralité ?
4. Existe-t-il une obligation légale de proposer un plat de substitution au porc à la cantine ?
5. Depuis quelle loi le menu végétarien hebdomadaire est-il pérennisé en restauration scolaire ?
6. Sur 20 déjeuners, 5 sont végétariens. Calculez le pourcentage.

Corrigé – Point d'étape 6.3.14 et 6.3.15

1. Quand il existe un danger grave pour une personne vulnérable (mineur, personne qui ne peut pas se protéger).
2. Pour préserver la confiance, respecter sa dignité et l'associer autant que possible à la suite.
3. Non : les agents publics sont tenus à la neutralité ; les usagers sont libres de leurs convictions, dans le respect de l'ordre public et du bon fonctionnement du service.
4. Non, mais la collectivité doit prendre en compte l'intérêt des enfants si elle modifie ses pratiques.

5. La loi Climat et résilience du 22 août 2021.
6. 5 / 20 × 100 = 25 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe au fil rouge et au cas guidé.
3 ou 4 sur 6	Je relis les dilemmes et le tableau sur la laïcité.
Moins de 3 sur 6	Je relis les parties 6.3.14 et 6.3.15 et je refais les exercices d'application.

6.3.16 Fil rouge : les choix éthiques d'Inès

Module · Référentiel et guide : voir 6.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Fil rouge – centre social des tilleuls – Ce qu'Inès a mis en place

- **Confidentialité** : cadre énoncé à chaque atelier (« ce qui se dit ici reste ici ») ; aucune information individuelle transmise à l'école ou au CCAS, seulement des données agrégées.
- **RGPD** : questionnaire de diagnostic anonyme (ni nom ni adresse, âge en tranches), mention d'information en tête ; questionnaires saisis puis détruits ; fichier protégé par mot de passe sur l'ordinateur du centre social ; suppression prévue le 15 septembre 2028.
- **Droit à l'image** : 12 autorisations distribuées, 9 signées pour les adultes ; pour les enfants, 7 autorisations signées par les deux parents sur 15 enfants présents : 7 / 15 × 100 = **46,7 %**. Inès a donc photographié surtout les mains et les plats et flouté les autres visages.
- **Conflit d'intérêts** : une enseigne de biscuits a proposé d'offrir les goûters ; Inès et sa tutrice ont refusé, car le thème de l'atelier était justement les goûters faits maison ; la supérette du quartier a fourni les fruits contre une simple mention « avec le soutien de » au bas de l'affiche, après accord de la direction.
- **Non-stigmatisation** : aucune pesée, aucune image de corps, vocabulaire « plaisir, petit budget, famille ».

Fil rouge – centre social des tilleuls – Compléments : sécurité, allégations et droits aux Tilleuls

- **Sécurité des ateliers** : fiche d'inscription avec allergies et contacts d'urgence (12 fiches, 2 allergies signalées : arachide et kiwi) ; affichage des allergènes de chaque recette ; trousse de secours ; numéros d'urgence affichés ; une brûlure légère (atelier 3) consignée dans le cahier de liaison et signalée à la tutrice, sans suite.
- **Convention de stage** : assurance responsabilité civile de l'établissement de formation et du centre social ; Inès n'utilise jamais le four avec les enfants sans la présence de l'animatrice.
- **Allégations** : en préparant l'atelier « étiquettes », Inès a repéré un biscuit « riche en fibres » à 4,8 g pour 100 g : allégation non conforme (seuil de 6 g) ; elle en a fait un exercice de littératie critique et l'a signalé à sa tutrice.
- **Droits et dignité** : le projet a été présenté au conseil d'administration du centre social, auquel participent des habitants ; les familles orientées par l'épicerie solidaire choisissaient librement de participer, et leur participation n'était pas une condition d'accès à l'épicerie.
- **Numérique** : aucune photo d'Inès avec les familles n'a été publiée sur ses comptes personnels ; les publications du centre social respectaient les autorisations par support.

6.3.17 Cas guidé : repérer la dénutrition des seniors à domicile

Module · Référentiel et guide : voir 6.2.1 · CNED : pas de passage correspondant (voir 6.2.2)

Ce cas guidé reprend l'ensemble des notions du chapitre sur un même projet. Lisez la situation, essayez de répondre à chaque question, puis comparez avec la réponse commentée.

Mise en situation – Le projet du CCAS de Val-Fleuri (données fictives)

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Val-Fleuri livre chaque jour des repas à 140 personnes âgées de 75 ans et plus. Les livreurs constatent que certains plateaux reviennent presque pleins. Le CCAS veut lancer un projet de repérage de la dénutrition : les livreurs noteraient chaque jour les restes sur une tablette, une diététicienne pèserait les bénéficiaires à domicile tous les trois mois, et les résultats seraient transmis aux médecins traitants et aux familles. Un fabricant de compléments nutritionnels oraux propose de fournir gratuitement les tablettes, en échange de la liste des personnes « à risque » pour leur envoyer des échantillons.

Question 1 – Quels sont les bénéfices attendus et les risques éthiques du projet ?

Bénéfices (bienfaisance) : la dénutrition est fréquente chez les personnes âgées vivant à domicile, souvent méconnue, et elle augmente le risque de chutes, d'infections et d'hospitalisation ; un repérage précoce permet d'agir (enrichissement, aide aux repas, orientation médicale). Risques : atteinte à la vie privée (surveillance quotidienne des restes), sentiment d'être contrôlé, données de santé recueillies par des personnes non soignantes, transmission aux familles sans accord, utilisation commerciale des données par le fabricant.

Question 2 – Quelles règles s'appliquent aux données recueillies ?

Le relevé des restes et le poids sont des données de santé (catégorie particulière du RGPD). Le CCAS, responsable du traitement, doit définir une finalité précise (repérer un risque de dénutrition pour proposer un accompagnement), une base légale (mission d'intérêt public, avec l'exception de l'article 9 relative à la prise en charge sociale ou sanitaire), informer chaque bénéficiaire, ne recueillir que le nécessaire (un relevé simple « tout, la moitié, presque rien » plutôt qu'un détail par plat), limiter l'accès aux personnes habilitées, sécuriser la tablette et fixer une durée de conservation. Plusieurs critères de la CNIL sont réunis (données de santé, personnes vulnérables, suivi systématique) : une analyse d'impact est nécessaire. Le délégué à la protection des données de la commune est consulté.

Question 3 – Le secret permet-il de transmettre les résultats aux médecins et aux familles ?

Le médecin traitant ne fait pas partie de la même équipe que le CCAS : la transmission suppose l'**accord** de la personne. Les familles ne sont pas des professionnels : rien ne leur est transmis sans l'accord de la personne âgée, qui reste un adulte capable de décider, sauf mesure de protection juridique et dans les limites de celle-ci. La personne de confiance peut être associée si la personne le souhaite.

Question 4 – Comment recueillir le consentement des bénéficiaires ?

Lors d'une visite, la diététicienne présente le projet à l'oral et avec un document simple en gros caractères : le but, ce qui est noté, qui le verra, la possibilité de refuser sans que la livraison des repas change. Elle vérifie la compréhension (« pouvez-vous me redire ce que nous allons noter ? ») et recueille un accord écrit pour la pesée et pour la transmission au médecin. Pour les personnes présentant des troubles cognitifs, on recherche leur assentiment et l'on associe la personne de confiance ou le représentant légal selon la situation.

Question 5 – Que répondre au fabricant de compléments ?

La proposition est à **refuser** : la transmission d'une liste de personnes « à risque » à une entreprise serait une violation du secret et du RGPD (utilisation commerciale de données de santé, sans consentement et pour une finalité étrangère au projet), et l'envoi d'échantillons à des personnes vulnérables relève de la promotion. Le CCAS peut chercher d'autres financements pour les tablettes (conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, caisse de retraite, budget communal) et, si des compléments sont nécessaires, ils sont prescrits par le médecin.

Question 6 – Comment rendre le projet plus respectueux et plus juste ?

Remplacer le relevé quotidien systématique par un relevé simple une semaine par mois, ou seulement chez les personnes qui l'ont accepté ; proposer la pesée lors de la visite annuelle plutôt que tous les trois mois, et seulement si elle est utile ; former les livreurs à repérer et à signaler avec tact, sans commentaire devant la personne ; associer des bénéficiaires et le conseil d'administration du CCAS à la conception ; prévoir des

réponses concrètes (portage adapté, aide aux courses, repas partagés au foyer-restaurant) pour que le repérage débouche sur une aide.

Exemple – Calcul : estimer la charge du repérage

Avec 140 bénéficiaires et une pesée tous les trois mois, il faut 140 × 4 = **560** visites par an. À raison de 30 minutes par visite, déplacement compris, cela représente 560 × 0,5 = **280 heures** de diététicienne par an. Avec une pesée annuelle seulement pour les personnes qui l'acceptent (par exemple 70 % d'entre elles, soit 98 personnes), on passe à 98 × 0,5 = **49 heures**, ce qui libère du temps pour accompagner les personnes repérées. La proportionnalité est aussi une question de bon usage des ressources.

6.4 Approfondissements

6.4.1 Le diététicien sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont un canal de prévention puissant, mais ils exposent à des risques déontologiques : conseils individualisés donnés publiquement sans bilan, promotion de produits (placement de produits, codes promotionnels), images de « transformations » corporelles, publication de photos d'ateliers sans autorisation, réponses à des personnes présentant des signes de TCA. La loi du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale impose notamment d'indiquer clairement la **nature publicitaire** d'un contenu et interdit certaines promotions. Le diététicien reste tenu par son code de déontologie : **information loyale**, **indépendance**, **secret**, **orientation**.

Méthode pas à pas – Cinq règles pour une publication professionnelle

1. Ne publier que des contenus **sourcés** et à jour (repères officiels).
2. Ne jamais publier de photo de participants sans **autorisation écrite** spécifique aux réseaux sociaux.
3. Signaler tout partenariat ou avantage reçu (« collaboration commerciale »).
4. Ne pas donner de conseil individualisé en commentaire : orienter vers une consultation.
5. Éviter les avant/après corporels et le vocabulaire de la minceur.

Créer un compte de prévention : la charte éditoriale

Une structure (centre social, service de santé, association) qui ouvre un compte sur un réseau social pour diffuser des messages de prévention a intérêt à écrire une **charte éditoriale**. Ce document court fixe les règles de publication et de modération, et il protège à la fois le public et les professionnels.

Rubrique de la charte	Contenu (exemple)
Objectif du compte	Informer les habitants sur les ateliers et diffuser des repères de nutrition fiables
Public visé	Familles du quartier, adolescents, seniors
Sources autorisées	Santé publique France, Anses, Haut Conseil de la santé publique, sociétés savantes ; chaque contenu est daté
Ce que l'on ne publie pas	Photos de participants sans autorisation spécifique aux réseaux sociaux ; images de corps, avant/après ; marques et produits ; conseils individualisés
Validation	Chaque publication est relue par une deuxième personne de l'équipe avant diffusion
Modération	Réponse sous 48 heures ouvrées aux questions générales ; orientation en message privé vers une consultation pour les questions personnelles ; suppression des propos injurieux, discriminants ou publicitaires

Rubrique de la charte	Contenu (exemple)
Partenariats	Aucun partenariat commercial ; les soutiens institutionnels sont mentionnés sobrement
Données	Aucune collecte de données des abonnés en dehors des statistiques globales de la plateforme

Méthode pas à pas – Vérifier une publication avant de la diffuser

1. **Exactitude** : l'information est-elle conforme à une source officielle récente ?
2. **Clarté** : une personne qui lit peu comprend-elle le message en dix secondes ?
3. **Respect** : le message ou l'image peut-il blesser, stigmatiser ou culpabiliser quelqu'un ?
4. **Image et données** : toutes les personnes reconnaissables ont-elles autorisé cette diffusion sur ce réseau ?
5. **Indépendance** : une marque apparaît-elle sur la photo (emballage, logo) ?
6. **Source** : la référence et la date sont-elles indiquées ?

Exemple – Calcul : suivre l'impact d'un compte

Le compte d'un centre social (exemple fictif) a publié 24 messages en trois mois. Les publications « recette petit budget » ont obtenu en moyenne 180 vues et 12 partages ; les publications « repères nutritionnels » 95 vues et 3 partages. Taux de partage : 12 / 180 × 100 = **6,7 %** pour les recettes, 3 / 95 × 100 = **3,2 %** pour les repères. Les recettes concrètes intéressent davantage : l'équipe décide d'intégrer les repères dans les recettes (« cette soupe compte pour deux portions de légumes »). Ces chiffres mesurent l'audience, pas le changement de comportement : ils ne suffisent pas à évaluer l'action.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.31

Un animateur veut publier sur le compte du centre social une photo prise pendant l'atelier : on y voit trois participantes souriantes, une boîte de céréales de marque au premier plan, avec le texte « Nos mamans apprennent enfin à bien nourrir leurs enfants ! ». Appliquez la méthode de vérification et proposez une version corrigée.

Corrigé

Exactitude : le message ne contient aucune information de nutrition. Respect : « enfin » et « apprennent à bien nourrir » sont condescendants et culpabilisants ; « nos mamans » réduit les participantes à leur rôle de mère. Image : il faut vérifier que les trois participantes ont autorisé la diffusion sur ce réseau. Indépendance : la marque de céréales doit être retirée du cadre. Source : sans objet ici. Version corrigée : une photo des mains et des plats, sans emballage de marque, avec le texte « Atelier du mardi : crêpes et compote maison pour le goûter, moins de 50 centimes la part ! Prochain atelier le 14 mars, ouvert à tous. »

6.4.2 Les partenariats public-privé en nutrition

Les partenariats avec l'industrie agroalimentaire ou la grande distribution peuvent apporter des moyens (locaux, produits, financements), mais soulèvent des questions de **crédibilité** et d'**indépendance** : l'industrie peut utiliser l'action comme outil de communication (« marketing de la bonne cause »). Les recommandations internationales (OMS) invitent à une **analyse de risque** avant tout partenariat : objectifs compatibles avec la santé, absence de promotion de produits, contrôle des contenus par la partie publique, transparence des financements, possibilité de rompre. Le PNNS distingue ainsi ses messages institutionnels des communications commerciales (la mention « Pour votre santé… » des publicités alimentaires en est l'illustration).

Une grille chiffrée pour décider d'un partenariat

Pour éviter de décider « au feeling », une structure peut analyser chaque proposition de partenariat avec une grille de critères notés. La grille ne remplace pas la réflexion, mais elle rend la décision **transparente** et **comparable** d'une proposition à l'autre.

Critère	0 point	1 point	2 points
Cohérence des produits ou activités du partenaire avec les messages de santé	Contradictoire	Neutre	Cohérent
Visibilité demandée	Logo, produit mis en avant	Mention discrète	Aucune
Maîtrise des contenus	Le partenaire intervient sur les messages	Relecture demandée	Liberté totale de la structure
Accès aux participants ou à leurs données	Demandé	Indirect (enquête)	Aucun
Convention écrite	Refusée	Partielle	Complète
Durée et dépendance financière	Plus de 30 % du budget	10 à 30 %	Moins de 10 %
Transparence	Le partenaire refuse d'être mentionné	Mention partielle	Mention publique claire

Règle de décision proposée : 12 à 14 points, partenariat acceptable ; 8 à 11 points, à négocier ; moins de 8 points ou un seul 0 sur les critères « cohérence » ou « données », refus.

Exemple – Appliquer la grille à deux propositions

Proposition A : une mutuelle finance 600 € d'ingrédients pour un budget de 5 000 €, demande une mention dans le bilan, n'intervient pas sur les contenus et signe une convention. Cohérence 2, visibilité 1, contenus 2, données 2, convention 2, dépendance : 600 / 5 000 × 100 = 12,0 %, soit 1 point, transparence 2. Total : **12 points**, partenariat acceptable.

Proposition B : une enseigne de restauration rapide offre 1 500 € en échange de son logo sur les affiches et d'un stand de dégustation. Cohérence 0, visibilité 0, contenus 1, données 2, convention 1, dépendance : 1 500 / 5 000 × 100 = 30,0 %, soit 1 point, transparence 2. Total : **7 points**, avec un 0 en cohérence : refus.

Attention – Les limites de la grille

Une grille peut donner une impression d'objectivité trompeuse. Les seuils sont des choix de l'équipe et doivent être discutés. Certains critères comptent plus que d'autres (une collecte de données à des fins commerciales justifie à elle seule un refus). Enfin, la grille doit être appliquée **avant** de connaître le montant, pour ne pas être tenté de l'ajuster au profit d'une proposition généreuse.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.32

Une coopérative de producteurs de fruits propose de fournir gratuitement des fruits de saison (valeur 400 € pour un budget de 3 200 €) pour des ateliers en école, avec son nom sur le bilan, sans intervention sur les contenus, avec une convention complète. Elle demande seulement à distribuer un dépliant de recettes à son nom. Calculez la part du budget, notez la proposition avec la grille et concluez.

Corrigé

Part : 400 / 3 200 × 100 = 12,5 %, soit 1 point. Cohérence 2 ; visibilité : le dépliant à son nom est une mise en avant, 0 ou 1 selon sa présentation (1 si les recettes sont neutres et sans promotion de marque) ; contenus 2 ; données 2 ; convention 2 ; transparence 2. Total : 11 ou 12 points. Conclusion : partenariat acceptable ou à négocier ; on peut demander de remplacer le dépliant par une simple mention, ou relire le dépliant pour

vérifier qu'il ne contient que des recettes conformes aux repères, sans message publicitaire.

6.4.3 La participation des personnes : une exigence éthique

Associer les personnes concernées à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation d'une action (habitants, usagers, patients partenaires) est à la fois un principe de promotion de la santé (Charte d'Ottawa, chapitre 1), une condition d'efficacité et une exigence de **respect** : on ne fait pas « pour » les gens sans eux. Elle suppose de reconnaître leurs savoirs d'expérience, de rémunérer ou défrayer leur contribution quand c'est possible et de leur restituer les résultats.

L'échelle de la participation d'Arnstein

En 1969, la sociologue américaine Sherry Arnstein a proposé une **échelle de la participation citoyenne** en huit barreaux, regroupés en trois niveaux. Elle reste un outil simple pour évaluer si un projet associe réellement les personnes ou s'il se contente de les informer.

Niveau	Barreaux (du bas vers le haut)	Ce que cela donne dans un projet de nutrition
Non-participation	1. Manipulation ; 2. Thérapie (au sens d'« éduquer » les personnes pour qu'elles acceptent)	On fait signer une liste de présence pour prouver la « participation » ; on organise une réunion pour convaincre les habitants d'un projet déjà décidé
Participation symbolique	3. Information ; 4. Consultation ; 5. Conciliation (quelques représentants associés, sans pouvoir réel)	Affiche annonçant les ateliers ; questionnaire sur les attentes ; un habitant invité au comité de pilotage
Pouvoir effectif des citoyens	6. Partenariat ; 7. Délégation de pouvoir ; 8. Contrôle citoyen	Les habitants choisissent les recettes et les horaires avec l'équipe ; un groupe d'habitants gère un budget pour les ateliers ; une association d'habitants porte elle-même le projet

La plupart des projets se situent aux barreaux 3 et 4 (information et consultation). Ce n'est pas une faute, mais l'échelle invite à se demander si l'on peut **monter d'un barreau** : passer d'un questionnaire de satisfaction à un groupe d'habitants qui co-construit le prochain cycle, par exemple.

Lien diététique – Participation et efficacité

La participation n'est pas seulement un principe éthique. Les actions construites avec les personnes concernées sont en général mieux adaptées à leurs habitudes, à leur budget et à leur culture, et elles mobilisent davantage. C'est un argument que le diététicien peut utiliser face à un financeur qui juge la concertation trop longue.

Exemple – Situer un projet sur l'échelle

Un projet « petits déjeuners » dans un collège (exemple fictif) : l'infirmière a choisi les produits, une affiche a informé les élèves, et un questionnaire de satisfaction a été distribué à la fin. Position : barreaux 3 (information) et 4 (consultation). Pour monter d'un barreau, on peut constituer un groupe d'élèves volontaires, avec des délégués, qui choisit une partie des produits dans un budget donné, organise le service et présente les résultats au conseil d'administration : on atteint le partenariat (barreau 6).

À vous de jouer – Exercice d'application 6.33

Situez chaque pratique sur l'échelle d'Arnstein : a) une commune présente aux parents les nouveaux menus

de la cantine, déjà votés ; b) un comité de résidents d'un foyer décide du budget des repas festifs ; c) une association invite un habitant au comité de pilotage, mais les décisions sont prises avant la réunion ; d) un questionnaire demande aux familles leurs préférences pour les ateliers.

Corrigé

a) Information (barreau 3), voire thérapie si l'objectif est seulement de faire accepter une décision. b) Délégation de pouvoir (barreau 7). c) Conciliation (barreau 5), participation symbolique : la présence ne donne aucun pouvoir réel. d) Consultation (barreau 4).

6.4.4 Éthique et intelligence artificielle en santé

L'usage d'outils d'intelligence artificielle (IA) pour rédiger des supports, analyser des données ou répondre au public soulève des questions éthiques : **confidentialité** (ne jamais saisir de données personnelles ou de santé dans un outil non sécurisé), **exactitude** (erreurs présentées avec assurance), **biais** (les données d'apprentissage peuvent reproduire des stéréotypes), **transparence** (indiquer quand un contenu a été produit avec l'aide d'une IA), **responsabilité** (le professionnel reste responsable de ce qu'il diffuse). Le règlement européen sur l'intelligence artificielle (*AI Act*, 2024) classe les usages selon leur niveau de risque et impose des obligations progressives. Dans le cadre d'une formation et d'un examen, présenter comme sien un travail produit par une IA ou par une autre personne relève en outre de la **fraude**, contraire à l'intégrité académique.

Le règlement européen sur l'IA et l'usage professionnel des outils

Le règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, entré en vigueur le 1er août 2024, classe les systèmes d'IA selon leur **niveau de risque** et fixe des obligations proportionnées. Ses dispositions s'appliquent par étapes : interdictions depuis le 2 février 2025, règles pour les modèles d'IA à usage général depuis le 2 août 2025, obligations de transparence depuis le 2 août 2026 ; le règlement (UE) 2026/1744 du 24 juillet 2026 a reporté les obligations des systèmes à haut risque au 2 décembre 2027 (et au 2 août 2028 pour ceux intégrés à des produits).

Niveau de risque	Exemples	Règle
Inacceptable	Notation sociale des personnes, manipulation qui exploite la vulnérabilité liée à l'âge ou au handicap	Interdit
Élevé	Certains dispositifs médicaux intégrant de l'IA, systèmes qui décident de l'accès à des prestations sociales	Obligations strictes : gestion des risques, qualité des données, documentation, contrôle humain
Transparence	Agents conversationnels, contenus générés ou modifiés par IA (images, vidéos truquées)	Informer les personnes qu'elles échangent avec une IA ou qu'un contenu a été généré
Minimal	Filtres anti-spam, correcteurs d'orthographe	Pas d'obligation particulière

Pour le diététicien, les outils d'IA générative (rédaction, traduction, résumé) sont utiles pour gagner du temps, mais ils peuvent produire des **erreurs présentées avec assurance**, inventer des références, reproduire des **biais** (stéréotypes culturels sur l'alimentation, modèles alimentaires occidentaux pris comme norme) et poser des problèmes de **confidentialité**.

Méthode pas à pas – Utiliser une IA générative pour un support d'atelier

1. Vérifier les règles : la structure ou l'établissement de formation autorise-t-il l'outil, et pour quel usage ?

2. Ne saisir aucune donnée personnelle : pas de nom, pas d'information de santé, pas de situation identifiable.

3. Formuler une demande précise : public, niveau de langue, longueur, sources à respecter.

4. Vérifier chaque information dans une source officielle datée (repères, seuils, chiffres) et corriger.

5. Relire le ton : pas de culpabilisation, pas de stéréotype, exemples adaptés au public réel.

6. Tester avec le public : faire relire par une ou deux personnes concernées (« faire dire », chapitre 5).

7. Être transparent : indiquer, quand c'est pertinent, qu'un outil a aidé à la rédaction ; le professionnel reste responsable du contenu.

Exemple – Vérifier un texte produit par une IA

Un outil propose pour une affiche : « Les adultes doivent manger 5 fruits par jour, boire 3 litres d'eau et éviter totalement le sucre. » Vérification avec les recommandations de Santé publique France (2019) : le repère est **au moins 5 fruits et légumes** par jour (et non 5 fruits) ; la quantité d'eau n'est pas fixée à 3 litres pour tous, on recommande de boire de l'eau à volonté, les besoins variant selon la personne, la chaleur et l'activité ; il est conseillé de **limiter** les produits sucrés et les boissons sucrées, pas de supprimer tout sucre. Trois erreurs en une phrase : le texte ne peut pas être utilisé sans correction.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.34

Une collègue a demandé à un outil d'IA un « menu type pour une famille musulmane pendant le ramadan ». La réponse présente un menu unique, très riche en fritures et en pâtisseries, comme « le menu traditionnel ». Relevez deux problèmes et proposez une meilleure façon de préparer ce support.

Corrigé

Problèmes : stéréotype culturel (un menu unique présenté comme « traditionnel » alors que les habitudes varient selon les pays, les régions et les familles) ; message implicitement jugeant sur la qualité de cette alimentation ; informations non vérifiées. Meilleure démarche : construire le support avec des familles concernées ou une médiatrice, partir de leurs plats habituels, valoriser ce qui est déjà favorable (soupes, dattes, légumineuses, eau), proposer des adaptations choisies (cuissons, hydratation, répartition sur la soirée), et vérifier les repères dans des sources officielles.

6.4.5 Le consentement des personnes vulnérables

Certaines personnes ont une capacité de décision limitée ou fluctuante : enfants, personnes âgées présentant des troubles cognitifs, personnes en situation de handicap intellectuel, personnes sous mesure de protection (tutelle, curatelle). Le principe reste de **rechercher leur adhésion** (assentiment), avec une information adaptée (FALC, chapitre 5), et d'associer, selon le cas, les représentants légaux, la personne de confiance ou l'entourage. On ne fait jamais participer quelqu'un « parce que c'est bon pour lui » contre son refus exprimé.

Les mesures de protection juridique des majeurs

Certaines personnes majeures ne peuvent plus pourvoir seules à leurs intérêts en raison d'une altération de leurs facultés (maladie, handicap, troubles cognitifs). Le juge des contentieux de la protection peut alors prononcer une mesure de protection. Le diététicien doit savoir de quoi il s'agit, car la mesure ne supprime **pas** les droits de la personne sur les décisions qui touchent à sa vie personnelle, dont son alimentation.

Mesure	Principe	Ce que cela signifie pour l'alimentation et la santé
Sauvegarde de justice	Protection temporaire et légère ; la personne conserve l'exercice de ses droits	Elle décide seule

Mesure	Principe	Ce que cela signifie pour l'alimentation et la santé
Curatelle	La personne est assistée par un curateur pour les actes importants, surtout financiers	Elle prend elle-même les décisions relatives à sa personne, y compris sur ses repas et ses soins, après information
Tutelle	La personne est représentée par un tuteur pour les actes de la vie civile	Pour les décisions relatives à sa personne, elle décide seule dans la mesure où son état le permet ; sinon, le juge peut prévoir l'assistance ou la représentation du tuteur, en tenant compte de son avis
Habilitation familiale	Un proche (enfant, conjoint, frère ou sœur) est autorisé par le juge à représenter ou assister la personne	Même principe : l'avis de la personne est recherché et respecté autant que possible

Le Code civil prévoit que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne **dans la mesure où son état le permet**, et que la protection est exercée dans le respect de ses droits et de sa **dignité**. Une famille ou un tuteur ne peut donc pas imposer un régime alimentaire restrictif à un adulte qui peut exprimer ses choix.

Exemple – Un adulte sous curatelle et le choix de ses repas

M. A., 45 ans, vit dans un foyer pour adultes en situation de handicap et bénéficie d'une curatelle. Son curateur demande qu'on lui supprime les desserts, car il a pris du poids. La curatelle porte sur la gestion de ses biens, pas sur ses choix de vie quotidienne : la diététicienne explique au curateur que la décision appartient à M. A. Elle propose à M. A. un entretien pour parler de ce qui est important pour lui, des desserts qu'il aime, et des petits changements qu'il souhaiterait (fruits au goûter, desserts maison moins sucrés), en lien avec le médecin du foyer.

Point d'étape – Je teste mes acquis – 6.4 – Approfondissements

Répondez sans regarder le cours, puis corrigez-vous. Comptez 1 point par réponse juste.

1. Citez trois rubriques d'une charte éditoriale pour un compte de prévention.
2. Avec la grille de partenariat, que décide-t-on si un critère « données » obtient 0 point ?
3. Quels sont les trois niveaux de l'échelle d'Arnstein ?
4. Que doit-on indiquer aux personnes qui échangent avec un agent conversationnel, selon le règlement européen sur l'IA ?
5. Un curateur peut-il décider à la place d'une personne de ce qu'elle mange ?
6. Une proposition apporte 900 € sur un budget de 6 000 €. Quelle part du budget représente-t-elle ?

Corrigé – Point d'étape 6.4

1. Objectif, public, sources autorisées, ce que l'on ne publie pas, validation, modération, partenariats, données.
2. On refuse la proposition.
3. Non-participation, participation symbolique, pouvoir effectif des citoyens.
4. Qu'elles échangent avec une IA.
5. Non : la curatelle porte surtout sur les actes financiers importants ; la personne décide elle-même de sa vie quotidienne.
6. 900 / 6 000 × 100 = 15 %.

Mon score	Ce que je fais
6 ou 5 sur 6	Je passe à la partie « Pour aller plus loin ».

6.5 Pour aller plus loin – niveau Licence 3

Pour aller plus loin – niveau L3 – Justice sociale et capabilités

Deux grandes théories éclairent le principe de justice en santé publique. **John Rawls** (*Théorie de la justice*, 1971) propose que les inégalités ne soient acceptables que si elles profitent aux plus défavorisés (principe de différence). **Amartya Sen** et **Martha Nussbaum** développent l'approche par les **capabilités** : ce qui compte n'est pas seulement les ressources (revenu, informations), mais la **liberté réelle** des personnes de les convertir en états de santé (savoir cuisiner, avoir un équipement, du temps, un environnement favorable). Cette approche justifie d'agir sur les **environnements** et sur les **compétences**, pas seulement sur l'information.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Le débat sur le paternalisme en santé publique

Les mesures nutritionnelles contraignantes (taxes, interdictions publicitaires, logos obligatoires) sont parfois critiquées comme **paternalistes** : l'État déciderait à la place des individus. Les défenseurs répondent que les choix alimentaires sont déjà fortement orientés par le marketing et l'environnement, et que la régulation **rétablit** des conditions de choix plus libres ; ils invoquent aussi l'**équité** (les mesures structurelles bénéficient davantage aux personnes défavorisées) et la protection des **enfants**. L'éthique de santé publique ne tranche pas a priori : elle exige une justification au cas par cas (efficacité, proportionnalité, nécessité, moindre atteinte, transparence).

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'éthique du care

Développée par Carol Gilligan (*Une voix différente*, 1982) et Joan Tronto, l'éthique du **care** (« prendre soin ») insiste sur l'**attention** aux besoins concrets, la **responsabilité**, la **compétence** et la **réceptivité** des personnes aidées. Elle complète les principes abstraits par une attention à la **relation** et à la vulnérabilité, particulièrement pertinente auprès des personnes âgées isolées, des personnes précaires ou en situation de handicap.

Pour aller plus loin – niveau L3 – L'éthique de la discussion et la délibération

Le philosophe Jürgen **Habermas** a développé une **éthique de la discussion** : une norme est légitime si elle peut être acceptée par toutes les personnes concernées à l'issue d'une discussion libre et argumentée. Appliquée à la santé publique, cette approche justifie la **délibération** avec les usagers et les citoyens (démocratie en santé, conseils de la vie sociale, jurys citoyens, conventions citoyennes) avant des décisions qui touchent leur vie quotidienne, comme l'organisation des repas ou les mesures nutritionnelles contraignantes.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Justice alimentaire et démocratie alimentaire

Le mouvement de la **justice alimentaire**, né aux États-Unis dans les années 1990, part d'un constat : l'accès à une alimentation saine, durable et culturellement adaptée est inégalement réparti selon le revenu, le quartier et l'origine. Il ne s'agit pas seulement de distribuer de la nourriture, mais de transformer les systèmes alimentaires pour que chacun puisse choisir. En France, la notion de **démocratie alimentaire** prolonge cette idée : les citoyens devraient pouvoir participer aux décisions sur ce qui est produit, distribué et mangé sur leur territoire. Plusieurs expérimentations locales de « sécurité sociale de l'alimentation » (caisses alimentaires communes alimentées par des cotisations et gérées par des comités citoyens, depuis le début des années 2020) s'inscrivent dans cette réflexion ; leurs résultats sont encore en cours d'évaluation. Pour le

diététicien, cette approche invite à dépasser l'éducation individuelle pour agir aussi sur l'offre (épiceries solidaires, restauration collective, circuits courts accessibles) et sur la gouvernance (projets alimentaires territoriaux, conseils locaux de l'alimentation).

Pour aller plus loin – niveau L3 – Une seule santé : l'éthique au-delà de l'humain

L'approche **Une seule santé** (*One Health*), promue par l'OMS, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé animale et le Programme des Nations unies pour l'environnement, considère que la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes sont étroitement liées. Elle élargit la réflexion éthique en nutrition : un régime alimentaire peut être favorable à la santé d'une personne mais coûteux pour l'environnement (forte consommation de produits animaux, gaspillage), ou au contraire durable mais inaccessible financièrement. Elle pose des questions de **justice entre générations** (que laissons-nous aux générations futures ?) et de **justice mondiale** (qui supporte les coûts environnementaux de notre alimentation ?). Les recommandations alimentaires françaises de 2019 intègrent déjà certains de ces enjeux (privilégier les produits de saison, les légumineuses, limiter la charcuterie et la viande hors volaille). L'enjeu éthique est de ne pas faire porter l'effort sur les plus modestes, pour qui le prix reste le premier critère de choix.

Pour aller plus loin – niveau L3 – Autonomie relationnelle et vulnérabilité

La conception classique de l'autonomie imagine un individu rationnel qui décide seul, après information. Des philosophes, notamment dans le courant féministe (Catriona Mackenzie et Natalie Stoljar, *Relational Autonomy*, 2000), proposent la notion d'**autonomie relationnelle** : nos capacités de choisir se construisent dans nos relations et dépendent de nos conditions de vie. Une personne isolée, précaire ou dépendante n'a pas les mêmes possibilités de choix qu'une autre, même si elle est parfaitement informée. Respecter son autonomie, c'est alors aussi **renforcer ses capacités** (pouvoir d'agir, ressources, soutien social), ce qui rejoint la notion d'*empowerment* de la promotion de la santé et l'approche par les capabilités d'Amartya Sen.

6.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation bc1 – Secret et entourage

La fille d'une patiente âgée appelle le diététicien pour connaître « ce que maman a dit en consultation ». Il ne transmet rien sans l'accord de la patiente, propose une consultation à trois si la patiente le souhaite.

Situation bc2 – Allergies et données

En restauration scolaire, la liste des enfants allergiques (projets d'accueil individualisés) est une donnée de santé : elle est accessible aux seuls agents qui en ont besoin, n'est pas affichée nominativement en salle de restauration et est mise à jour chaque année.

Situation bc3 – Une campagne choc ?

Une mairie veut une affiche « Stop à l'obésité de nos enfants » avec une photo d'enfant en surpoids. Le diététicien argumente (non-malfaisance, stigmatisation, inefficacité) et propose une affiche positive centrée sur les goûters et le jeu.

Situation bc3 – Un financement à analyser

Un fabricant de boissons propose de financer un tournoi sportif « bien manger, bien bouger » dans un collège. Le diététicien analyse le conflit d'intérêts, informe le chef d'établissement et propose des financements alternatifs (ARS, collectivité, mutuelle).

Situation bc2 – Une allégation sur le menu

Un prestataire propose d'afficher « menu riche en protéines » au self d'un EHPAD. Le diététicien vérifie la composition (part de l'énergie apportée par les protéines) et préfère un affichage factuel et compréhensible, sans allégation non justifiée.

Situation bc3 – Une allergie en atelier

Une participante présente des démangeaisons après une dégustation. Le diététicien applique le protocole (arrêt, appel du 15 en cas de signe de gravité, information de la structure), puis analyse l'incident : l'allergie n'avait pas été déclarée ; la fiche d'inscription est complétée par une question orale à chaque séance.

Méthodes pour l'épreuve E5 : réussir les questions d'éthique

Les questions d'éthique et de cadre juridique sont présentes dans la plupart des sujets de l'épreuve E5, souvent sous la forme : « Identifiez les enjeux éthiques », « Proposez une conduite à tenir », « Justifiez au regard de la réglementation », « Analysez la proposition de partenariat ». Les méthodes suivantes permettent de répondre de façon structurée.

Méthode 1 – Identifier les enjeux éthiques d'une situation en cinq minutes

1. Repérer les personnes concernées : public, familles, professionnels, partenaires, financeurs.

2. Repérer les « mots signaux » dans le document : photo, questionnaire, nom, poids, logo, gratuit en échange de, confidence, enfant, obligatoire, liste, réseau social.

3. Associer chaque mot signal à une notion : photo, droit à l'image ; questionnaire nominatif, RGPD ; logo, conflit d'intérêts ; confidence, secret ; obligatoire, autonomie ; poids, non-malfaisance et stigmatisation ; public modeste, justice.

4. Rédiger un enjeu par paragraphe : notion, élément précis du document, risque concret, piste de solution.

Méthode 2 – Justifier par un texte sans se tromper

Citez le texte avec son **nom** et sa **date** quand vous en êtes sûr (« le RGPD, applicable depuis le 25 mai 2018 » ; « l'article 9 du Code civil »). Si vous n'êtes pas sûr du numéro d'article, citez le principe et le texte général (« le secret professionnel prévu par le Code pénal »). Une référence fausse affaiblit la copie ; une référence générale exacte suffit souvent. Ajoutez toujours **l'application concrète** à la situation : le jury évalue la capacité à utiliser la règle, pas seulement à la réciter.

Formulation de la question	Ce qui est attendu
« Identifiez »	Une liste organisée d'enjeux, chacun relié à un élément du document
« Analysez »	Les enjeux, leurs causes, leurs conséquences et les tensions entre principes
« Justifiez »	Un argument fondé sur un principe ou un texte, appliqué à la situation

Formulation de la question	Ce qui est attendu
« Proposez une conduite à tenir »	Des actions concrètes, ordonnées, réalistes (qui, quoi, quand)
« Rédigez » (un courrier, une note, une réponse)	Un texte prêt à l'emploi, adapté au destinataire, poli et clair

Exemple – Un paragraphe d'enjeu bien construit

« **Droit à l'image** : le document 3 indique que les photos de l'atelier seront publiées sur le compte du centre social. Or seuls 9 participants sur 14 ont signé une autorisation, soit 64,3 %. Publier des photos où l'on reconnaît les autres porterait atteinte à leur vie privée (article 9 du Code civil). Il faut donc ne publier que des photos des personnes qui ont autorisé ce support, ou des photos de mains et de plats. »

Ce paragraphe nomme la notion, s'appuie sur un chiffre du document, calcule, cite le texte, et propose une solution.

Méthode 3 – Rédiger un courrier de refus de partenariat

1. Remercier pour la proposition.

2. Rappeler l'objectif du projet et ses principes (indépendance, absence de publicité, protection des données).

3. Énoncer le refus clairement, sans agressivité ni jugement sur l'entreprise.

4. Proposer éventuellement une alternative acceptable (soutien sans contrepartie, mécénat anonyme), si elle existe.

5. Formule de politesse adaptée.

Méthode 4 – Préparer l'oral : défendre la dimension éthique de son projet

Le jury peut demander : « Quelles précautions éthiques avez-vous prises ? » Préparez une réponse en six points, chacun illustré par un fait de votre projet : **confidentialité** (cadre énoncé, données agrégées), **données** (questionnaire anonyme, durée de conservation), **image** (autorisations, photos sans visage), **partenariat** (refus ou convention), **non-stigmatisation** (vocabulaire, absence de pesée), **participation** (choix des recettes avec le public). Ayez en tête un **dilemme vécu** et la façon dont vous l'avez résolu avec votre tuteur : c'est souvent la question qui fait la différence.

Méthode 5 – Quinze affirmations à corriger avant l'épreuve

Point d'étape – Vrai ou faux ? Justifiez chaque réponse en une phrase

1. Un questionnaire sans nom est toujours anonyme.
2. Le secret professionnel s'arrête quand la personne a elle-même parlé publiquement de sa situation.
3. Un stagiaire n'a pas à respecter la confidentialité, car il n'est pas encore professionnel.
4. Le consentement d'un salarié à une enquête demandée par son employeur est une base légale solide.
5. Un parent seul peut autoriser la diffusion de la photo de son enfant sur un réseau social.
6. Un lien d'intérêts est une faute professionnelle.
7. Un nudge interdit les choix défavorables à la santé.
8. Un aliment peut annoncer qu'il prévient le cancer s'il est riche en fibres.
9. Les compléments alimentaires sont autorisés comme des médicaments avant leur mise sur le marché.
10. Une évaluation de la satisfaction d'un atelier relève de la loi Jardé.
11. Une violation de données doit être notifiée à la CNIL dans les 72 heures, sauf absence de risque pour les personnes.

12. La nutrition artificielle est considérée comme un traitement par la loi.
13. Un tuteur peut imposer un régime alimentaire à une personne protégée capable d'exprimer ses choix.
14. Le titre de nutritionniste est protégé comme celui de diététicien.
15. Un professionnel de santé peut accepter un repas offert par un laboratoire pharmaceutique s'il assiste à une présentation de produits.

Corrigé – Vrai ou faux

1. Faux : le croisement de plusieurs informations (âge, classe, quartier) peut permettre d'identifier une personne, surtout dans un petit groupe.
2. Faux : le professionnel reste tenu au secret, même si la personne a parlé (exemple de l'avis en ligne).
3. Faux : il est tenu à la discrétion et à la confidentialité par sa convention de stage et la déontologie.
4. Faux : le salarié n'est pas vraiment libre de refuser ; on s'appuie sur une autre base légale.
5. Faux : l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale est nécessaire, et l'enfant est associé selon son âge.
6. Faux : c'est l'absence de déclaration et de gestion qui pose problème.
7. Faux : le nudge oriente sans rien interdire.
8. Faux : aucun aliment ne peut prétendre prévenir ou guérir une maladie, sauf allégation de réduction d'un risque autorisée au cas par cas.
9. Faux : ils sont déclarés, mais ne font pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché comme un médicament.
10. Faux : il s'agit d'une évaluation d'action, soumise au RGPD si des données personnelles sont recueillies.
11. Vrai : article 33 du RGPD.
12. Vrai : loi du 2 février 2016.
13. Faux : la personne protégée décide de sa vie personnelle dans la mesure où son état le permet.
14. Faux : seul le titre de diététicien (et celui de médecin nutritionniste) est protégé.
15. Faux : un avantage sans contrepartie professionnelle réelle est interdit par l'encadrement des avantages.

Mon score	Ce que je fais
13 à 15 sur 15	Je passe à l'entraînement de la partie 6.8.
9 à 12 sur 15	Je relis les parties correspondant à mes erreurs.
Moins de 9 sur 15	Je relis l'essentiel à retenir et les points d'étape avant l'entraînement.

Méthode 6 – Relier l'éthique aux autres chapitres du cours

Notion du chapitre 6	Chapitre lié	Ce qu'il faut relier
Justice, universalisme proportionné	Chapitre 2 (déterminants et inégalités sociales de santé)	Ne pas creuser les inégalités, cibler sans stigmatiser
Stigmatisation, culpabilisation	Chapitres 3 et 4 (représentations, comportements alimentaires)	Restriction cognitive, vocabulaire moral, préjugés
Information loyale, consentement éclairé	Chapitre 5 (littératie en santé)	Écrire clair, « faire dire », précautions universelles
Questionnaires, RGPD, petits effectifs	Chapitre 9 (évaluation)	Minimisation, anonymat, analyse des limites
Démarche de projet	Chapitres 1, 7 et 8 (santé publique, démarche de projet)	La dimension éthique accompagne chaque étape du projet

Notion du chapitre 6	Chapitre lié	Ce qu'il faut relier
Allégations, marketing	Chapitre 5 (lecture d'étiquettes)	Littératie critique face aux emballages
Sécurité des ateliers, TIAC	Chapitre 13 du volume 2 (hygiène et sécurité alimentaire)	Allergènes, chaîne du froid, déclaration à l'ARS

Méthode 7 – Savoir à qui s'adresser : les autorités et leurs rôles

Une question fréquente à l'épreuve est : « À qui signaler ? » ou « Quel organisme contrôle ? ». Le tableau suivant rassemble les principales autorités citées dans le chapitre.

Autorité	Statut	Rôle utile au diététicien	Exemple de saisine
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), créée en 1978	Autorité administrative indépendante	Conseille, contrôle et sanctionne en matière de données personnelles ; reçoit les notifications de violation et les plaintes	Une structure notifie la perte d'un fichier ; une personne se plaint d'une collecte abusive
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), avec les directions départementales de la protection des populations	Administration de l'État	Contrôle l'étiquetage, les allégations, la publicité, les pratiques commerciales trompeuses et l'influence commerciale	Signalement d'une allégation interdite (plateforme SignalConso)
Agence régionale de santé (ARS)	Établissement public de l'État	Pilote la santé publique en région ; reçoit les déclarations obligatoires (dont les TIAC) ; enregistre les diplômes des professionnels de santé	Déclaration d'une toxi-infection alimentaire collective
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses)	Établissement public	Évalue les risques ; publie les références nutritionnelles ; gère la nutrivigilance	Déclaration d'un effet indésirable lié à un complément alimentaire
Défenseur des droits, institué en 2011	Autorité constitutionnelle indépendante	Défend les droits des usagers des services publics, lutte contre les discriminations, défend les droits de l'enfant	Une famille estime que son enfant a été exclu de la cantine de façon discriminatoire
Cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CRIP)	Service du conseil départemental	Recueille et évalue les informations préoccupantes concernant les mineurs en danger ou en risque de l'être	Information préoccupante sur un enfant qui semble négligé
Procureur de la République	Magistrat	Reçoit les signalements de danger grave et immédiat et les plaintes pénales	Signalement d'un enfant victime de violences
Comité de protection des personnes (CPP)	Comité indépendant agréé	Rend un avis sur les recherches impliquant la personne humaine	Dépôt d'un protocole de recherche en nutrition

Définition – Sanction administrative et sanction pénale

Une **sanction administrative** est prononcée par une autorité administrative (amende de la CNIL, fermeture d'un établissement par le préfet après un contrôle d'hygiène). Une **sanction pénale** est prononcée par un tribunal pour une infraction prévue par la loi (contravention, délit ou crime) : amende pénale, emprisonnement. La violation du secret professionnel, l'usurpation de titre et la discrimination sont des

délits, jugés par le tribunal correctionnel.

À vous de jouer – Exercice d'application 6.35

Indiquez l'autorité à saisir dans chaque situation : a) un yaourt « brûleur de graisses » en rayon ; b) huit élèves malades après un pique-nique scolaire ; c) une association a publié en ligne le fichier nominatif des bénéficiaires de son épicerie ; d) une participante présente des palpitations après un complément « minceur » ; e) une personne en situation de handicap se voit refuser l'accès à un atelier cuisine.

Corrigé

a) DGCCRF (direction départementale de la protection des populations), par exemple via SignalConso. b) ARS : déclaration obligatoire d'une toxi-infection alimentaire collective, par le médecin ou le responsable. c) CNIL : notification de la violation par l'association dans les 72 heures ; les personnes concernées peuvent aussi porter plainte. d) Nutrivigilance de l'Anses, par un professionnel de santé, après orientation médicale. e) Défenseur des droits (discrimination fondée sur le handicap), et éventuellement plainte pénale.

6.7 L'essentiel à retenir

À retenir – Notions et principes

- **Morale** (valeurs) · **éthique** (réflexion face à une situation) · **déontologie** (devoirs professionnels) · **droit** (règles sanctionnées).
- **Quatre principes** (Beauchamp et Childress, 1979) : autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice.
- **Santé publique** (Childress, 2002) : efficacité, proportionnalité, nécessité, moindre atteinte, justification publique ; **échelle d'intervention** (Nuffield, 2007) ; **nudge** (Thaler et Sunstein, 2008) : transparence, réversibilité.
- **Non-stigmatisation** : parler de comportements et d'environnements, images respectueuses, pas de pesée en public, pas de vocabulaire moral.

À retenir – Règles

- Profession réglementée : **L. 4371-1 CSP** (inclut la prévention en santé publique) ; titre protégé ; enregistrement ; code de déontologie AFDN.
- **Secret** : L. 1110-4 CSP ; **226-13 Code pénal** (1 an, 15 000 €) ; données agrégées ; protection de l'enfance (CRIP, 119).
- **RGPD** (2016/679, 25 mai 2018) : licéité-transparence, finalité, minimisation, exactitude, conservation limitée, sécurité + responsabilité ; données de santé = catégorie particulière ; anonymiser ; sanction jusqu'à 20 M€ ou 4 % du CA (le plus élevé).
- **Image** : article 9 Code civil ; autorisation écrite, par support ; mineur : deux titulaires de l'autorité parentale.
- **Conflits d'intérêts** : repérer, déclarer, gérer ; Code OMS 1981 (substituts du lait maternel) ; loi du 29 décembre 2011 (Transparence Santé).
- **Démarche** : faits → règles → valeurs → options → décision justifiée et tracée.

À retenir – Compléments : droits, responsabilité, allégations, recherche, numérique

- **Droits** : DUDH art. 25 ; loi du 2 janvier 2002 (CVS, charte de la personne accueillie) ; loi du 4 mars 2002 ;

EGalim : précarité alimentaire, dignité, capacité à agir (L. 266-1 CASF) ; démocratie en santé.

- **Responsabilité** : civile (faute, dommage, lien ; assurance), pénale (infraction), disciplinaire ; TIAC = maladie à déclaration obligatoire ; stagiaire sous la responsabilité du tuteur (convention).
- **Allégations** (règlement 1924/2006) : source de fibres ≥ 3 g/100 g ; riche ≥ 6 g/100 g ; source de protéines ≥ 12 % de l'énergie ; allégé ≥ − 30 % ; contrôle par la DGCCRF.
- **Publicité** : messages sanitaires obligatoires (2004-2007) ; **compléments** : décret 2006-352, nutrivigilance (ANSES).
- **Enquêtes** : questionnaire d'évaluation hors loi Jardé ; RIPH : CPP ; MR-004 pour les études sur données existantes.
- **Numérique** : identité numérique, e-réputation ; IA : confidentialité, vérification, responsabilité, intégrité académique.

6.8 Entraînement

6.8.1 QCM (une ou plusieurs bonnes réponses)

QCM 1 – La déontologie :

a) rassemble les devoirs d'une profession **b)** est une réflexion philosophique générale **c)** est formalisée pour les diététiciens par un code porté par l'AFDN **d)** est toujours sanctionnée pénalement

QCM 2 – Les quatre principes de Beauchamp et Childress sont :

a) autonomie **b)** bienfaisance **c)** rentabilité **d)** justice

QCM 3 – Le principe de non-malfaisance en nutrition invite à :

a) éviter la stigmatisation du poids **b)** multiplier les pesées publiques **c)** éviter d'induire une restriction cognitive **d)** culpabiliser pour motiver

QCM 4 – Sur l'échelle d'intervention du Nuffield Council :

a) informer est peu intrusif **b)** la taxe sur les boissons sucrées est une désincitation **c)** l'interdiction des distributeurs dans les écoles restreint le choix **d)** plus l'intervention est intrusive, moins elle doit être justifiée

QCM 5 – Un nudge :

a) interdit certaines options **b)** modifie l'architecture du choix **c)** doit, pour être éthique, rester transparent et réversible **d)** a été popularisé par Thaler et Sunstein

QCM 6 – L'article L. 4371-1 du CSP :

a) définit la profession de diététicien **b)** mentionne les activités de prévention en santé publique **c)** crée un ordre des diététiciens **d)** concerne le secret médical uniquement

QCM 7 – La violation du secret professionnel est punie de :

a) 6 mois et 7 500 € **b)** 1 an et 15 000 € **c)** 5 ans et 75 000 € **d)** une simple amende

QCM 8 – Le RGPD :

a) est le règlement (UE) 2016/679 **b)** est applicable depuis le 25 mai 2018 **c)** ne concerne que les entreprises **d)** classe les données de santé en catégorie particulière

QCM 9 – Le principe de minimisation signifie :

a) collecter le moins de personnes possible **b)** collecter seulement les données nécessaires à la finalité **c)** réduire la taille des fichiers **d)** supprimer les questions sans rapport avec l'objectif

QCM 10 – Des données pseudonymisées :

a) sont des données anonymes **b)** restent des données personnelles **c)** peuvent être réidentifiées avec une clé **d)** échappent au RGPD

QCM 11 – Pour photographier un enfant de 8 ans lors d'un atelier :

a) l'accord oral de l'animateur suffit **b)** il faut l'autorisation écrite des titulaires de l'autorité parentale **c)** il est conseillé de recueillir aussi l'avis de l'enfant **d)** aucune autorisation n'est nécessaire dans un lieu public

QCM 12 – Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel :

a) a été adopté par l'OMS en 1981 **b)** autorise la distribution d'échantillons aux parents **c)** encadre la promotion des laits infantiles **d)** concerne uniquement les hôpitaux

QCM 13 – Un conflit d'intérêts :

a) est toujours une faute **b)** peut exister même si le jugement n'est pas réellement influencé **c)** doit être déclaré et géré **d)** concerne uniquement les intérêts financiers

QCM 14 – Un participant confie en atelier qu'il est diabétique. Vous :

a) le signalez à la structure **b)** respectez la confidentialité **c)** pouvez lui proposer en privé une orientation **d)** l'annoncez au groupe pour adapter la recette

QCM 15 – Dans un service public, le stagiaire :

a) respecte un devoir de neutralité religieuse et politique **b)** peut promouvoir ses convictions **c)** respecte les pratiques religieuses des usagers **d)** impose un menu unique sans adaptation

> **Corrigé – Corrigé expliqué des QCM**
>
> **1. a, c**. 2. **a, b, d** (+ non-malfaisance). 3. **a, c**. 4. **a, b, c** (d est faux : la justification doit croître). 5. **b, c, d**. 6. **a, b**. 7. **b** (article 226-13 du Code pénal). 8. **a, b, d**. 9. **b, d**. 10. **b, c**. 11. **b, c**. 12. **a, c**. 13. **b, c**. 14. **b, c** (on peut adapter la recette sans désigner la personne). 15. **a, c**.

QCM 16 – Le conseil de la vie sociale :

a) existe dans les établissements sociaux et médico-sociaux **b)** associe résidents, familles et personnel **c)** a été créé par la loi du 2 janvier 2002 **d)** remplace le médecin coordonnateur

QCM 17 – Une toxi-infection alimentaire collective :

a) concerne au moins deux cas groupés liés à une même origine alimentaire **b)** est une maladie à déclaration obligatoire **c)** se déclare à l'ARS **d)** ne concerne que les restaurants

QCM 18 – L'allégation « riche en fibres » suppose au moins :

a) 3 g de fibres pour 100 g **b)** 6 g de fibres pour 100 g **c)** 3 g de fibres pour 100 kcal **d)** 1,5 g de fibres pour 100 kcal

QCM 19 – La responsabilité civile :

a) oblige à réparer un dommage **b)** suppose une faute, un dommage et un lien de causalité **c)** est couverte par une assurance **d)** entraîne une peine de prison

QCM 20 – La méthodologie de référence MR-004 de la CNIL concerne :

a) les recherches n'impliquant pas la personne humaine **b)** les études et évaluations à partir de données existantes **c)** les essais de médicaments **d)** les sites internet

> **Corrigé – Corrigé expliqué des QCM complémentaires**
>
> **16. a, b, c**. 17. **a, b, c**. 18. **b, c** (l'une ou l'autre condition). 19. **a, b, c**. 20. **a, b**.

6.8.2 Exercices

À vous de jouer – Exercice 1 – Schéma à légender : les quatre principes

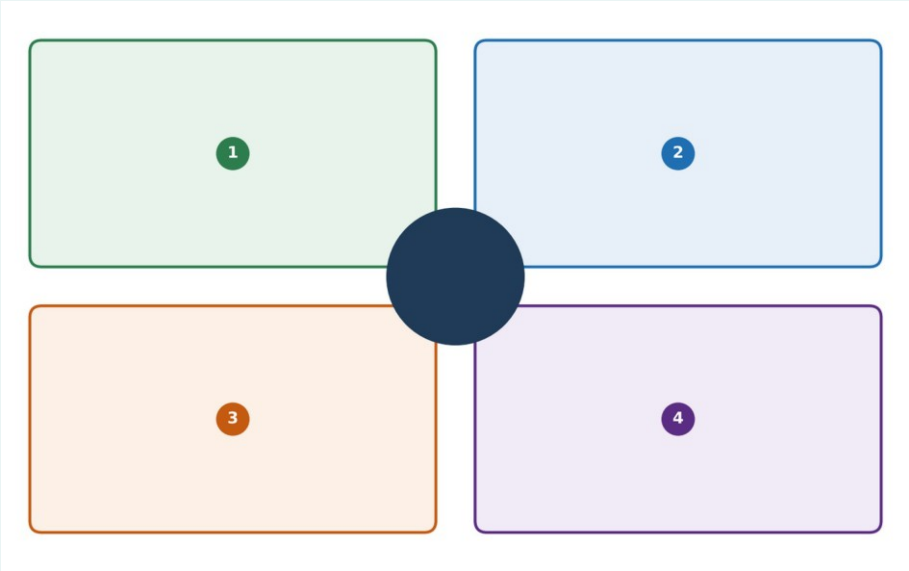


Figure 6.6 – Schéma à légender

Légendez les principes 1 à 4 et illustrez chacun par un exemple tiré d'un atelier culinaire.

Corrigé

1. Autonomie : chacun choisit de goûter ou non, de participer ou non. 2. **Bienfaisance** : recettes fondées sur les repères, utiles au budget. 3. **Non-malfaisance** : pas de commentaires sur le poids, vérification des allergies. 4. **Justice** : atelier gratuit, horaires compatibles avec les contraintes des familles, priorité au quartier prioritaire.

À vous de jouer – Exercice 2 – Schéma à légender : l'échelle d'intervention

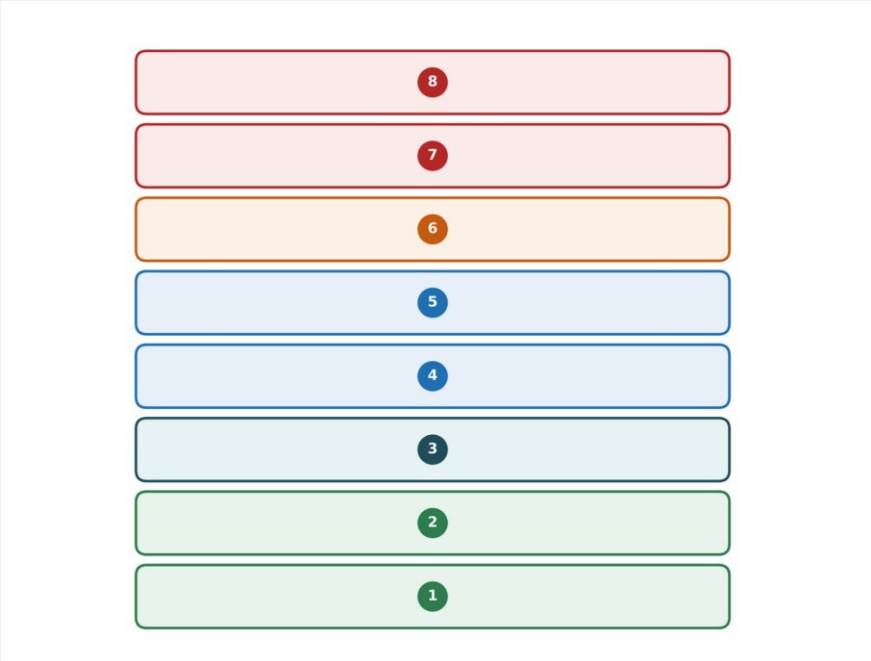


Figure 6.7 – Schéma à légender

Nommez les échelons 1 à 8 et placez les mesures suivantes : a) eau servie en carafe au restaurant scolaire ; b)

chèques « fruits et légumes » ; c) campagne d'affichage ; d) interdiction de la publicité pour les produits gras-sucrés-salés pendant les programmes jeunesse (proposition).

Corrigé

1. Ne rien faire ou surveiller. 2. Informer, éduquer. 3. Faciliter les choix. 4. Orienter par défaut. 5. Inciter. 6. Désinciter. 7. Restreindre les choix. 8. Éliminer le choix. Placement : a) **4** ; b) **5** ; c) **2** ; d) **7**.

À vous de jouer – Exercice 3 – Schéma à légender : le RGPD

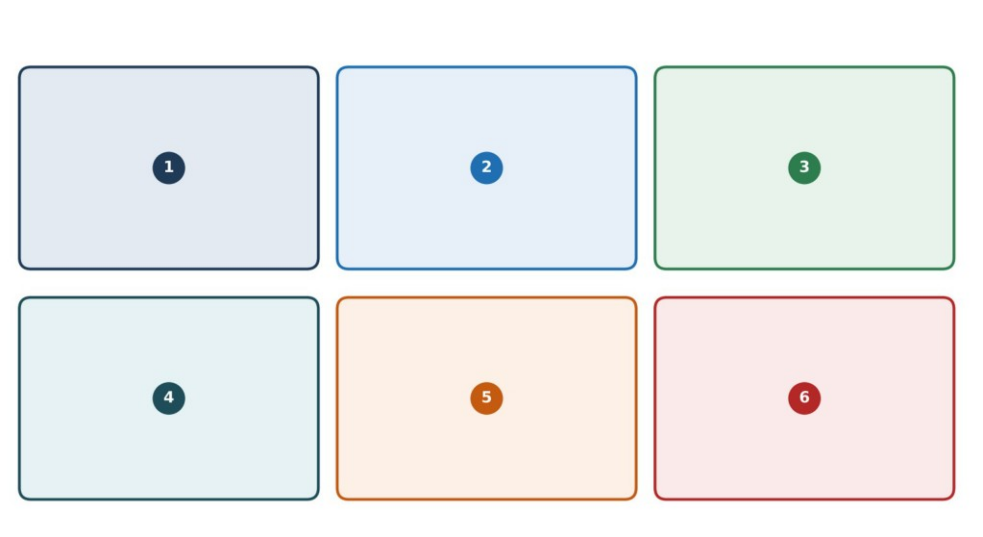


Figure 6.8 – Schéma à légender

Légendez les principes 1 à 6 et, pour chacun, indiquez une mesure concrète pour un questionnaire d'évaluation d'atelier.

Corrigé

1. Licéité, loyauté, transparence : mention d'information en tête. 2. **Finalité** : servir uniquement à évaluer l'atelier. 3. **Minimisation** : pas de nom, âge en tranches. 4. **Exactitude** : saisie vérifiée par double contrôle.

5. Conservation limitée : suppression à une date fixée. 6. **Intégrité et confidentialité** : fichier protégé, questionnaires détruits après saisie.

À vous de jouer – Exercice 4 – Minimiser un questionnaire

Un questionnaire d'évaluation d'atelier demande : nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone, poids, taille, nombre d'enfants, satisfaction, recettes refaites. Supprimez les données inutiles et justifiez.

Corrigé

À supprimer : **nom, prénom, adresse, téléphone** (identifiants inutiles pour évaluer ; si un recontact est souhaité, liste séparée, facultative, avec consentement) ; **date de naissance** (remplacer par une tranche d'âge si utile) ; **poids et taille** (données de santé non nécessaires à l'évaluation d'un atelier, et stigmatisantes). À conserver : nombre d'enfants (si utile pour l'analyse), satisfaction, recettes refaites. Principe : **minimisation** et respect de la catégorie particulière des données de santé.

À vous de jouer – Exercice 5 – Calcul : taux d'autorisations

Sur 18 participants adultes, 13 ont signé l'autorisation de droit à l'image pour le dossier, 6 pour les réseaux sociaux. Sur 22 enfants, 9 autorisations sont signées par les deux parents et 4 par un seul parent. Calculez les taux et indiquez qui vous pouvez photographier pour chaque support.

Corrigé

Adultes, dossier : 13 / 18 × 100 = **72,2 %** ; réseaux sociaux : 6 / 18 × 100 = **33,3 %**. Enfants, autorisation complète : 9 / 22 × 100 = **40,9 %** ; autorisations incomplètes : 4 / 22 × 100 = **18,2 %** (à compléter avant utilisation, par prudence). On ne publie sur les réseaux que les 6 adultes concernés ; pour les enfants, uniquement les 9 autorisés, sinon photos sans visage.

À vous de jouer – Exercice 6 – Rédiger une mention d'information

Rédigez la mention d'information d'un questionnaire de diagnostic distribué à la sortie d'une école.

Corrigé

« Ce questionnaire est **anonyme** et **facultatif**. Il est réalisé par [prénom], étudiante en BTS Diététique et nutrition, en stage au centre social [nom], pour connaître les habitudes et les besoins des familles et construire des ateliers adaptés. Les réponses seront saisies puis les questionnaires détruits. Les résultats seront présentés de façon globale (aucune réponse individuelle). Le fichier sera supprimé le [date]. Questions : [contact de la référente]. Merci ! »

À vous de jouer – Exercice 7 – Analyser un partenariat

Une enseigne de restauration rapide propose 800 € pour financer un cycle d'ateliers « cuisine maison » si son logo figure sur les supports et si un bon de réduction est remis aux participants. Analysez et proposez une réponse.

Corrigé

Analyse : intérêt secondaire commercial en contradiction avec l'objectif (cuisine maison) ; bon de réduction = promotion directe auprès d'un public vulnérable ; risque de perte de crédibilité. **Réponse** : refuser les contreparties ; si l'entreprise accepte un mécénat sans logo ni bon, sans influence sur le contenu, convention écrite et mention transparente, la décision revient à la direction ; sinon, solliciter d'autres financeurs (CAF, ARS, collectivité, fondation).

À vous de jouer – Exercice 8 – Calcul de sanction et de date

a) Calculez le plafond d'amende RGPD pour une entreprise réalisant 650 M€ de chiffre d'affaires mondial. b) Des données recueillies le 12 octobre 2027 doivent être conservées 18 mois : à quelle date les supprimer ?

Corrigé

a) 4 % × 650 = 0,04 × 650 = **26 M€** ; 26 M€ > 20 M€ → plafond : **26 M€** (le plus élevé des deux). b) 12 octobre 2027 + 12 mois = 12 octobre 2028 ; + 6 mois = **12 avril 2029**.

À vous de jouer – Exercice 9 – Réécrire un message stigmatisant

Réécrivez l'accroche suivante : « Vos enfants sont trop gros ? Venez apprendre à les mettre au régime ! »

Corrigé

« Des goûters bons, simples et pas chers : venez cuisiner avec vos enfants ! » Le nouveau message parle de plaisir, de famille et de budget, ne cible pas le poids, ne propose pas de régime (non-malfaisance : risque de restriction chez l'enfant) et n'exclut personne.

À vous de jouer – Exercice 10 – Dilemme : la participante qui ne veut plus venir

Une participante a manqué trois ateliers ; la référente vous demande de l'appeler pour « la remettre dans le droit chemin », car son assiduité conditionne une aide du CCAS. Analysez avec la grille en 5 étapes.

Corrigé

Faits : absences ; lien entre participation et aide (conditionnalité). **Règles** : participation libre à une action de santé ; secret ; règlement du CCAS à vérifier. **Valeurs** : autonomie (liberté de participer) contre bienfaisance (maintenir le lien, l'aide) et justice (ne pas pénaliser une personne en difficulté). **Options** : a) appeler pour rappeler l'obligation (contrainte) ; b) ne rien faire ; c) appeler pour prendre des nouvelles, comprendre les obstacles (horaires, enfants, santé) et proposer des adaptations, en rappelant que la participation est libre ; signaler à la référente le problème éthique de la conditionnalité. **Décision** : option c, discutée avec la tutrice et tracée.

6.8.3 Questions de réflexion

À vous de jouer – Question 1

Une taxe sur les boissons sucrées est-elle éthiquement justifiable ?

Corrigé

On peut la justifier par l'**efficacité** (baisse des teneurs en sucre par reformulation après 2018, baisse des achats), la **gravité** du problème (obésité, caries, diabète), la **proportionnalité** (le choix reste possible) et la **justice** si les recettes financent la prévention ou l'accès à l'eau. Les objections sont la **régressivité** (elle pèse davantage, en proportion du revenu, sur les ménages modestes) et le paternalisme. La réponse dépend de la conception et de l'accompagnement de la mesure.

À vous de jouer – Question 2

Peut-on mener une action efficace sans parler du poids ?

Corrigé

Oui : les comportements (alimentation, activité physique, sommeil) et les environnements améliorent la santé indépendamment du poids, et les approches centrées sur le poids risquent la stigmatisation et la restriction. On peut évaluer des indicateurs de comportements, de compétences et de bien-être. Le suivi du poids relève, si nécessaire, du soin individuel.

À vous de jouer – Question 3

L'éthique est-elle une affaire de règles ?

Corrigé

Les règles (droit, déontologie) sont nécessaires mais ne suffisent pas : elles ne prévoient pas toutes les situations et peuvent entrer en conflit. L'éthique est une **démarche** de réflexion, de délibération collective et de justification, qui s'appuie sur les règles mais cherche la conduite la plus juste dans chaque cas.

6.8.4 Étude de cas

Mise en situation – Étude de cas – Le défi « 10 000 pas » dans une entreprise

Une entreprise de 400 salariés lance un défi « 10 000 pas et zéro sucre » pendant un mois, avec classement nominatif affiché à la cafétéria, pesée volontaire au début et à la fin, et une application qui recueille les pas et les repas. Le service RH vous demande d'animer la partie alimentation.

1. Identifiez les enjeux éthiques (principes en tension).
2. Analysez la conformité au RGPD.
3. Quels risques pour la santé des salariés ?
4. Proposez une version éthique du projet.
5. Comment évaluer sans données individuelles de santé ?

Corrigé

1. Autonomie : volontariat réel dans un cadre hiérarchique ? Pression sociale du classement. **Non-malfaisance** : stigmatisation des moins performants, « zéro sucre » qui favorise la restriction. **Justice** : salariés en situation de handicap, de travail posté, exclus. **Bienfaisance** : promotion de l'activité physique, légitime.

2. Les pas, le poids et les repas sont des données personnelles, et le poids une donnée de santé ; l'employeur ne doit pas y accéder nominativement ; base légale, information, minimisation, durée, sécurité de l'application, analyse d'impact (AIPD) probablement nécessaire ; le consentement donné à l'employeur est fragile (lien de subordination).
3. Restriction cognitive, culpabilité, TCA chez des personnes vulnérables, blessures, stigmatisation, atteinte au climat de travail.
4. Défi **collectif** par équipes, sans classement nominatif ni pesée, objectifs adaptables à chacun ; ateliers « collations plaisir » et « eau au bureau » ; amélioration de l'environnement (fruits à la cafétéria, fontaines, escaliers mis en valeur) ; application facultative gérée par un tiers, données agrégées seulement.
5. Questionnaires anonymes avant/après (fréquence de consommation de boissons sucrées, satisfaction, ressenti), participation par équipe, consommation d'eau et de fruits à la cafétéria (ventes).

6.8.5 Mises en situation express

Mise en situation – MSE 1

Le jury : « Quelle différence entre éthique et déontologie ? »

Corrigé

La déontologie est l'ensemble des devoirs d'une profession, formalisés dans un code ; l'éthique est une réflexion sur les valeurs, face à une situation, pour décider de la conduite la plus juste, surtout quand les

règles ne suffisent pas ou se contredisent.

Mise en situation – MSE 2

Votre tutrice vous demande d'envoyer la liste des participants avec leurs pathologies sur votre messagerie personnelle pour que vous « travailliez le week-end ».

Corrigé

Je refuse poliment en expliquant les règles du RGPD (sécurité, données de santé) ; je propose de travailler sur des données anonymisées ou sur le poste sécurisé de la structure.

Mise en situation – MSE 3

Une mère veut filmer l'atelier pour sa page Facebook.

Corrigé

Je lui explique que d'autres personnes ont le droit de refuser d'être filmées ; je propose qu'elle filme uniquement son enfant (avec l'accord de l'autre parent si nécessaire) ou les plats, ou d'utiliser les photos autorisées par le centre social.

Mise en situation – MSE 4

Le jury : « Avez-vous rencontré un problème éthique pendant votre stage ? »

Corrigé

Je présente un exemple précis avec la démarche en 5 étapes : les faits, les règles, les valeurs en tension, les options envisagées et la décision prise avec ma tutrice, puis ce que j'en ai appris.

Mise en situation – MSE 5

Un laboratoire de compléments alimentaires vous propose d'animer un stand rémunéré lors de votre action.

Corrigé

Je refuse : conflit d'intérêts manifeste et risque de promotion commerciale auprès du public ; je rappelle l'indépendance de l'action et j'en informe ma tutrice.

Mise en situation – MSE 6

Un enfant vous dit pendant l'atelier qu'il « n'a pas mangé depuis hier » et semble inquiet.

Corrigé

Je lui propose discrètement à manger, je reste bienveillant(e), et j'en parle sans délai à la référente de la structure ; si la situation fait craindre un danger, la structure transmet une information préoccupante (CRIP) ; je ne mène pas d'enquête seul(e).

Mise en situation – MSE 7

Le jury : « Votre questionnaire était-il conforme au RGPD ? »

Corrigé

Oui : anonyme, facultatif, avec mention d'information, données minimisées (pas de poids ni de nom), finalité unique, questionnaires détruits après saisie, fichier protégé et date de suppression fixée.

Mise en situation – MSE 8

Une élue souhaite afficher les résultats de pesée des écoles par classe.

Corrigé

J'explique les risques de stigmatisation et la nature de données de santé ; je propose de présenter des données agrégées à l'échelle de la commune, issues de sources officielles, et de communiquer sur les actions plutôt que sur les corpulences.

Mise en situation – MSE 9

Le jury : « Qu'est-ce qu'un nudge ? Est-ce éthique ? »

Corrigé

C'est une modification de l'architecture du choix qui oriente sans interdire (fruits mis en avant au self). Il peut être éthique s'il est transparent, réversible, au service de la santé et équitable.

Mise en situation – MSE 10

Une participante demande votre numéro personnel pour vous poser des questions.

Corrigé

Je reste dans un cadre professionnel : je donne les coordonnées de la structure et les horaires où je suis joignable, et je l'oriente vers une consultation si ses questions sont individuelles.

Mise en situation – MSE 11

Le jury : « Que risque un professionnel qui viole le secret ? »

Corrigé

Un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende (article 226-13 du Code pénal), en plus des sanctions disciplinaires de son employeur et de la responsabilité civile.

Mise en situation – MSE 12

Une collègue utilise l'expression « les obèses du quartier » dans un compte rendu.

Corrigé

Je lui propose discrètement une formulation centrée sur les personnes et les déterminants (« les habitants concernés par le surpoids », « les familles du quartier ») en expliquant l'enjeu de stigmatisation.

6.8.6 Exercices complémentaires

À vous de jouer – Exercice 11 – Vérifier des allégations

Pour 100 g : pain de mie A : 270 kcal, fibres 3,4 g, protéines 8 g ; barre de céréales B : 410 kcal, fibres 6,5 g, protéines 6 g ; fromage blanc C : 75 kcal, protéines 7,5 g. Quelles allégations « fibres » et « protéines » sont possibles ?

Corrigé

A : fibres 3,4 g ≥ 3 g → « **source de fibres** » (pas « riche » : 3,4 < 6 ; 3,4 / 270 × 100 = 1,26 g pour 100 kcal < 3) ; protéines : 8 × 4 = 32 kcal ; 32 / 270 × 100 = **11,9 %** < 12 % → aucune allégation. B : fibres 6,5 ≥ 6 → « **riche en fibres** » ; protéines 6 × 4 / 410 × 100 = **5,9 %** → aucune. C : protéines 7,5 × 4 = 30 kcal ; 30 / 75 × 100 = **40 %** ≥ 20 % → « **riche en protéines** ».

À vous de jouer – Exercice 12 – Gérer un incident

Lors d'un atelier, deux participants présentent des troubles digestifs le lendemain d'une dégustation de mayonnaise maison. Décrivez la conduite à tenir.

Corrigé

Recenser les personnes malades et les symptômes (sans divulguer les noms), informer la structure et le médecin le cas échéant ; s'il s'agit d'au moins deux cas liés au même repas : suspicion de **TIAC**, déclaration à l'ARS par le médecin ou le responsable ; conserver les restes et noter les lots des produits (traçabilité) ; analyser les pratiques (œufs crus, conservation) ; ajuster les recettes (mayonnaise aux œufs pasteurisés ou consommation immédiate, chaîne du froid).

À vous de jouer – Exercice 13 – Classer des enquêtes

Indiquez le cadre applicable : a) questionnaire anonyme de satisfaction après des ateliers ; b) étude comparant la glycémie de 40 patients selon deux petits-déjeuners, en vue d'une publication ; c) analyse des dossiers diététiques d'un service hospitalier pour un mémoire ; d) questionnaire nominatif sur le poids des salariés d'une entreprise.

Corrigé

a) Hors loi Jardé ; RGPD allégé si anonyme (mention d'information). b) **RIPH** (intervention, prélèvements) : avis d'un CPP, consentement. c) Étude sur données existantes : **MR-004** ou autorisation, information des patients, accord de l'établissement. d) À **refuser ou revoir** : données de santé nominatives sans finalité légitime ni garanties ; risque de discrimination ; anonymiser et justifier ou supprimer (chapitre 6).

À vous de jouer – Exercice 14 – Dignité et aide alimentaire

Une association distribue des colis identiques et demande aux bénéficiaires de suivre un « cours de cuisine obligatoire » pour recevoir le colis. Analysez au regard de l'article L. 266-1 du CASF et proposez une

alternative.

Corrigé

La conditionnalité porte atteinte à la **liberté** et à la **dignité** ; les colis identiques ne respectent pas le **choix**. Alternative : épicerie solidaire avec choix des produits, atelier proposé librement, conçu avec les bénéficiaires, valorisant leurs savoir-faire ; participation à la gouvernance (comité de bénéficiaires).

À vous de jouer – Exercice 15 – Identité numérique

Une étudiante en stage publie sur son compte personnel une photo de la cuisine pédagogique avec le texte « Atelier avec les familles du quartier difficile des Tilleuls ». Analysez et réécrivez.

Corrigé

Problèmes : stigmatisation du quartier et des familles, risque d'identification indirecte, atteinte à l'image de la structure, absence d'accord de la structure. Correction : ne rien publier sur son compte personnel ; si la structure le souhaite, publication sur son compte officiel : « Atelier cuisine au centre social : merci aux familles pour ce parmentier de lentilles ! » avec une photo de plats, après validation.

6.9 Glossaire

Terme	Définition
Anonymisation	Traitement rendant impossible, de façon irréversible, toute réidentification
Autonomie	Principe de respect des choix éclairés des personnes
Bienfaisance	Principe d'action pour le bien des personnes
CNIL	Commission nationale de l'informatique et des libertés, autorité de contrôle
Conflit d'intérêts	Intérêt secondaire susceptible d'influencer le jugement professionnel
Consentement	Accord libre et éclairé d'une personne, révocable
Déontologie	Ensemble des devoirs d'une profession
Donnée de santé	Donnée personnelle relative à la santé ; catégorie particulière (art. 9 RGPD)
Donnée personnelle	Information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable
Droit à l'image	Droit de s'opposer à la prise et à la diffusion de son image (art. 9 Code civil)
Échelle d'intervention	Classement des interventions selon leur degré d'intrusion (Nuffield, 2007)
Éthique	Réflexion critique sur les valeurs face à une situation
Justice	Principe d'équité dans la répartition des ressources
Minimisation	Collecte des seules données nécessaires
Non-malfaisance	Principe de ne pas nuire
Nudge	Modification de l'architecture du choix sans interdiction
Pseudonymisation	Remplacement des identifiants par un code ; les données restent personnelles
RGPD	Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données, applicable depuis le 25 mai 2018

Terme	Définition
Secret professionnel	Obligation de ne pas révéler les informations connues dans l'exercice professionnel
Stigmatisation	Attribution d'une identité dévalorisée à une personne ou un groupe
Allégation nutritionnelle	Mention affirmant qu'une denrée a des propriétés nutritionnelles bénéfiques (règlement 1924/2006)
Complément alimentaire	Denrée en doses destinée à compléter l'alimentation normale (décret 2006-352)
Conseil de la vie sociale	Instance de participation des personnes accueillies en établissement social ou médico-social
Démocratie en santé	Participation des usagers et citoyens aux politiques de santé
E-réputation	Image d'une personne ou d'une organisation sur internet
Nutrivigilance	Dispositif de l'ANSES recueillant les effets indésirables liés aux compléments et denrées enrichies
Responsabilité civile	Obligation de réparer un dommage causé à autrui
Responsabilité pénale	Obligation de répondre d'une infraction devant la justice
TIAC	Toxi-infection alimentaire collective : au moins deux cas groupés de même origine alimentaire ; déclaration obligatoire

6.10 Renvois bibliographiques par notion

Notion	Références
Principes éthiques	[1] Beauchamp et Childress ; [2] Childress et coll. ; [3] Nuffield Council
Nudge, paternalisme	[4] Thaler et Sunstein
Profession, déontologie	[5] CSP L. 4371-1 ; [6] AFDN code de déontologie
Secret, droits	[7] CSP L. 1110-4 ; [8] Code pénal 226-13 ; [9] loi du 4 mars 2002
Données	[10] RGPD ; [11] CNIL
Image	[12] Code civil art. 9
Conflits d'intérêts	[13] OMS 1981 ; [14] loi du 29 décembre 2011 ; [15] loi du 9 juin 2023
Stigmatisation	[16] Puhl et Heuer
Justice	[17] Rawls ; [18] Sen

6.12 Bibliographie numérotée

1. Beauchamp T. L., Childress J. F. *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press, 1979 (8e éd. 2019) ; trad. fr. *Les principes de l'éthique biomédicale*, Les Belles Lettres, 2008.
2. Childress J. F., Faden R. R., Gaare R. D. et coll. « Public health ethics: mapping the terrain ». *Journal of Law, Medicine & Ethics*, 2002, 30 (2), p. 170-178.
3. Nuffield Council on Bioethics. *Public health: ethical issues*. Londres, 2007.
4. Thaler R. H., Sunstein C. R. *Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness*. Yale University Press, 2008.
5. Code de la santé publique, articles L. 4371-1 à L. 4372-2 (profession de diététicien), *legifrance.gouv.fr*.

6. Association française des diététiciens nutritionnistes (AFDN). *Charte de déontologie du diététicien-nutritionniste*, 1er janvier 2018, *afdn.org* (consulté le 26 octobre 2026).

7. Code de la santé publique, article L. 1110-4.

8. Code pénal, articles 226-1, 226-13 et 226-14.

9. Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

10. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD).

11. CNIL. Guides pratiques (« Le RGPD pour les associations », « Les durées de conservation »), *cnil.fr*.

12. Code civil, article 9.

13. OMS. *Code international de commercialisation des substituts du lait maternel*. Genève, 1981.

14. Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ; base *transparence.sante.gouv.fr*.

15. Loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux.

16. Puhl R. M., Heuer C. A. « Obesity stigma: important considerations for public health ». *American Journal of Public Health*, 2010, 100 (6), p. 1019-1028.

17. Rawls J. *Théorie de la justice*. Paris, Seuil, 1987 (éd. originale 1971).

18. Sen A. *L'idée de justice*. Paris, Flammarion, 2010.

19. Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine (loi Jardé).

20. Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie.

21. Code de l'action sociale et des familles, article L. 266-1 (lutte contre la précarité alimentaire), issu de la loi EGalim du 30 octobre 2018.

22. Code civil, articles 1240 et 1241.

23. Règlement (CE) n° 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

24. Décret n° 2007-263 du 27 février 2007 relatif aux messages sanitaires accompagnant les publicités alimentaires.

25. Décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ; ANSES, dispositif de nutrivigilance.

26. CNIL. Méthodologies de référence MR-001 à MR-004, *cnil.fr*.

27. Règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle.

28. Habermas J. *De l'éthique de la discussion*. Paris, Cerf, 1992.

Cours du CNED (contrôle de conformité, section 6.2.2)

29. CNED. *BTS Diététique – Environnement professionnel : les essentiels*, 2e année, module 1. Réf. 3-6124-AN-WT-00-21. Futuroscope : CNED, 2022.